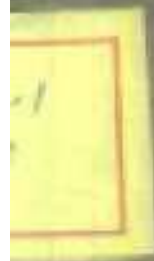


脉法解析



脉法解析

样 本 库

脉法解析

蒋泽霖 白玉珣 编著

陕西科学技术出版社



1154015



2k10/30-28

脉 法 解 折

蒋泽霖 白玉珣 编著

陕西科学技术出版社出版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 西安第二印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 5.375印张 100千字

1986年9月第1版 1986年9月第1次印刷

印数：1—8,000

统一书号：14202·151 定价：1.10元

610101

凡 例

一、本书将《伤寒论》辨脉法、平脉法二篇原文按脉法大纲、平脉与病脉、平脉辨证、平脉预后分章节加以解析。

二、辨脉法、平脉法原文以明代赵开美复刻宋本为准（依据南京中医学院伤寒教研组编著《伤寒论译释》，上海科学技术出版社，1980年10月第2版）。二篇条文共计78条，其中辨脉法34条，平脉法44条。为表明出处，在原文后分别用括弧标以“辨—×”及“平—×”加以注明。“辨”表示该条属辨脉法，其后为该条在辨脉法中的序码，“平”表示该条属平脉法，其后为该条在平脉法中的序码。

三、原文的断句和标点，根据笔者对原文的理解，在《伤寒论译释》的断句和标点基础上有所更动。但原文的文字，均按《伤寒论译释》的著录。

四、原文解析按如下体例：

〔原文〕按赵开美本的文字（依据《伤寒论译释》的著录）分条抄录，文后用括弧注出所属篇名和序码。原文次序则按类编体系加以编排，使其适应内容的逻辑关系。

〔校勘〕主要与成无己《注解伤寒论》（明：汪济川本，人民卫生出版社，1972年重印版）、《金匱玉函经》（清·陈世杰本，人民卫生出版社，1955年影印版）以及王

叔和《脉经》（明·袁表本，金山钱熙祚重校，商务印书馆，1954年重印版）等对照，以资参考。

〔词解〕包括字、词、句的音义和解释。

〔语译〕主要将原文顺译为现代汉语。

〔提要〕扼要地提示原文中心内容，以助领会原文精神。

〔释义〕主要针对原文阐发义理，以利加深对原文的理解。

〔讨论〕着重对原文进行一些必要的归纳、分析和阐释，或对原文所揭示的重要的脉学理论知识和实践经验进行一些初步研讨，以利古为今用，或供作进一步研究之参考。

〔参考〕主要摘录《内经》、《难经》与条文有关之说，以示脉法二篇与《内经》、《难经》脉学一脉相承的学术渊源关系，说明脉学理论之源流，以加深对原文的理论认识。

以上校勘、词解、讨论、参考等项根据具体条文而定，而非每条原文皆备。

五、本书引用的《伤寒论》条文，均依据成都中医学院主编的《伤寒论释义》（1964年版）的文字及序码。引用《内经》、《难经》的原文，依据《黄帝内经素问》（人民卫生出版社，1978年版）、《灵枢经》（商务印书馆，1955年校订重印版）、《难经译释》（南京中医学院医经教研组编著，上海科学技术出版社，1961年版）。

六、本书所引一些注家之说，均依据《伤寒论译释》，不再另注明出处。

绪 言

辨脉法、平脉法均见于宋本与成本《伤寒论》卷一，是《伤寒论》的脉学专篇。不少注家和学者认为，此二篇非仲景之文，乃王叔和所纂言。如错简派之代表方有执认为，辨脉法、平脉法、伤寒例以及诸可与不可篇，都是王叔和“述仲景之言，附己意以为赞经之辞”。喻嘉言认为，辨脉法是仲景原著，平脉法是叔和之言。也有学者认为，二篇均为仲景之著。但有的学者以《金匱玉函經》无平脉法，认为该篇可能是唐宋间人搜集当时所见的仲景之论脉遗文，汇集为“平脉法”而补入论中的。考叔和与仲景相去不远，该两篇即使出自王叔和之手，亦不能说不是仲景脉学的体现，因此不失为研究仲景脉学的重要文献。

关于对辨脉法、平脉法二篇的篇名与分合的认识，注家和学者的意见也不一致。如方有执认为，“辨脉”是辨别脉象，“平脉”是指正常脉象，该二篇原来就是辨脉法一篇，而一分为二乃王叔和及后人所为。魏荔彤则认为，“辨”与“平”二者意思不同，并非后人随意划分为二，“辨者分别之也，平者较量之也，平如平章之平，非平人之脉……辨者始条理也，分为二，推至于无穷也。平者终

条理也，衡如一，究归于不二也。”如此观之，似尚有进一步考证的必要。从字义来看，“平”有平静、和平之义；且“平”通“辨”，有辨识、诊察之义。故“平脉”的涵义有二：其一，指平人之脉，如《素问》平人气象论所说：“平人者，不病也……春胃微弦曰平……”《难经》十四难说：“脉来一呼再至，一吸再至，不大不小曰平”等均属其例，本书第二章所称“平脉”亦指此义；其二，指诊脉，如《伤寒论》自序所说：“撰用《素问》……并平脉辨证”及平脉法篇名等所言之“平脉”即指诊脉，本书第一章之“平脉总则”、第三章所名之“平脉辨证”、第四章所名之“平脉预后”等所说的“平脉”，亦指诊脉而言。因此说辨脉法与平脉法二篇的命名涵义，并无很大区别。从辨脉法和平脉法二篇原文来看，内容是很相近的，都是论述如何辨识脉象并推断病情。如果要区分一下，辨脉法主要是一般地论述脉象和病证的关系，而平脉法除此之外还论述了一些实际的诊脉方法。

综观辨脉法、平脉法二篇的基本内容，大致可以归纳为四个方面：其一，脉诊基本知识，如脉诊的理论基础，诊脉的方法，注意事项，以及四诊合参的意义等；其二，平脉与病脉，包括一些主要病脉的脉象、机理及主病等；其三，平脉辨证，这是脉法二篇的主要内容，主要论述如何辨识脉象并推断病情；其四，平脉预后，主要论述了一些平脉预后的基本原则及脉象。从这些内容来看，可以说已初具脉学规范，并且都出自丰富的临床实践，是十分宝贵的。仲景的

脉学，师承于《内经》和《难经》，并有创造性地发展。如从仲景的诊脉方法来看，也正体现了这一点。在当时《难经》独取寸口的诊脉方法逐渐盛行，但还未完全抛弃《内经》的遍诊法。仲景对《内经》遍诊法进行了简化，提出“人迎、寸口、趺阳”三部诊法，加上少阴脉以候肾，与独取寸口诊法并用。如他在《伤寒论》自序中说：“观今之医，……按寸不及尺，握手不及足，人迎、趺阳三部不参”，可资为证。然而，在实际运用上，仲景以独取寸口诊法为主，《伤寒论》中以寸口脉象的论述为多且详，脉法二篇亦然。仲景独取寸口诊法，以寸脉主阳、主表、主气，候上焦病；关脉主阴阳出入、主中，候中焦病；尺脉主阴、主里、主血，候下焦病。正如平脉法第1条所说：“审察表里，三焦别焉。知其所舍，消息诊看”。如此将脉象与脏腑经络、营卫气血联系起来进行辨证，即所谓“平脉辨证”，阐明了脉象的病理生理基础和辨证论治意义，体现了整体观念。论中寸口“三部九候”脉位，有时又以阴阳名之，如：寸为阳，尺为阴；浮为阳，沉为阴。辨脉法和平脉法二篇，还对诊脉部位、指力、调息，以及何谓“平脉”、脉象四时变化、诊脉肥瘦之异、四诊合参等，作了具体论述。《伤寒论》自序说：“动数发息不满五十，短期未知决诊，九候曾无仿佛，……所谓窥管而已。”充分反映了仲景诊脉严肃认真的科学态度，及对病人高度负责的人道精神。

辨脉法、平脉法二篇，为后世脉学树立了典范，直接为王叔和撰写《脉经》奠定了基础，从而开拓了中医脉学发展

的广阔道路。脉法二篇虽是汉代的脉学，但其中不少的内容至今还为中医所习用。因此，学习二篇不仅具有一定的理论意义，还有一定的现实指导意义。学习脉法二篇，可以加深对《内经》、《难经》脉学理论的认识，以穷脉学理论之源。《伤寒论》16条曰“观其脉证，知犯何逆，随证治之”，规定了辨证论治的原则精神。从脉法二篇可以比较具体地了解仲景是怎样“观其脉证”的，也就是如何凭脉以辨证的，这无疑对学习《伤寒论》辨脉证并治的精神有所裨益。同时，从脉法二篇中还可以吸取许多有益的宝贵经验，以为今用。当然也应当指出，由于时代的局限，脉法二篇中也存在一些机械的、形而上学的内容，加之从汉代流传至今，年代久远，誊鱼亥豕、脱落错简之处难免有之，因此舛错脱漏而不能解释之处在所难免，必须用发展的眼光，批判地加以对待。

目 录

绪 言

第一章 脉法大纲.....	(1)
一、平脉总则.....	(1)
二、诊脉方法.....	(17)
三、脉诊注意事项.....	(22)
(一) 脉应四时.....	(22)
(二) 脉因人异.....	(23)
(三) 脉随神变.....	(24)
(四) 脉有灾怪.....	(26)
四、四诊合参.....	(27)
第二章 平脉与病脉.....	(32)
一、平脉.....	(32)
二、脏腑脉.....	(36)
(一) 辨脏腑脉之胃气.....	(37)
(二) 五脏平脉、病脉及死脉.....	(39)
三、病脉.....	(46)
第三章 平脉辨证.....	(56)
一、寸口脉.....	(56)
(一) 诸脉概说.....	(56)

(二) 浮数脉.....	(86)
(三) 浮紧脉.....	(69)
(四) 浮大脉.....	(71)
(五) 浮迟脉.....	(82)
(六) 弱迟脉.....	(83)
(七) 弱缓脉.....	(85)
(八) 微缓脉.....	(86)
(九) 微涩脉.....	(89)
(十) 微弱脉.....	(95)
(十一) 寸脉与尺脉.....	(96)
二、趺阳脉.....	(111)
三、少阴脉.....	(122)
四、趺阳脉与少阴脉合参.....	(125)
第四章 平脉预后.....	(129)
一、预后总则.....	(129)
二、预后脉象.....	(136)
(一) 漉然汗出而解脉.....	(136)
(二) 战汗而解脉.....	(137)
(三) 不战而汗出得解脉.....	(139)
(四) 不战不汗出而解脉.....	(139)
(五) 欲解脉.....	(141)
(六) 死证脉.....	(147)
【附录】《伤寒论》脉象及主病表.....	(155)

第一章 脉法大纲

本章归纳了脉法二篇论述脉诊基本知识的条文，故命名“脉法大纲”。主要包括：脉诊理论基础，如脉象的生理和病理基础、独取寸口的理论依据、平脉和病脉的诊察要旨等；诊脉方法，如诊脉的部位、指力、调息等；诊脉注意事项，如脉应四时、脉因人异、脉随神变、脉有灾怪等；四诊合参示例。

一、平脉总则

本节计 3 条。论述了有关脉诊的基本理论法则，故冠以“平脉总则”。

〔原文〕问曰：脉有三部①，阴阳相乘②，荣卫血气，在人体躬③，呼吸出入，上下于中④，因息游布⑤，津液流通，随时动作，效象形容⑥，春弦秋浮，冬沉夏洪；察色观脉，大小不同，一时之间，变无经常，尺寸参差⑦，或短或长，上下乖错⑧，或存或亡，病辄⑨改易，进退低昂⑩，心迷意惑，动

失纪纲，愿为具陈，令得分明。师曰：子①之所问，道之根源，脉有三部，尺寸及关，荣卫流行，不失衡铨②，肾沉心洪，肺浮肝弦，此自经常，不失铢分③，出入升降，漏刻周旋④，水下百刻⑤，一周循环，当复寸口，虚实见焉；变化相乘，阴阳相干⑥，风则浮虚⑦，寒则牢坚⑧，沉潜水濡⑨，支饮急弦⑩，动则为痛⑪，数则热烦，设有不应，知变所缘⑫，三部不同，病各异端，大过可怪，不及亦燃，邪不空见，终必有奸⑬，审察表里，三焦别焉，知其所舍，消息⑭诊看，料度⑮腑脏，独见若神。为子条记，传与贤人。（平—1）

〔校勘〕“荣卫血气”，《脉经》作“荣卫气血”。

“愿为具陈”，《脉经》作“愿为缕陈”。“水下百刻”，《脉经》及成本皆作“水下二刻”。“一周循环”，《脉经》作“脉一周身”。“当复寸口”，《脉经》作“旋复寸口”。“寒则牢坚”，《脉经》作“寒则紧弦”。“水濡”，成本作“水畜”。“动则为痛”，《脉经》作“动弦为痛”。“数则热烦”，《脉经》作“数洪热烦”。“大过可怪”，《脉经》及成本皆作“太过可怪”。“终必有奸”，《脉经》及成本皆作“中必有奸”。

〔词解〕

①脉有三部：此指寸、关、尺三部。

②相乘：乘，乘袭。相互作用、影响。

③躬：身体。

④上下于中：上、下，谓气息升降于心肺与肝肾；呼出心与肺，吸入肝与肾。呼吸之间，脾受气于中。

⑤因息游布：靠气息运行，将精气输布于全身。

⑥效象形容：效，摹仿、仿效；此通“肖”，有相似之义。容，相貌、样子。效象形容，喻状态多种多样。

⑦尺寸参差：尺寸，概指寸、关、尺三部脉象。参差(cēncī)，长短不齐。

⑧上下乖错：上、下，此指寸、尺脉。乖(guāi)，不顺、不和谐。错，不符合。上下乖错，谓寸、尺脉错乱。

⑨辄(zhé)：犹“即”、就、便。

⑩进退低昂：指脉搏或快或慢，或高或低。

⑪子：此同“您”，是古代对对方的尊称。

⑫衡铨(héngquán)：衡量。此喻作法度。

⑬铢分：古代重量单位。10黍为1铢，6铢为1分。不失铢分，即不失分毫。此喻作不失正常法度。

⑭漏刻周旋：漏刻，古代计时用的水器，总以百刻分于昼夜，约合24小时。漏刻周旋，谓荣卫气血随昼夜时间的变化而运行不息，周而复始，与漏刻相应。

⑮水下百刻：即一昼夜的时间，约合24小时。

⑯相干：干，关连、干涉。相干，相互影响、相互为患。

⑰浮虚：浮缓脉之谓。

⑱牢坚：紧弦脉之谓。

⑭沉潜水滴：潜，伏藏。滴（xū），水聚曰滴。水滴，水积为饮，即水饮。沉脉按至筋骨乃得，故谓沉潜，主水积为饮。

⑮急弦：急脉，弦、紧脉之类。

⑯动：动脉。

⑰缘：原因。

⑱奸：此指邪乱之义。

⑲消息：斟酌之义。

⑳料度：料，预料。度（duó），揣度、推测。料度，此指细心诊察推断之义。

〔译译〕问：诊脉有三个部位，由于阴阳的相互作用，荣卫气血在人体内随呼吸而出入，气息升降于心肺与肝肾，脾受气于中，靠气息运行，将精气输布于全身，津液流通，故而脉之搏动不息，显现出多种多样的状态，如春弦、秋浮、冬沉、夏洪；诊察病人的气色和脉象，脉有大小不同，在一个时间内变化不定，尺寸之间的脉象不齐，或现短脉、或现长脉，上下错乱，脉搏或有或无，每随病情变化而改变，或快或慢、或高或低，令人心意迷惑，不得要领，愿请老师一一讲解，使我明白。老师答：你所问的，说到了医学中的根本问题，所谓脉有三部，就是寸、关、尺三部，若荣卫气血运行不失常度，则肾脉沉、心脉洪、肺脉浮、肝脉弦，这是五脏的正常脉象，不会有分毫差错，呼吸出入，气息升降，荣卫气血随昼夜时间的变化运行不息，周而复始，与漏刻相应，水下一百刻，循环一大周而复会于寸口，因此可依据寸口的

脉象诊察人体的虚实；若有病变影响，阴阳盛衰相干，就会出现各种病脉，如中风脉现浮虚，伤寒脉现牢坚，脉沉潜主水饮停蓄，支饮脉现急弦，动脉主痛，数脉主烦热，假设脉证不符，就要分析其变化的原因，寸、关、尺三部脉象不同，病变也就各异，脉现太过是病态，脉现不及亦是病态，邪气不是空无所见，终究必有邪乱的表现，细审其在表在里，还分别在三焦何部，以了解病变之所在，斟酌察看，细心诊察推断脏腑病情，就会有独到的见解，定能见病知源。今给你逐条记述于后，以传给德才兼备的人。

〔提要〕平脉总则。

〔释义〕脉搏是荣卫气血在经脉中的运行搏动。肺朝百脉，荣卫气血赖肺气的呼吸出入循环运行，靠气息运行将精气输布于全身，周流不息。故而脉随呼吸出入搏动不停，表现出各种形象，即所谓脉象。人身经脉总长计十六丈二尺，一息（肺一呼一吸）脉行六寸，一昼夜一万三千五百息，脉行八百四十丈，合五十度，为一大周，复会于寸口（《灵枢》五十营篇）。若失此常度，即太过与不及，皆为病脉。这是诊脉独取寸口的主要理论依据。寸口脉又分寸、关、尺三部，以辨表里、三焦、脏腑、阴阳。人与自然息息相通，故脉应四时而有序弦、夏洪、秋浮、冬沉的变化。人体为统一的整体，故脉亦应脏腑，而有肾脉沉、心脉洪、肺脉浮、肝脉弦等的不同。这些都是平脉。若有病，脉即随之发生变化，如中风脉浮缓、伤寒脉紧弦、脉沉伏主水饮停蓄、支饮脉急弦、动脉主痛、数脉主烦热等。有其病必有其

脉，但也有脉与证不符者，如此则当查明原因。总之，寸、关、尺三部脉象不同，其病亦异。邪气不是空无所见的，穷究其源必有所发现。应细审其表里、三焦病变之所在，细心诊察推断脏腑病情，即能做到见病知源。

〔讨论〕

1.原文分析：本条以问答形式，阐述了有关脉诊的一些理论法则。提问的内容大致可分为两段：“问曰：脉有三部……冬沉夏洪”为一段，其中心意思是说脉象的生理变化多样，有何规律可循，也就是询问平脉要旨如何；“察色观脉……令得分明”为一段，其中心意思是说脉象的病理变化复杂，有何诊察要领，也就是询问病脉要旨是什么。回答的内容主要就是针对这两个中心问题的，一问一答紧相呼应。回答指出：脉象的生理变化规律决定于荣卫气血的运行法度，所谓“出入升降，漏刻周旋，水下百刻，一周循环，当复寸口，虚实见焉”，不失此常度即为平脉，并指出脉应四时、五脏的正常变化亦属平脉；因病变影响，荣卫气血的运行失其常度，所谓太过与不及，即表现病脉，有其病则有其脉，亦有脉证不符者，则当详察原因，所谓“没有不应，知变所缘，三部不同，病各异端，大过可怪，不及亦然，邪不空见，终必有奸，审察表里，三焦别焉，知其所舍，消息诊看，料度脏腑，独见若神。”

2.本条揭示了以下问题：

(1)脉象的生理和病理基础：脉象是荣卫气血在经脉中运行而搏动的外部征象。因而荣卫气血在经脉中的运行状

况，是形成脉象的主要生理基础。如文中所说：“脉有三部，阴阳相乘，荣卫气血，在人体躬，呼吸出入，上下于中，因息游布，津液流通，随时动作，效象形容”，此“荣卫流行，不失衡铨”，故脉象有规律可循。若因病变影响，如文中所说“变化相乘，阴阳相干”，致荣卫气血的运行失其常度，所谓太过与不及，即表现病脉。

(2) 诊脉独取寸口的理论依据：仲景诊脉方法以《难经》独取寸口法为主，以《内经》遍诊法为辅；且对《内经》遍诊法进行了简化，提出人迎、寸口、趺阳（并加上少阴脉以候肾）三部诊法（实际只诊寸口、趺阳、少阴）。如文中说：“脉有三部，尺寸及关”。何以独取寸口？这在《内经》、《难经》均有明确的论述，仲景之说亦一脉相承。肺朝百脉，脉会太渊，太渊正当寸口，寸口又为脾胃之气所归，故全身脏腑、经脉、气血情况都可以在寸口上表现出来；五脏六腑之气失常，即变现于寸口，这是诊脉独取寸口的主要理论依据。如原文所说：“出入升降，漏刻周旋，水下百刻，一周循环，当复寸口，虚实见焉”。

(3) 平脉与病脉诊察要旨：平脉是荣卫气血在经脉中正常运行所表现的脉象，脉应四时、五脏的正常变化皆为平脉。所谓“春弦秋浮，冬沉夏洪”，以及“肾沉心洪，肺浮肝弦”，都是平脉。这些是脉象变化的生理规律的表现，所谓“此自经常，不失铢分”。对病脉的诊察，有其病必有其脉，但亦有脉证不符者，遇此当详察根由。凭脉以辨证，重在辨晰为何邪所犯，所犯何部，脏腑病情如何。如原文所

说：“设有不应，知变所缘，三部不同，病各异端，大过可怪，不及亦然；邪不空见，终必有奸，审察表里，三焦别焉，知其所舍，消息诊看，料度腑脏，独见若神。”

〔参考〕本条揭示了《内经》、《难经》脉诊之精要，兹摘《内经》、《难经》有关之说，以供参考：

1.脉的概念：《灵枢》决气篇说：“何谓脉？岐伯曰：壅遏营气，令无所避，是谓脉”。《素问》脉要精微论说：

“夫脉者，血之府也”。《灵枢》邪客篇说：“营气者，泌其津液，注之于脉，化以为血，以荣四末，内注五脏六腑，以应刻数焉”。《素问》痹论说：“荣者，水谷之精气也，和调于五藏，洒陈于六府，乃能入于脉也，故循脉上下，贯五藏，络六府也。”《灵枢》营卫生会篇说：“营在脉中，卫在脉外，营周不休，五十而复大会，阴阳相贯，如环无端”。

《素问》离合真邪论说：“真气者，经气也”。《素问》平人气象论说：“胃之大络，名曰虚里，贯膈络肺，出于左乳下，其动应衣，脉宗气也。”《灵枢》邪客篇说：“故宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心脉，而行呼吸焉。”《灵枢》刺节真邪篇说：“宗气不下，脉中之血，凝而留止”。

2.脉诊部位：《素问》三部九候论说：“帝曰：何谓三部？岐伯曰：有下部、有中部、有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人也”。《难经》十八难说：“脉有三部九候，各何主之？然：三部者，寸关尺也，九候者，浮中沉也。上部法天，主胸以上至头之有疾也；中部法人，主膈以下至脐之有疾也；下部法地，主脐以下至足之有疾也。”《难

经》二难说：“脉有尺寸，何谓也？然：尺寸者，脉之大要会也。从关至尺是尺内，阴之所治也；从关至鱼际是寸口内，阳之所治也。故分寸为尺，分尺为寸，故阴得尺内一寸，阳得寸内九分，尺寸终始一寸九分，故曰尺寸也”。

3.独取寸口的理论依据：《素问》经脉别论说：“食气入胃，散精于肝，淫气于筋。食气入胃，浊气归心，淫精于脉。脉气流经，经气归于肺，肺朝百脉，输精于皮毛。毛脉合精，行气于府。府精神明，留于四肢，气归于权衡。权衡以平，气口成寸，以决死生。”《素问》五藏别论说：“帝曰：气口何以独为五藏主？岐伯曰：胃者水谷之海，六府之大源也。五味入口，藏于胃以养五藏气。气口亦太阴也，是以五藏六府之气味，皆出于胃，变见于气口。”《灵枢》动输篇说：“胃为五藏六府之海，其清气上注于肺，肺气从太阴而行，其行也，以息往来，故人一呼脉再动，一吸脉亦再动，呼吸不已，故动而不止。”《灵枢》五十营篇说：“人经脉上下左右前后二十八脉，周身十六丈二尺，以应二十八宿，漏水下百刻，以分昼夜。故人一呼脉再动，气行三寸，一吸脉亦再动，气行三寸，呼吸定息，气行六寸”。《难经》一难说：“十二经皆有动脉，独取寸口，以决五脏六腑死生吉凶之法，何谓也？然：寸口者，脉之大会，手太阴之脉动也。人一呼脉行三寸，一吸脉行三寸，呼吸定息，脉行六寸，人一日一夜，凡一万三千五百息，脉行五十度，周于身，漏水下百刻，荣卫行阳二十五度，行阴亦二十五度，为一周也，故五十度复会于手太阴寸口者，五脏六腑之所终始，故法取

于寸口也。”

4. 脉诊要旨：《素问》金匱真言论说：“故善为脉者，谨察五脏六腑，一逆一从，阴阳、表里、雌雄之纪，藏之心意，合心于精，非其人勿教，非其真勿授，是谓得道。”《灵枢》终始篇说：“谨奉天道，请言终始，终始者，经脉为纪，持其脉口人迎，以知阴阳有余不足，平与不平，天道毕矣。”

〔原文〕寸口①卫气盛，名曰高②；荣气盛，名曰章③；高章相搏④，名曰纲⑤。卫气弱，名曰牎⑥；荣气弱，名曰卑⑦；牎卑相搏⑧，名曰损⑨。卫气和，名曰缓⑩；荣气和，名曰迟⑪；迟缓相搏⑫，名曰沉⑬。（平—22）

·〔词解〕

①寸口：此指寸、关、尺三部。

②高：高亢之义。言脉势能浮能升，气盛力强。《医宗金鉴》说：“脉随指有力上来，卫气盛也，谓之高……高者长盛也”。

③章：显著、分明之义。这里形容脉形充满。《医宗金鉴》说：“脉随指有力下去，荣气盛也，谓之章……章者分明也”。

④高章相搏：即高章相合。说明荣卫俱盛，脉象有余。

⑤纲：纲领之义。《医宗金鉴》说：“高章相合名曰纲，纲者以荣卫俱有余，有总挽之意也。”

⑥牎(dié)：怯弱之义。《医宗金鉴》说：“脉随指无力

上来，卫气弱也，谓之慄……慄者恍惚也”。

⑦卑：卑下、低微之义。此比喻脉象细小。《医宗金鉴》说：“脉随指无力下去，营气弱也，谓之卑……卑者缩下也。”

⑧慄卑相搏：即慄卑相合。说明荣卫俱弱，脉象不足。

⑨损：亏损。《医宗金鉴》说：“慄卑相合，名曰损，损者以营卫俱不足，有消缩之意也。”

⑩缓：和缓。表示卫气和调，脉来和缓。

⑪迟：此指从容徐缓之义。表示荣气和调，脉去从容。

⑫迟缓相搏：即迟缓相合。表示荣卫调和，脉象从容和缓，乃平脉之象。

⑬沉：此指沉静之义。表示荣卫调和，脉象和平沉静。

〔译译〕寸口部卫气强盛，叫做“高”，荣气强盛，叫做“章”，高与章相合，叫做“纲”。卫气虚弱，叫做“慄”，荣气虚弱，叫做“卑”，慄与卑相合，叫做“损”。卫气和调，叫做“缓”，荣气和调，叫做“迟”，迟与缓相合，叫做“沉”。

〔提要〕寸口荣卫的盛衰与和调，决定脉象的有余、不足及和平之象。

〔释义〕本条揭示寸口脉象的有余、不足及和平之象，决定于寸口荣卫的盛衰及和调与否。卫主气属阳，行脉外，荣主血属阴，行脉中。荣卫气血在人体内环周运行，“五十度复会于手太阴寸口”，且“五脏六腑之气味皆出于胃，变见于气口（寸口）”，说明荣卫气血的盛衰集中表现在寸口。故

寸口荣卫气血的盛衰及和调与否，是决定寸口脉象有余、不足及和平之象的生理与病理基础。若卫气偏盛，则脉来势有余，所谓“脉随指有力上来”，气盛力强。此乃卫气偏盛，脉显长盛之象，故谓之“名曰高”。荣气偏盛，则脉去势有余，所谓“脉随指有力下去”，圆实充满。此乃荣气偏盛，脉形显著，故谓之“名曰章”。荣卫俱盛，则其脉来去之势俱有余，脉象长盛、脉形显著，即所谓“高章相搏”，为诸有余脉之大纲，故谓之“名曰纲”。若卫气偏弱，则脉来势不足，所谓“脉随指无力上来”，气衰力弱。此乃卫气不足，脉搏软弱之象，故谓之“名曰微”。荣气偏弱，则脉去势不足，所谓“脉随指无力下去”，不能振作。此乃荣气不足，脉形细小之象，故谓之“名曰卑”。荣卫俱弱，则其脉来去之势俱不足，脉搏软弱、脉形细小，即所谓“微卑相搏”，为诸不足脉之大纲，故谓之“名曰损”。若荣卫调和，气血和调，阴平阳秘，则现平脉。卫气和调，脉来和缓，故谓之“名曰缓”；荣气和调，脉去从容，故谓之“名曰迟”；荣卫调和，则其脉来去和缓从容，即所谓“迟缓相搏”，此乃平脉和平沉静之象，故谓之“名曰沉”。

〔讨论〕

1. 原文分析：本条据寸口荣卫的盛衰及和调，以论其脉之有余、不足与和平之象。兹分析如下：

寸	卫气盛——脉来气盛力强，脉显长盛之象——高	荣卫俱盛	高章相搏	纲（诸有余脉之大纲）
	荣气盛——脉去圆实充满，脉形显著之象——章			
口	卫气弱——脉来气衰力弱，脉搏软弱之象——慄	荣卫俱弱	慄卑相搏	损（诸不足脉之大纲）
	荣气弱——脉去不能振作，脉形细小之象——卑			
	卫气和——脉来和缓——缓	荣卫调和	迟缓相搏	沉（和平沉静之脉）
	荣气和——脉去从容——迟			

本条原文叙述简略，加之古今字义变迁及医学术语演变，故关于高、章、纲、慄、卑、损、缓、迟、沉等的医学意义颇为难解。对此，可但领会其精神，而不必为其词解所拘泥。如对其“沉”字，《医宗金鉴》据平脉法23条认为，“名曰沉之‘沉’字，当是‘强’字，玩下文（即平脉法23条）自知。”无论是“沉”还是“强”，其所指寸口营卫调和即表现和平之脉的精神是一致的。

2. 关于本条的精神实质：本条说明，寸口荣卫出现偏盛或偏衰，则寸口脉必现太过或不及，从而出现相应的病变表现，这是据寸口脉以平脉辨证的基本法则；若寸口荣卫调和，则其脉必和缓从容，乃为无病之平脉。这是学习本条应当领会的精神实质。将本条与平脉法1条合参，可对诸太过与不及脉的成因和辨识要点获得比较全面的认识。对和缓从容之平脉的认识，还应当结合平脉法23条（见第二章“平脉”），该条即专论“寸口脉缓而迟”的生理。

3. 关于寸口荣卫盛衰的主病：据赵本与成本注释说：“高者，暴狂而肥。”“章者，暴泽而光。”“纲者，身筋急，脉强直故也。”“懔者，心中气动迫怯。”“卑者，心中常自羞愧。”“损者，五脏六腑俱乏气，虚憊故也。”“缓者，四肢不能自收。”“迟者，身体具重，但欲眠也。”“沉者，腰中直，腹内急痛，但欲卧，不欲行。”列举了荣卫盛衰的主病，成无己并引用《内经》之理做了阐释。试分析如下：

高：卫气盛，则阳气盛，阴不胜其阳，故“暴狂而肥”。

章：荣气盛，则荣血盛，阳不胜其阴，故“暴泽而光”。

纲：荣卫俱盛，则筋脉满急，故“身筋急，脉强直”。

懔：卫气弱，则上焦虚，故“心中气动迫怯”。

卑：荣气弱，则神气虚，故“心中常自羞愧”。

损：荣卫俱弱，则气血俱虚，五脏六腑失于滋养，故“五脏六腑俱乏气，虚憊”。

以上可以看作是对荣卫盛衰主病的举例，可以从中学习其分析病情的方法。但就其具体主病来说，不可认作定论。关于赵本与成本对缓、迟、沉的主病注解，则未免武断，也不能自圆其说。岂有荣卫调和而反见病象之理？故不可从。历代注家亦多从和缓从容之平脉来解释。

〔参考〕《素问》生气通天论说：“岐伯曰：阴者藏精而起亟也，阳者卫外而为固也。阴不胜其阳，则脉流薄疾，并乃狂。阳不胜其阴，则五藏气争，九窍不通。是以圣人陈阴阳，筋脉和同，骨髓坚固，气血皆从。如是则内外调

和，邪不能害，耳目聪明，气立如故。”《素问》脉要精微论说：“黄帝问曰：诊法何如？岐伯对曰：诊法常以平旦，阴气未动，阳气未散，饮食未进，经脉未盛，络脉调匀，气血未乱，故乃可诊有过之脉。”

〔原文〕问曰：脉有阴阳，何谓也？答曰：凡脉大、浮、数、动、滑，此名阳①也；脉沉、涩、弱、弦、微，此名阴②也。凡阴病③见④阳脉者生，阳病⑤见阴脉者死。（辨一1）

〔校勘〕“脉有阴阳”，成本作“脉有阴阳者”。本条在《金匱玉函经》为：“问曰：脉有阴阳，何谓也？答曰：脉大为阳，浮为阳，数为阳，动为阳，滑为阳，沉为阴，涩为阴，弱为阴，弦为阴，微为阴。阴病见阳脉者生，阳病见阴脉者死。”

〔词解〕

①阳：阳脉，脉象较平脉有余。

②阴：阴脉，脉象较平脉不及。

③阴病：八纲之阴证，或三阴病。

④见：音、义均同“现”（xiàn）。

⑤阳病：八纲之阳证，或三阳病。

〔语译〕问：脉象有阳脉、阴脉，说的是什么呢？答：凡脉象大、浮、数、动、滑的叫做阳脉；凡脉象沉、涩、弱、弦、微的叫做阴脉。凡是阴病显现阳脉的，预后良好，阳病显现阴脉的，预后不良。

〔提要〕脉分阴阳。

〔释义〕脉有阴阳之分。凡脉象有余者属阳脉，如大、浮、数、动、滑等；脉象不及者属阴脉，如沉、涩、弱、弦、微等。凡阴病，如里、虚、寒证，或太阴、少阴、厥阴病，而现阳脉，是正胜邪却之象，预后良好，故曰“生”；阳病，如表、实、热证，或太阳、阳明、少阳病，而现阴脉，是正不胜邪之征，预后不良，故曰“死”。

〔讨论〕

1. 脉象的阴阳属性：凡脉象有余者（太过）为阳脉，不及者（不足）为阴脉。阴阳是相对的，脉象的阴阳属性亦是相对的，本条举例示意，不可拘泥。

2. 凭脉预后原则：本条提出据脉象之阴阳与病证之阴阳的关系来推测预后的原则，是就一般规律而言，临证还当脉证详参，具体分析，方不致误。从临床实践来看，脉象因人、因时、因病而多变，脉与证是错综复杂的。因此，必须根据具体脉证进行预断。

〔参考〕《素问》阴阳别论说：“脉有阴阳，知阳者知阴，知阴者知阳……所谓阴阳者，去者为阴，至者为阳，静者为阴，动者为阳，迟者为阴，数者为阳。”《难经》四难说：“脉有阴阳之法，何谓也？……浮者阳也，滑者阳也，长者阳也，沉者阴也，短者阴也，涩者阴也；……”《素问》平人气象论说：“脉从阴阳，病易已，脉逆阴阳，病难已。”

二、诊脉方法

本节计2条。着重阐述了切脉的指力轻重，并分候五脏之气，平脉必须调息。

〔原文〕问曰：经①说脉有三菽②、六菽重者何谓也？师曰：脉，人以指按之，如三菽之重者，肺气也；如六菽之重者，心气也；如九菽之重者，脾气也；如十二菽之重者，肝气也；按之至骨者，肾气也。假令下利，寸口、关上、尺中悉不见脉，然尺中时一小见，脉再举头③（赵本注：一云按投）者，肾气也；若见损脉④来至，为难治。（平—10）

〔校勘〕“脉，人以指按之”，成本作“脉者，人以指按之”。“假令下利”以下文，成本分为另条。

〔词解〕

①经：此指《难经》五难。

②菽（shū）：豆类的总称，此指大豆。一菽约重0.25克。

③脉再举头：谓脉随呼吸再动，应指外鼓。再，二也，又一次之意。《医宗金鉴》说：“再举头者，谓一呼再起头，一吸再起头，合为四至也。”

④损脉：脉一息二至或不足二至者，名曰损脉。

〔语译〕问：《难经》说，脉有三菽重、六菽重的，这

说的是什么意思呢？老师答：切脉，医生用手指按脉，若用手指按脉的力量如三颗豆那么重，这样所切得的脉象是肺脉；如六颗豆那么重，是心脉；如九颗豆那么重，是脾脉；如十二颗豆那么重，是肝脉；重按至骨所切得的脉象，是肾脉。假如病人下利，寸、关、尺三部的脉都按不到，但是尺部有时能按到随呼吸而应指外鼓之脉，一呼再起头，一吸再起头，合为四至，这是肾气未绝的表现；若一息二至，叫做损脉，那就难以治疗了。

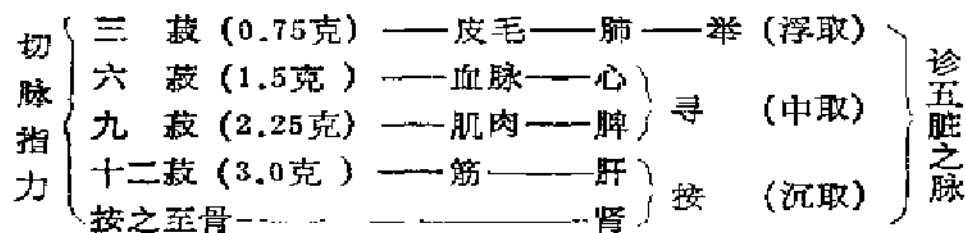
〔提要〕以切脉指力轻重，分候五脏脉气；并示例以寸、关、尺三部脉象辨下利预后。

〔释义〕本条概论切脉之法。《难经》五难说：“初持脉，如三菽之重，与皮毛相得者，肺部也。如六菽之重，与血脉相得者，心部也。如九菽之重，与肌肉相得者，脾部也。如十二菽之重，与筋平者，肝部也。按之至骨，举指来疾者，肾部也。”本条承其旨，论切脉指力的轻重以诊五脏之脉。肺主皮毛，心主血脉，脾主肌肉，肝主筋，肾主骨，五脏之脉各显现其所主之部。其中，特别教人如何掌握切脉指力之轻重，举菽重为例以供参考。凡初持脉，先轻手浮取，继之中取，后重手沉取，这是按脉的基本手法。文中列举下利为例，示人寸、关、尺三部脉法的运用。寸脉主心、肺，候上焦病；关脉主脾、胃，候中焦病；尺脉主肝、肾，候下焦病。若下利，寸、关、尺三部悉不见脉，然尺脉时一小见，即随呼吸再动而一息四至，是肾气未绝之征，病虽重尚可治疗；若脉一息二至，名为损脉，是气衰无胃之脉，预后

不良。

〔讨论〕

1. 切脉指力与举、按、寻：滑伯仁《诊家枢要》说：“持脉之要有三：曰举、按、寻。轻手循之曰举，重手取之曰按，不轻不重委曲求之曰寻。”本条举菽重以别之，示人规矩。二者关系如下图所示：



2. 尺脉为脉之根：本条后段举下利为例，说明寸、关、尺三部脉分候五脏的运用，着重突出尺脉为脉之根。尺脉候肾气，尺脉沉取应指有力为有根之脉，说明肾气为脉之根。如《脉诀》所说：“寸关虽无，尺犹不绝，如此之流，何忧殒灭！”所谓“然尺中时一小见，脉再举头者，肾气也”，其意义即在此。如《医宗金鉴》所说：“假令下利而甚，元气暴夺于中，寸口、关上、尺中全不见脉，法当死，其不死者，必是尺中时有一小见之脉也。再举头者，谓一呼再起头，一吸再起头，合为四至也。夫尺中时一小见脉四至，则是肾间生气之源未绝，即下利未止，尚为易治。若一息二至，名曰损脉，是气衰无胃，故为难治也。”

〔参考〕《难经》十四难说：“一呼一至，一吸一至，名曰损，人虽能行，犹当着床，所以然者，血气皆不足也”，“上部有脉，下部无脉，其人当吐，不吐者死。上部无脉，

下部有脉，虽困无能为害，所以然者，譬如人之有尺，树之有根，枝叶虽枯槁，根本将自生，脉有根本，人有元气，故知不死。”

〔原文〕师曰：呼吸者，脉之头①也。初持脉，来疾去迟，此出疾入迟，名曰内虚外实也②；初持脉，来迟去疾，此出迟入疾，名曰内实外虚也。（平一2）

〔校勘〕本条在《脉经》为：“夫呼者，脉之头也。初持之，来疾去迟，此为出疾入迟，为内虚外实；初持脉，来迟去疾，此为出迟入疾，为内实外虚也。”

〔词解〕

①头：此喻作标准。脉随呼吸而行，故呼吸为脉之标准。

②来，去，出，入：此针对呼吸而言。随气之呼出者为来、为出，随气之吸入者为去、为入。以下义同。

〔语译〕老师说：呼吸为脉之标准。初按脉时，脉来的快去的慢，这是呼气时脉快而吸气时脉慢，叫内虚外实。初按脉时，脉来的慢去的快，这是呼气时脉慢而吸气时脉快，叫做内实外虚。

〔提要〕呼吸为脉之标准，并以此辨内外虚实。

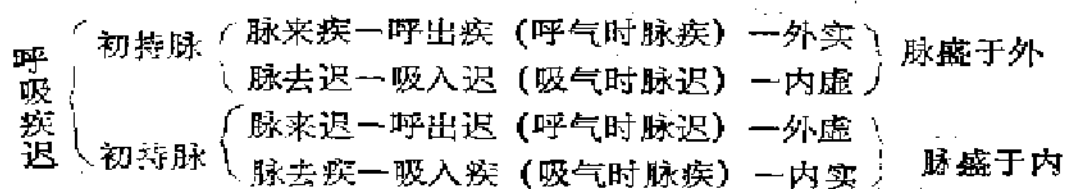
〔释义〕脉随肺气的呼吸出入而搏动，因此可用呼吸来作为计算脉搏快慢的标准。《素问》平人气象论说：“人一呼脉再动，一吸脉亦再动，呼吸定息脉五动，闰以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病调病人，医不病，故为

病人平息以调之为法。”其不足曰迟，太过为数（疾）。脉随气之呼出为来，随气之吸入为去。脉来疾去迟，是脉盛于外，故曰“内虚外实”；脉来迟去疾，是脉盛于内，故曰“内实外虚”。总的精神，在于说明脉搏与呼吸必须匀调，方为无病。

〔讨论〕

1. 平脉调息：脉与呼吸相应，因此可用呼吸作为脉搏快慢的标准。《素问》平人气象论以“呼吸定息脉五动，闰以太息，命曰平人。”《难经》十四难以“脉来一呼再至，一吸再至，不大不小曰平”。据此，呼吸与脉搏之比约为1:4~5。这是辨迟、数脉的主要依据，所以平脉必须调息。所谓“调息”，如《素问》平人气象论所说：“常以不病调病人，医不病，故为病人平息以调之为法。”因此，医生诊脉时必须静心专注，匀和呼吸，以定病人一息的至数。原文“呼吸者，脉之头也”，其意义如此。

2. 关于内外虚实之辨：文中据呼吸与脉之疾、迟的关系辨内外虚实，说明平脉调息的运用。如下图所示：



关于“来”、“去”、“出”、“入”的涵义，历代注家多认为：来、去者，指脉之来去；出、入者，指呼吸之出入。即认为来者自骨肉之分，而出于皮肤之际，气之升而上

也，去者自皮肤之际，而还于骨肉之间，气之降而下也，出呼而来，入吸而去。但黄竹斋认为：“脉度虽有去来，而诊脉之法，但诊其来不诊其去，且来疾则去亦疾，来迟则去亦迟。今曰来疾去迟、来迟去疾者，盖以呼出为来，吸入为去，人病则呼吸长短不匀，而有来去迟疾之各异，是以呼吸而为脉之头者如此。”（《伤寒杂病论会通》）义明理顺，可供参考。但总的来说，本条关于内外虚实之辨，似难验证于临床。其主要精神，在于说明脉搏与呼吸必须匀调，方为无病。

三、脉诊注意事项

本节计5条。内容分为：脉应四时，脉因人异，脉随神变，脉有灾怪。

（一）脉应四时

〔原文〕师曰：立夏得洪（赵本注：一作浮）大脉，是其本位。其人病，身体苦疼重者，须发其汗；若明日身不疼不重者，不须发汗；若汗潏潏①自出者，明日便解矣。何以言之？立夏脉洪大，是其时脉，故使然也。四时仿此。（辨一16）

〔校勘〕成本无“师曰”二字。“若汗潏潏自出者”，《金匱玉函经》作“若汗潏潏然自出者”。“立夏脉洪大”，成本作“立夏得洪大脉”。

〔词解〕

①潏潏：潏（jì），音戟。潏潏，汗出连绵不断的意

思。

〔语译〕老师说：立夏时人现洪大脉，这是夏令本来应见的脉象。如果其人得病，身体疼重难受，这是表证，须用汗法来治疗；如果第二天身体不疼、不重，那就不须发汗；如果自动地连绵不断出汗，身疼重第二天便可解除。为什么这样说呢？因为立夏脉洪大，是夏令之脉，所以如此。四时均可依此类推。

〔提要〕以夏脉洪大为例，说明脉应四时为顺。

〔释义〕人与自然相应，脉应四时之气而变。春弦、夏洪、秋毛、冬石，为四时阴阳和平之脉。脉应四时，即使有病亦不会太重，容易痊愈。因脉应四时乃正气充实之象，虽一时不慎外感客邪，正气自能抗邪达表，得自汗出而解。如立夏得洪大之脉，是因人体阳气应夏令而盛于体表之象，故为夏令阴阳和平之脉。此即使见身体疼重之表证，发其汗即愈；若转见不疼、不重，则无须发汗；若见濈濈然自汗出，是正气驱邪出表之征，病即自愈。正如《素问》平人气象论说：

“脉得四时之顺，曰病无他；脉反四时及不间藏，曰难已。”

〔参考〕《内经》、《难经》有关脉应四时的论述，可详参《素问》脉要精微论、平人气象论、玉机真藏论和《难经》十五难等。

（二）脉因人异

〔原文〕师曰：脉①肥人责②浮，瘦人责沉。肥人当沉，今反浮；瘦人当浮，今反沉，故责之。（平—17）

〔词解〕

①脉：这里指诊脉的意思。

②责：责求，这里有追究的意思。

〔语译〕老师说：诊肥胖人的脉，要追究脉浮；体瘦的人，要追究脉沉。因为肥胖的人应脉沉，而现在反见浮象；体瘦的人应脉浮，而现在反见沉象，所以要追究其原因。

〔提要〕脉因体质肥瘦而有浮沉之不同。

〔释义〕肥人皮肉丰满，经脉不易显露，其脉显沉；瘦人皮肉浅薄，经脉易于显露，其脉显浮。这是脉因人体肥瘦不同而有沉浮的不同，是正常变化，不属病脉。若肥胖的人脉反浮，体瘦的人脉反沉，则是反常现象，多为邪气干扰所致，应当详究其原因。

（三）脉随神变

〔原文〕问曰：人愧者，其脉何类？师曰：脉浮，而面色乍白乍赤①。（平—9）

〔校勘〕本条在《脉经》为：“问曰：人愧者，其脉何等类？师曰：其脉自浮而弱，面形乍白乍赤。”

〔词解〕

①乍白乍赤：乍（zhà），忽然。乍白乍赤，一忽儿白，一忽儿红。

〔语译〕问：人在羞愧时，其脉象是什么样？老师说：脉浮，而且面色一忽儿白，一忽儿红。

〔提要〕羞愧时的脉象及面色。

〔释义〕羞愧者神不定，神气外浮而气血紊乱。因此，脉应之而现浮象；气血逆下则面白，气血逆上则面赤。但此乃暂时现象，而非病态。一待神定而气血和调，即可恢复正常。

〔原文〕问曰：人恐怖者，其脉何状？师曰：脉形如循丝①，累累然②，其面白脱色也。（平—7）

〔校勘〕“人恐怖者”，成本作“人病恐怖者”。本条在《脉经》为：“问曰：人病恐怖，其脉何类？师曰：脉形如循丝，累累然，其面白脱色。”

〔词解〕

①如循丝：如按在丝缕上一样。

②累累然：累(léi)累，通“羸羸”，瘦瘠疲惫的样子，这里指细小无力的意思。

〔语译〕问：人受了恐怖，其脉是什么形态？老师答：脉的形态好象按在丝缕上一样，细小无力，病人的面色苍白无泽。

〔提要〕人受惊恐时的脉象与面色。

〔释义〕心藏神，主血脉，其华在面。《灵枢》营卫生会篇说：“血者，神气也”。可知血气不足者，神气虚弱，而易受惊恐。恐则血随气下，经脉空虚，血不上荣，故见其脉细小无力，面色苍白无泽。

〔讨论〕以上二条，揭示了人的精神状态对脉象有着明显的影响。《素问》举痛论说：“余知百病生于气也。怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，思则气

结。”可见情志失调，必然影响荣卫气血的正常运行，而对脉象发生影响。因此，诊脉时必须使病人保持安静状态，心情舒畅，方能排除情志变化对脉象的干扰，以便诊有病之脉。

（四）脉有灾怪

〔原文〕问曰：脉有灾怪①，何谓也？师曰：假令人病，脉得太阳，与形证相应，因为作汤；比还②送汤如食顷③，病人乃大吐，若下利，腹中痛。师曰：我前来不见此证，今乃变异，是名灾怪。又问曰：何缘作此吐利？答曰：或有旧时服药，今乃发作，故为灾怪耳。（平—13）

〔校勘〕“怪”，成本作“恠”。“故为灾怪耳”，成本作“故名灾恠耳”。本条在《脉经》为：“问曰：脉有灾怪，何谓？师曰：假令人病，脉得太阳，脉与病形证相应，因为作汤；比还送汤之时，病者因反吐，若下利，病腹中痛。因问言：我前来脉时，不见此证，今反变异，故是名为灾怪。因问：何缘作此吐利？答曰：或有先服药，今发作，故为灾怪也。”

〔注解〕

①灾怪：灾害怪异之义。凡脉证相应，如法服药后而病情反变化加重，故称为灾怪。

②比还：比，挨着，相接之义。还，再、又。比还，紧接着又……。

③食顷：一顿饭工夫。表示时间短暂。

〔语译〕问：脉有灾怪，说的是什么意思呢？老师答：假使有人得病，诊得太阳病脉象，脉象与太阳病的证候一致，据此给予治太阳病的汤药；紧接着给病人服药，服药后一顿饭的工夫，病人即大吐，又下利，腹中痛。医生说：我初来时并无此证，今忽然变异，这就叫灾怪。又问：是什么原因引起如此呕吐、下利？答：或许在前些时候服了其它的药，现在才发生作用，所以发生灾怪。

〔提要〕脉有灾怪。

〔释义〕所谓“脉得太阳，与形证相应”，如太阳病提纲所说：“太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。”即脉与形证相应。脉证相符的太阳病，对证下药，理当药到病除。今药后食顷，病人吐利、腹痛，此乃诊治时所未见之证，故名“灾怪”。何以发生如此灾怪？原因在医生未详细了解病人过去的诊治、服药情况，或者病人有所隐讳，以致发生灾怪。这仍然是诊治的过错。

〔讨论〕本条的意义，如《医宗金鉴》所说：“望、问、固医家之事，亦须病人毫无隐讳，方能尽医所长，仲景为病家服药未告于医，医失问先服何药，故出此条以示戒耳！”点出了本条的精神实质。至于灾怪是否皆责之于“旧时服药，今乃发作”之过，不可拘泥。

四、四诊合参

本节计2条。揭示了四诊合参的意义。

〔原文〕师曰：病家人来请云，病人发热烦极。明日师到。病人向壁卧，此热已去也，设令脉不和，处言①已愈。设令向壁卧，闻师到，不惊起而眈视②，若三言三止，脉③之，咽唾者，此诈病④也；设令脉自和，处言此病大重，当须服吐下药，针灸数十百处，乃愈。（平—4）

〔校勘〕“此病大重”，成本作“汝病大重”。本条在《脉经》为：“假令向壁卧，闻师到，不惊起而目眈视（一云反面仰视），若三言三止，脉之，咽唾，此为诈病；假令脉自和，处言此病太重，当须服吐下药，针灸数十百处，乃愈。”

〔词解〕

①处言：告诉之义。

②眈视：眈（xī），怒视。

③脉：此活用为动词，诊察的意思。

④诈病：诈，欺骗、装假。诈病，装病。

〔语译〕老师说：病家的人来请医生时说，病人发热，烦躁得很。第二天医生去看，病人向壁静卧，这是热已退去，假使脉象还未平和，亦可以告诉病家，其病将愈。假使病人向壁而卧，听说医生到，并不惊起，反而有怒视的样子，说话吞吐支吾，诊脉时，又故意吞嚥唾沫，这是伪装的假病；假使脉自正常，可以告诉病人此病很严重，必须服催吐、泻下药，同时还要针灸数十百处，才能痊愈。

〔提要〕四诊合参判断病情，并示人对诈病的处理。

〔释义〕阳主动，病人发热烦极，必不得卧。今病人向

壁静卧，足征烦热已退，即使脉象尚见不和，仍是向愈之象，故可以告诉病家其病将痊愈。若病人脉不和，且烦躁不得卧，甚或昏睡，乃病进重急之征，必须及时救治，切不可妄言将愈。又若病人向壁静卧，其病属真，即或系阴证，见医生到来亦必有欣喜之情，且述病絮絮不休。今病者相反，见医生到来反有厌恶之意，又不很好地述说病情，吞吐支吾，脉之只见噤唾而无呻吟之声，且脉象和平，则可知其为诈病。对此诈病者，可以危言警告之，诈言当以毒药及针灸数十百处治疗，彼畏毒药、针灸，即不敢再诈病。

〔讨论〕脉诊为四诊之一，诊法当以望、闻、问、切四诊合参，不可偏执脉诊一端。本条以病人发热烦极的病情变化及对诈病的辨识为例，具体说明了四诊合参的重要意义，教诲医生必须细致地诊察病人。只有对病人进行周密、细致的全面诊察，才能透过现象看到本质。

〔原文〕师持脉，病人欠①者，无病也。脉之，呻②者，病也。言迟③者，风也。摇头言者，里痛也。行迟者，表强④也。坐而伏者，短气也。坐而下一脚者，腰痛也。里实护腹⑤，如怀卵物者，心痛也。

（平—5）

〔校勘〕本条在《脉经》分为两条：“师持脉，病人欠者，无病也。脉之，因呻者，无病也（一曰呻者病也）。”

“言迟者，风也。摇头言者，其里痛也。行迟者，其表强也。坐而伏者，短气也。坐而下一膝者，必腰痛里实。护腹如怀

卵者，必心痛。”

〔词解〕

①欠：呵欠。

②呻：呻吟。

③言迟：说话迟钝，不灵活。

④表强：邪痹肌表，筋脉强急不和，因而行动迟钝，行步不利，名为表强。

⑤护腹：用手保护脘腹部。

〔语译〕医生诊脉时，病人打呵欠的，是没有病。诊脉时呻吟不已的，是有病。说话迟钝不灵活的，是风病。摇头说话的，是里有疼痛。行动迟钝的，是邪痹肌表，筋脉强急不和，叫做表强。坐而俯伏的，是喘促短气。坐着而要伸下一脚的，是腰痛。里实而用手保护脘腹部，如怀抱鸡蛋一样不肯松手的，是心胃部疼痛。

〔提要〕四诊合参示例。

〔释义〕脉诊必须结合望诊、闻诊、问诊，方能全面诊察病情。本条即以举例方式，说明望诊、闻诊、问诊的结合运用。如医生诊脉时望见病人呵欠，即所谓深呼吸之态，这是阴阳相引，常为平人疲倦之象，提示无病。若闻之病人呻吟不已，则必有所痛苦。又若闻其言语迟钝，多提示舌强，重则舌蹇，常为风邪内中之疾，故曰风。若里有疼痛，则痛难言语，言之多头摇不定，是说话费力的表现。望之行动迟钝，多为风、寒、湿邪痹着肌表、经络，以致筋脉强急不和，名为表强。若坐而俯伏，多为喘咳而呼吸短促的标

志，其动必喘甚，仰则胸闷不舒，故曰短气。腰痛者，坐则多伸足倚椅，以求暂安，故曰坐而下一脚。里实拒按，而今观之以手护腹，正是以防触碰，若其状如怀抱鸡蛋而不敢松手，多是心、胃疼痛的表现。

〔讨论〕本条虽提到“师持脉”、“脉之”，但并未具体指出脉象，所举皆望、闻、问诊内容，示人四诊的结合运用。其对病情的判断，意在举例，说明其判断皆来自对病人的全面诊察，不可厘定。

〔参考〕《素问》五脏别论说：“凡治病，必察其下，适其脉，观其志意，与其病也。”《素问》阴阳应象大论说：

“善诊者，察色按脉，先别阴阳；审清浊，而知部分；视喘息，听音声，而知所苦；观权衡规矩，而知病所主；按尺寸，观浮沉滑涩，而知病所生。以治无过，以诊则不失矣。”

《素问》五脏生成篇说：“夫脉之大小滑涩浮沉，可以指别；五藏之象，可以类推，五藏相音，可以意识；五色微诊，可以目察。能合脉色，可以万全。”《素问》玉机真藏论说：“黄帝曰：凡治病，察其形气色泽，脉之盛衰，病之新故，乃治之，无后其时。”

第二章 平脉与病脉

本章汇集了脉法二篇有关平脉与病脉的条文。内容包括：平脉的脉象及生理，主要病脉的脉象、机理及主病等。

一、平脉

本节计2条。主要论述了平人之缓脉（平脉）的脉象及生理。

〔原文〕阳脉①浮大而濡，阴脉②浮大而濡，阴脉与阳脉同等者，名曰缓也。（辨—8）

〔校勘〕“阴脉与阳脉同等者”，《金匱玉函經》作“阴与阳同等者”。

〔词解〕

①阳脉：此指寸脉。

②阴脉：此指尺脉。

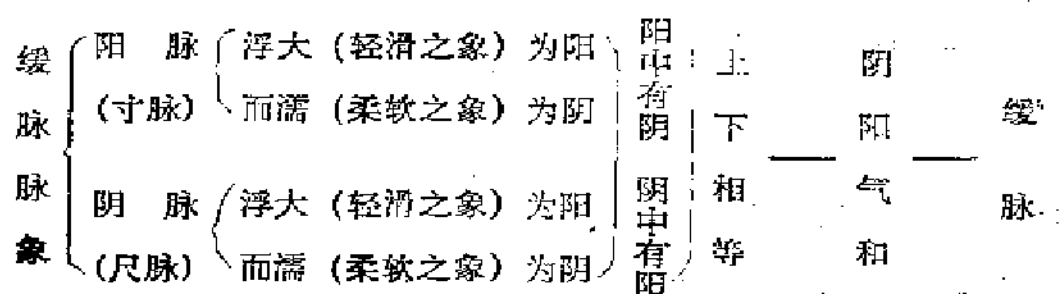
〔语译〕寸脉浮大而濡，尺脉浮大而濡，寸脉与尺脉相等，名叫缓脉。

〔提要〕辨缓脉之脉象。

〔释义〕脉浮大为阳，濡软为阴，浮大而濡者，是阴中有阳、阳中有阴，更若寸口与尺中之脉上下相等，无偏盛偏衰之象，是阴阳气和，故其脉来从容和缓，名为缓脉。其脉一息四至，不疾不徐，从容和缓，而属平脉。

〔讨论〕本条举辨缓脉为例，以示平人和缓之脉，当与脉缓之病脉鉴别。如成无己说：“阳脉寸口也，阴脉尺中也。上下同等，无有偏胜者，是阴阳之气和缓也，非若迟缓之有邪也。阴阳偏胜者为结、为促，阴阳相搏者为动，阴阳气和者为缓，学者不可不知也。”（《注解伤寒论》）兹分析如下：

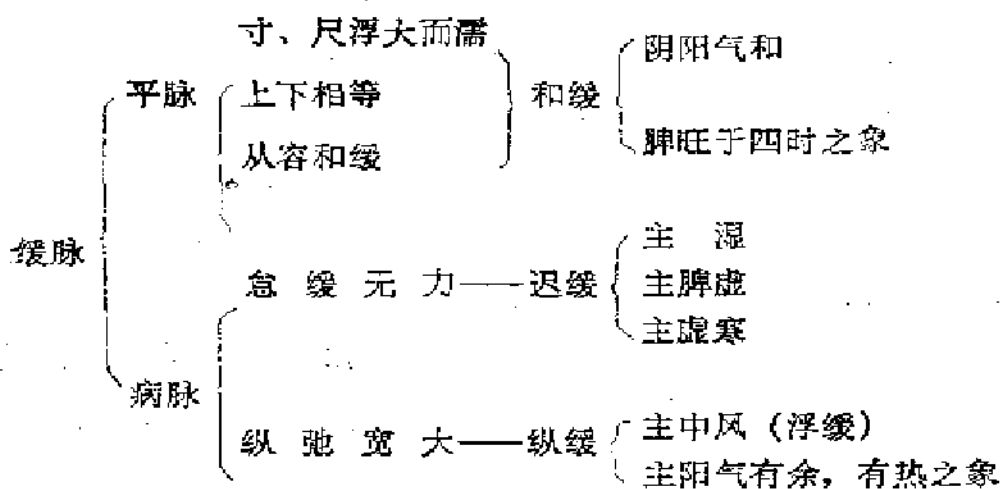
1. 缓脉之脉象：如下图所示：



据此，缓脉的形态特征是：寸、尺均显浮大而濡（轻滑而柔软），上下相等，即为和缓从容之平脉。

2. 缓脉之平脉与病脉的鉴别：

缓脉有平脉与病脉之分。本条所论为从容和缓之平脉，是阴阳气和之象。有病之缓脉，乃邪扰之征。其鉴别如下图所示：



有病之缓脉多迟缓，故一般列属迟脉类。和缓平脉之浮大而濡，是轻滑柔软之象，这与虚脉之浮大无力、按之软而空虚的特征截然不同，亦当注意鉴别。

〔原文〕寸口脉缓而迟①，缓则阳气②长，其色鲜，其颜光，其声商③，毛发长；迟则阴气④盛，骨髓生，血满，肌肉紧薄鲜⑤。阴阳相抱⑥，荣卫俱行，刚柔相得⑦，名曰强⑧也。（平—23）

〔校勘〕“刚柔相得”，成本作“刚柔相搏”。《脉经》载本条为：“寸口脉缓而迟，缓则为阳，其气长；迟则为阴，荣气促。荣卫俱和，刚柔相得，三焦相承，其气必强。”

〔词解〕

①寸口脉缓而迟：寸口脉，此指寸、关、尺脉。缓，和

缓之谓，迟，从容之谓。即寸口脉和缓从容。

②阳气：此指卫气。

③商：五音（宫、商、角、征、羽）之一。此喻语声清脆。

④阴气：此指荣阴。

⑤肌肉紧薄鲜鞭：肌肉丰腴结实。

⑥阴阳相抱：形容阴中有阳、阳中有阴，阴阳和调。

⑦刚柔相得：刚，阳之谓；柔，阴之谓。刚柔相得，喻阴阳相济。

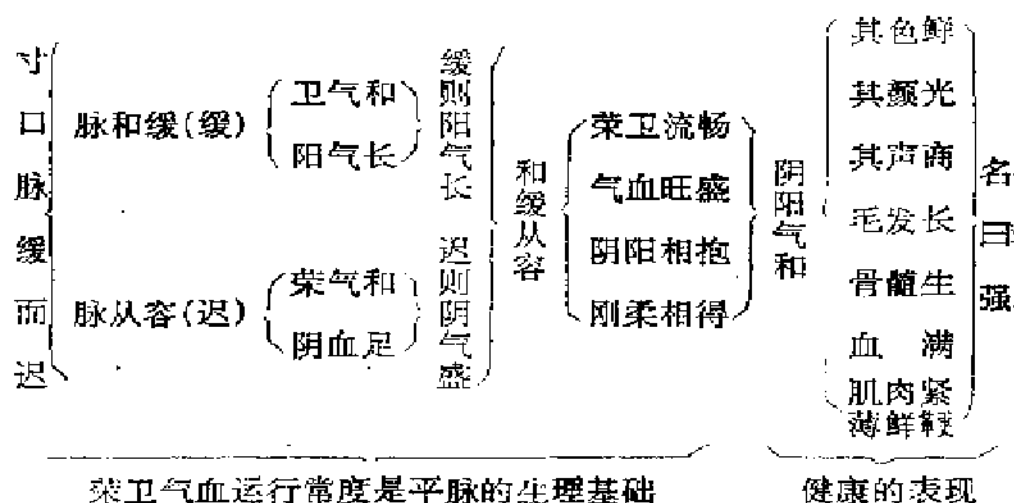
⑧强：强健。

〔语译〕寸口脉和缓从容，和缓是卫阳旺，其人皮色鲜明，容颜光泽，语声清脆，毛发荣长；从容是荣血充盛，其人骨髓生长，血液充盈，肌肉丰腴结实。阴阳和调，荣卫并行，阴阳相济，叫做强健。

〔提要〕论平脉之生理。

〔释义〕荣卫气血在经脉中的运行状况，是形成脉象的生理基础。平脉是荣卫、气血、阴阳和调的生理表现。本条所言“寸口脉缓而迟”，是指和缓从容的平脉。所谓“缓”，即和缓之意；“迟”，即从容之意。脉和缓，是卫气和、阳气旺的表现；脉从容，是荣气和、阴血足的表现。脉和缓从容，则荣卫流畅，气血旺盛，阴阳和调，即所谓“刚柔相得”。如此则其人必皮色鲜明，容颜光泽，语声清脆，毛发荣长，骨髓盛满，荣血充盈，肌肉丰腴结实，身体健壮，故谓之“强”。

〔讨论〕本条所谓“缓则阳气长”、“迟则阴气盛”是为分析说明问题而分别言之，不能将其割裂开来看待。从“阴阳相抱，荣卫俱行，刚柔相得”，即明确说明必须将二者结合起来认识。兹将原文分析如下：



〔参考〕《素问》生气通天论说：“岐伯曰：阴者，藏精而起亟也；阳者，卫外而为固也。阴不胜其阳，则脉流薄疾，并乃狂。阳不胜其阴，则五藏气争，九窍不通。是以圣人陈阴阳，筋脉和同，骨髓坚固，气血皆从。如是则内外调和，邪不能害，耳目聪明，气立如故。……阴平阳秘，精神乃治，阴阳离决，精气乃绝。”

二、脏 腑 脉

本节计 3 条。论述了脏腑脉之胃气、脏腑之平脉、病脉及死脉等。

（一）辨脏腑脉之胃气

〔原文〕问曰：濡弱①何以反适②十一头③？师曰：五脏六腑相乘④，故令⑤十一。（平—43）

〔词解〕

①濡弱：此指脉有胃气所表现的柔和之象。如“春脉弦者，肝东方木也，万物始生，未有枝叶，故其脉来，濡弱而长，故曰弦。”（《难经》十五难）其“濡弱而长”之“濡弱”，即胃气的表现，与本条同义。

②适：切合，相合。

③十一头：头，物量词，代表脏腑。十一头，指五脏六腑，合为十一脏腑。

④相乘：相互作用，相互影响。

⑤令：使，使得。其后省略“反适”二字。

〔语译〕问：濡弱的脉为什么反适合十一脏腑？老师答：因为五脏六腑相互作用，所以使能适合十一脏腑。

〔提要〕据濡弱辨五脏六腑之胃气。

〔释义〕本条揭示脉有胃气为贵。如《素问》五藏别论说：“是以五藏六府之气味，皆出于胃，变见于气口。”胃为后天之本，生化之源。五脏六腑皆禀气于胃，胃气间于五脏六腑之中，故五脏六腑之脉皆以有胃气为贵。五脏六腑之脉有胃气，是后天化源未竭，故为贵。如何辨脏腑脉有胃气？以其脉显濡弱为有胃气之征。濡弱，是脉有胃气所表现的柔和之象。五脏六腑之气相互贯通，故其脉均以显濡弱为

有胃气。五脏六腑之脉显濡弱，是有胃气之脉，即使有病，其预后亦良好。若脏腑脉无胃气（不显濡弱），则为真脏脉现，不死也殆。

〔讨论〕

1. “濡弱”脉的辨识：本条所言“濡弱”，是指脉显柔和之象，是对脉有胃气的描述。这与濡脉（浮小而细软，主诸虚、主湿）和弱脉（沉而细柔，主气血不足，主虚寒）截然不同，二者皆属病脉。且二者虽均显细而柔软之象，但按之无力。脉有胃气所表现的濡弱，以和缓均匀、柔和有力为特征。

一般来说，此“濡弱”之脉主要为脾（胃）之平脉。如《素问》平人气象论说：“长夏胃微濡弱曰平，弱多胃少曰脾病……”今以“濡弱”为有胃气之征，适见于五脏六腑，而不独为脾（胃）所见，故原文问曰何以“反”适十一头。

2. 平脉之“缓而迟”与脉有胃气之“濡弱”的关系：平脉和缓从容，即所谓“寸口脉缓而迟”（平—23条）。而平脉即平人之脉，“平人者，不病也”（《素问》平人气象论）。可知平脉乃为无病之脉。无病之脉，自当有胃气。故平脉之“缓而迟”亦是有胃气之征，如辨脉法21条所说“趺阳脉迟而缓，胃气如经也。”平脉是有胃气之脉，自然也显“濡弱”之象。因此，平脉并见“缓而迟”与“濡弱”的特征，概括其辨识要点是：不浮不沉，不大不小，不长不短，虚实和调，不疾不徐，至数分明，从容和缓，柔和有力。于此可见“迟缓”与“濡弱”，皆胃土之脉。然平脉与有胃之脉，在概念

上是有区别的。平脉必有胃气，但有胃气之脉并非都是平脉。一般病脉亦有胃气，只是较之平脉而有程度不同。无胃气之脉乃真脏脉，必预后不良，所谓“人无胃气曰逆，逆者死”（《素问》平人气象论）。因此，“濡弱”之象不仅显现于平脉，还显现于一般病脉，说明虽病而尚有胃气，预后良好，如“肝病自得濡弱者，愈也”（平—14），即其例。

〔参考〕《素问》平人气象论说：“平人之常气禀于胃，胃者平人之常气也。人无胃气曰逆，逆者死。”《素问》玉机真藏论说：“岐伯曰：五藏者皆禀气于胃，胃者五藏之本也；藏气者，不能自致于手太阴，必因于胃气，乃至于手太阴也。故五藏各以其时，自为而至于手太阴也。”《灵枢》动输篇说：“胃为五藏六府之海，其清气上注于肺，肺气从太阴而行之……”。《素问》玉机真藏论说：“脉弱以滑，是有胃气，命曰易治，取之以时。”

（二）五脏平脉、病脉及死脉

〔原文〕问曰：东方肝脉，其形何似？师曰：肝者，木也，名厥阴，其脉微弦濡弱而长，是肝脉也。肝病自得濡弱者，愈也；假令得纯弦脉者，死。何以知之？以其脉如弦直，此是肝藏伤，故知死也。（平—14）

〔校勘〕“此是肝藏伤”，成本无“此”字。

〔语译〕问：东方肝脉的形象怎样？老师答：肝属木，名叫厥阴，其脉象微弦濡弱而长，是肝的平脉。肝病脉象自显

濡弱的，易愈；假使纯见弦象，多不治。如何知道的呢？根据其脉象弦直，这是肝脏受到伤害，所以知道不治的。

〔提要〕辨肝脏平脉、病脉与死脉。

〔释义〕本条以肝为例，示辨五脏平脉、病脉及死脉，可以说是上条（平—43条）的实例。《素问》玉机真藏论说：“春脉者肝也，东方木也，万物之所以始生也，故其气来，奭弱轻虚而滑，端直以长，故曰弦，反此者病。”《难经》十五难说：“春脉弦者，肝东方木也，万物始生，未有枝叶，故其脉之来，濡弱而长，故曰弦。”又说：“春脉微弦曰平，弦多胃气少曰病，但弦无胃气曰死，春以胃气为本。”这是用取类比象之法，以自然之理来说明肝之平脉。本条承其旨。肝之平脉微弦濡弱而长，所谓“春脉微弦曰平”，“濡弱”者胃气也。肝病“弦多胃气少”，即濡弱之象不及。若肝病脉象自显濡弱，是得胃气之脉，示肝气已和，故曰愈也。若肝病见纯弦之脉，所谓“死肝脉来，急益劲，如新张弓弦，曰肝死。”（《素问》平人气象论）这是毫无胃气之象，乃肝脏伤，真脏脉现，故曰“死”。可见，凭脉预后，全视胃气之多少与有无。综上所述，可知本条还具体说明了“濡弱何以反适十一头？”的基本道理。

〔参考〕本条精神内容，系承《内经》、《难经》之说。兹摘《内经》、《难经》有关五脏平脉、病脉及死脉的论述，以供参考：

《素问》宣明五气篇说：“五脉应象，肝脉弦，心脉钩，脾脉代，肺脉毛，肾脉石，是谓五藏之脉。”

《素问》平人气象论说：“春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦无胃曰死……夏胃微钩曰平，钩多胃少曰心病，但钩无胃曰死……长夏胃微濡弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代无胃曰死……秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛无胃曰死……冬胃微石曰平，石多胃少曰肾病，但石无胃曰死……夫平心脉来，累累如连珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃气为本；病心脉来，喘喘连属，其中微曲，曰心病；死心脉来，前曲后居，如操带钩，曰心死。平肺脉来，厌厌聂聂，如落榆莢，曰肺平，秋以胃气为本；病肺脉来，不上不下，如循鸡羽，曰肺病；死肺脉来，如物之浮，如风吹毛，曰肺死。平肝脉来，濡弱招招，如揭长竿末梢，曰肝平，春以胃气为本；病肝脉来，盈实而滑，如循长竿，曰肝病；死肝脉来，急益劲，如新张弓弦，曰肝死。平脾脉来，和柔相离，如鸡践地，曰脾平，长夏以胃气为本；病脾脉来，实而盈数，如鸡举足，曰脾病；死脾脉来，锐坚如鸟之喙，如鸟之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平肾脉来，喘喘累累如钩，按之而坚，曰肾平，冬以胃气为本；病肾脉来，如引葛，按之益坚，曰肾病；死肾脉来，发如夺索，辟辟如弹石，曰肾死。”

《难经》十五难说：“春脉弦者，肝东方木也，万物始生，未有枝叶，故其脉之来，濡弱而长，故曰弦。夏脉钩者，心南方火也，万物之所茂，垂枝布叶，皆下曲如钩，故其脉之来，来疾去迟，故曰钩。秋脉毛者，肺西方金也，万物之所终，草木华叶，皆经秋而落，其枝独在，若毫毛也，故其脉

之来，轻虚以浮，故曰毛。冬脉石者，肾北方水也，万物之所藏也，极冬之时，水凝如石，故其脉之来，沉濡而滑，故曰石。此四时之脉也。如有变奈何？然：春脉弦，反者为病。何谓反？然：其气来实强，是谓太过，病在外；气来虚微，是谓不及，病在内。气来厌厌聂聂，如循榆叶曰平；益实而滑，如循长竿曰病；急而劲益强，如新张弓弦曰死。春脉微弦曰平，弦多胃气少曰病，但弦无胃气曰死，春以胃气为本。夏脉钩，反者为病。何谓反？然：其气来实强，是谓太过，病在外；气来虚微，是为不及，病在内。脉来累累如环，如循琅玕，曰平；来而益数，如鸡举足者曰病；前曲后居，如操带钩曰死。夏脉微钩曰平，钩多胃气少曰病，但钩无胃气曰死，夏以胃气为本。秋脉毛，反者为病。何谓反？然：其气来实强，是谓太过，病在外；气来虚微，是谓不及，病在内。其脉来蔼蔼如车盖，按之益大曰平；不上不下，如循鸡羽曰病；按之萧索，如风吹毛曰死。秋脉微毛曰平，毛多胃气少曰病，但毛无胃气曰死，秋以胃气为本。冬脉石，反者为病。何谓反？然：其气来实强，是谓太过，病在外；气来虚微，是谓不及，病在内。脉来上大下兑，濡滑如雀之喙曰平；啄啄连属，其中微曲曰病；来如解索，去如弹石曰死。冬脉微石曰平，石多胃气少曰病，但石无胃气曰死，冬以胃气为本。胃者，水谷之海，主禀四时，故皆以胃气为本，是谓四时之变病，死生之要会也。脾者，中州也，其平和不可得见，衰乃见耳，来如雀之啄，如水之下漏，是脾衰之见也。”

〔原文〕南方心脉，其形何似？师曰：心者，火也，名少阴，其脉洪大而长，是心脉也。心病自得洪大者，愈也。假令脉来微去大①，故名反②，病在里也；脉来头小本大③，故名复④，病在表也；上微头小⑤者，则汗出；下微本大⑥者，则为关格不通⑦，不得尿，头无汗者可治，有汗者死。西方肺脉，其形何似？师曰：肺者，金也，名太阴，其脉毛浮⑧也。肺病自得此脉，若得缓迟者皆愈。若得数者，则剧。何以知之？数者南方火，火克西方金，法当痈肿，为难治也。（平—15）

〔校勘〕“脉来头小本大”，成本“大”字下有“者”字。“名太阴”，成本作“名大阴”。

〔词解〕

①来微去大：来，指脉自骨肉之分而出于皮肤之际；去，指脉自皮肤之际而还于骨肉之间。微，言脉之气势衰微；大，言脉之气势盛大。来微去大，即脉来势衰微而去势盛大。

②反：此谓脉“反”。心脉洪大而长，其气来盛去衰，亦可谓之来大去微；而今反来微去大，与之相反，故名曰“反”。

③头小本大：头，指寸部；本，指尺部。头小本大，即寸脉小尺脉大。

④复：即“覆”，此义同“反”。指寸脉与尺脉上下相错。心脉当寸脉大尺脉小（即头大本小），今反寸脉小尺脉

大（即头小本大），是上下相错，故名曰“复”。

⑤上微头小：上，指寸部。上微头小，即寸脉微小。

⑥下微本大：下，指尺部。下微本大，即尺脉微大。

⑦关格不通：关，关闭；格，格拒。关格的概念有三：一指脉象，如《素问》六节藏象论说：“人迎与寸口俱盛四倍已上为关格，关格之脉羸，不能极于天地之精气，则死矣。”二指病理，如《素问》脉要精微论说：“阴阳不相应，病名曰关格。”《灵枢》脉度篇说：“阴气太盛，则阳气不能荣也，故曰关；阳气太盛，则阴气弗能荣也，故曰格。阴阳俱盛，不得相荣，故曰关格。”三指病证，如本论指中焦不纳而吐逆、下焦不出为癃闭的一类病证。癃闭者不得尿，故谓之关格不通。

⑧其脉毛浮：《难经》十五难说：“秋脉毛者，肺西方金也，万物之所终，草木华叶，皆秋而落，其枝独在，若毫毛也，故其脉之来，轻虚以浮，故曰毛。”

〔语译〕南方心脉的形象是什么样？老师说：心属火，名叫少阴，其脉洪大而长，是心的平脉。心病自现洪大的脉，容易痊愈。假使脉来微去大，名叫“反”，主病在里；脉来寸小尺大，名叫“复”，主病在表；寸脉微小，则汗出；尺脉微大，则为关格不通，不得小便，无头汗现象的尚可医治，有头汗的多属不治。西方肺脉的形象是什么样？老师说：肺属金，名叫太阴，其脉毛浮。肺病自现这样的脉象或现缓迟脉象，皆容易痊愈。若现数脉，则病将加重。何以知道呢？因为数脉为南方火象，火克西方金，理当肿痛，为难

治之证。

〔提要〕辨心与肺之平脉、病脉及死脉。

〔释义〕心旺于夏，阳气外盛，气血淖溢，故其脉以洪大而长为平。心病现此洪大而长之脉，是心气和，脉有胃气，故曰愈。心脉洪大，其势来盛去衰，若来微去大，是反本脉，故曰“反”，主病在里。如《素问》玉机真藏论说：

“其气来不盛去反盛，此谓不及，病在中。”即此之谓。心脉寸大尺小，若寸小尺大，是上下相错，故曰“复”，乃心气外虚，故曰“病在表也”。若寸脉微小，是心气不足，故汗出。若尺脉微大，是下焦水道闭塞，如《难经》十难所说“心脉微大者，小肠邪自干小肠也”，称为关格不通，故不得尿；若其头无汗者，是阳气未上脱，津液内藏，故曰可治；有汗者，乃阳气脱于上，津液外泄，故曰死。

肺气通于秋，万物收成，草木叶落，枝若毫毛，其气来轻虚以浮，故谓其脉毛浮。肺病得现脉毛浮，是肺气和而有胃气之象；若脉现迟缓，乃从容和缓之谓，是得脾之平脉，所谓土旺生金之象，故曰皆愈。若肺病现数脉，数脉为南方火象，其脉现火克金之象，其病必剧。又因肺主皮毛，数则为热，热壅皮肤留而不去，必生痈肿，所谓“数脉不时，则生恶疮”（辨一21），其病为难治。

〔讨论〕本条承上条，辨心与肺之平脉、病脉及死脉。二条精神实质相同，均旨在阐明脉应四时、五脏而有胃气者为平脉；五脏脉得胃气，即使有病者预后亦良好；若现无胃气之真脏脉，则预后不良。兹将本条所论心、肺脉象归纳如

下:

1. 心脉主病及预后:

心脉	平脉——洪大而长	旺于夏，阳气外盛，气血淖溢之象 心病自得洪大，预后良好
	病脉	脉反——来微去大（反洪脉之来盛去衰），主病在里 脉复——头小本大（反心脉之头大本小），主病在表 上微头小——心气不足，主汗出 下微本大——下焦水道闭塞，关格不通

头无汗可治
头有汗不治

2. 肺脉主病及预后:

肺脉	平脉——脉毛浮	脉气通于秋，万物收成，草木叶落之象 肺病自得此脉，预后良好
	缓迟——肺病见脾脉，土旺生金之象，预后良好	
	数脉——肺脉显火克金之象，主热壅皮肤，必生痈肿	

三、病脉

本节计 8 条。论述了一些主要病脉（如紧、弦、滑、涩、动、结、促、革等单一脉象），其内容包括脉象形态、形成机理及主病等。

〔原文〕问曰：脉有残贼①，何谓也？师曰：脉有弦、紧、浮、滑、沉、涩，此六脉名曰残贼，能为诸脉作病②也。（平—12）

〔校勘〕“此六脉”，成本作“此六者”。本条在《脉经》为：“问曰：脉有残贼，何谓？师曰：脉有弦、有紧、有涩、有滑、有浮、有沉，此六脉为残贼，能与诸经作病。”

〔词解〕

①残贼：伤残，贼害。

②能为诸脉作病：诸脉，各种经脉。作，起、兴起。能为诸脉作病，意指残贼之脉，是人体正气受客邪伤残贼害的脉象，人体正气受到伤害，即发生经脉病变，而表现各种脉象，故曰“能为诸脉作病”。

〔语译〕问：脉有残贼，这说的是什么呢？老师答：脉有弦、紧、浮、滑、沉、涩，这六种脉象名叫残贼，能为各种经脉兴起病端。

〔提要〕脉有残贼。

〔释义〕所谓“脉有残贼”，即指反映人体正气受客邪伤残贼害的脉象。这些脉象就是弦、紧、浮、滑、沉、涩六脉，称为残贼脉。脉浮主邪在表，脉沉主邪在里，弦主气机逆乱，涩主血脉不利，滑主痰火壅实，紧主阴邪为患。此六脉揭示了阴阳、表里、寒热、虚实之疾，经脉病变不出所辖，故谓之“能为诸脉作病也”。

〔讨论〕本条揭示辨脉纲领。不同脉象，是不同病变的反映。然脉象繁多，为便于临床掌握，《内经》、《难经》皆提出了辨脉纲领。如《灵枢》邪气藏府病形篇说：“黄帝曰：色脉已定，别之奈何？岐伯曰：调其脉之缓、急、大、小、滑、涩，而病变定矣。”《难经》四难说：“脉有阴阳之法，何谓也？……浮者阳也，滑者阳也，长者阳也；沉者阴也，短者阴也，涩者阴也。”这是《内经》、《难经》提出的六纲脉。本条提出残贼六脉“能为诸脉作病”亦宗其意。

今通行以浮、沉、迟、数、虚、实六脉为纲，是其发展。其要旨不外教人把握表里、寒热、虚实之辨，凭脉以辨八纲。

〔原文〕问曰：曾为人所难，紧脉从何而来？师曰：假令亡汗，若吐，以肺里寒，故令脉紧也；假令咳者，坐饮冷水，故令脉紧也；假令下利，以胃虚冷，故令脉紧也。（平—21）

〔校勘〕“以胃虚冷”，成本作“以胃中虚冷”。本条在《脉经》为：“问曰：尝为人所难，紧脉何所从而来？师曰：假令亡汗，若吐，肺中寒，故令紧；假令咳者，坐饮冷水，故令紧；假令下利者，以胃中虚冷，故令紧也。”

〔语译〕问：我曾被人所难，紧脉是怎样产生的？老师答：假使大出汗，或呕吐，由于肺内受寒，所以使脉紧；假使咳嗽，不运动而饮冷水，所以也使脉紧；假使下利，由于胃肠虚寒，所以也使脉紧。

〔提要〕紧脉成因。

〔释义〕本条举例说明紧脉的成因，都是因于寒。亡汗是阳衰有寒，呕吐伤胸阳而感寒，皆使肺中受寒，以致脉紧；咳者，饮冷伤肺，以致脉紧；下利者，胃肠虚寒，以致脉紧。文中连用“假令”之语，明确告人不可认定亡汗、若吐、咳、下利一定见紧脉；反之，紧脉并不一定主见上述诸证。

〔讨论〕“诸紧为寒”（平—42），其“寒”有虚实之不同。本条所举诸证，均属虚寒之例。一般实寒证之脉紧较常见，容易

辨识。而虚寒证之脉紧多不为人所辨，故此列举肺气虚寒、中焦虚寒之脉紧以示其例。它如《伤寒论》中太阳伤寒见脉阴阳俱紧（3条），而少阴病亦可见之（283条），均其例。此外，脉紧还有属热者，如阳明里实即可见脉浮紧（200、226条），不可不知。

〔原文〕脉浮而紧者，名曰弦也。弦者，状如弓弦，按之不移也。脉阴者，如转索无常也。（辨一9）

〔校勘〕“脉阴者”，《金匱玉函经》及成本均作“脉紧者”。

〔语译〕脉浮而紧的，名叫弦脉。弦脉状如弓弦，按之不动。紧脉如转索，按之则转动不定。

〔提要〕辨弦脉与紧脉。

〔释义〕弦脉有浮紧之象，故与紧脉相类。“脉浮而紧者，名曰弦。”意在说明弦脉如弓弦之劲急而端直不移的特征，此与紧脉有相似之象，应注意鉴别。然浮紧之脉并非弦脉，弦脉与紧脉是不相同的。弦脉状如弓弦，端直而不移，紧脉形态如转索，按之转动不定。所谓“弦、紧之分，在移与不移耳”。

〔讨论〕本条的意义，如《医宗金鉴》所说：“脉浮而紧者，名曰弦也，此非谓浮紧即弦脉，乃谓浮而劲紧，弦之状也。弦、紧相类，惟恐人将弦作紧，将紧作弦，故并举相形以别之也。弦者状如弓弦，按之不移，即所谓端直也；紧者

如转索无常，即所谓不端直也。端直则不能如转索，转索则不能似端直，其为劲急则同，所以相类也。”可资参考。

原文“脉阴者”，似以《金匱玉函经》及成本作“脉紧者”为妥。

〔原文〕问曰：翕奄沉①，名曰滑，何谓也？师曰：沉为纯阴②，翕为正阳③，阴阳和合，故令脉滑，关尺自平。阳明脉微沉，饮食自可；少阴脉微滑，滑者紧之浮名④也，此为阴实⑤，其人必股内⑥汗出，阴下⑦湿也。（平—20）

〔校勘〕成本无“师曰”二字。本条在《脉经》为：“问曰：翕奄沉，名曰滑，何谓？师曰：沉为纯阴，翕为正阳，阴阳和合，故脉滑也。”

〔词解〕

①翕奄沉：翕（xī），合、聚。奄，忽然。翕奄沉，描述脉体聚而忽沉之态，如转珠之状，故名曰滑脉。

②纯阴：指少阴。

③正阳：指阳明。

④滑者紧之浮名：所谓“滑”，实名为紧而浮。

⑤阴实：指邪实少阴。

⑥股内：大腿内侧。

⑦阴下：阴部。

〔语译〕问：脉体聚而忽沉，名叫滑脉，这说的是什么意思呢？老师答：沉是少阴之象，翕是阳明之象，阴阳和

合，所以使脉滑，关尺部自显和平。若阳明脉微沉，饮食自可，少阴脉微滑，其“滑”实名为紧而浮，这是邪实少阴，其人必大腿内侧出汗，阴部潮湿。

〔提要〕辨滑脉。

〔释义〕脉体聚而忽沉，状如转珠，即是滑脉。纯阴为少阴，是先天之根；正阳为阳明，是后天之本。先天、后天之气阴阳和合，气血充盈，经脉流利，脉体聚而忽沉，如转珠之状，即形成滑脉。关部候后天阳明之气，尺部候先天少阴之气，先后天之气阴阳和合，则关脉、尺脉匀调，故曰“关尺自平”。这是滑脉的和平之象，是气血旺盛的表现，属平脉。原文“阳明脉微沉……”以下，文义费解，注家解释不一，今存疑待考。《医宗金鉴》认为：“滑者紧之浮名，此为阴实二句，与上下之义不属，当是错简。”似为有理。

〔讨论〕本条前段论述了滑脉的形态特征、成因与和平之象，兹分析如下：

1.滑脉的形态特征：本条概括滑脉的形态特征为“翕奄沉”，可谓得其要领。《脉经》描述为“往来前卻流利展转，替替然与数相似。”后世更形象地描述为“往来流利如转珠，应指圆滑”。这些描述都不外是对“翕奄沉”三字的具体发挥，正如王肯堂所说“翕奄沉三字，状得滑字最好。”

2.滑脉成因与和平之象：滑脉有平脉与病脉之分，不可概论为病脉。显和平之象的滑脉属平脉，是气血充盈，经脉流利，“阴阳和合”的征象，其辨识要点为“关尺自平”。

“阳明脉微沉，饮食自可”，据黄竹斋《伤寒杂病论会

通》为“趺阳脉微沉，饮食自平”，以下文均相同，但自“趺阳脉微沉”而列为另条。可为错简说之参考。此段成无己注解：“阳明脉微沉者，当阳部见阴脉，则阴偏胜而阳不足也。阳明胃脉，胃中阴多，故饮食自可。少阴脉微滑者，当阴部见阳脉，则阳偏胜而阴不足也，以阳凑阴分，故曰阴实。股与阴，少阴之部也，今阳热凑阴，必熏发津液，泄达于外，股内汗出而阴下湿也。”可资参考。

〔原文〕问曰：人不饮，其脉何类？师曰：脉自涩，唇口干燥也。（平—8）

〔校勘〕“脉自涩”，成本作“其脉自涩”。

〔语译〕问：人不饮水，其脉象怎样？老师答：脉象自显涩，且口唇干燥。

〔提要〕脉涩主津液不足。

〔释义〕《医宗金鉴》解释说：“津液少则脉涩，唇口因以干燥，此因不饮而然，非由此而不饮也。”盖津液与血相生，亡津液者亡血，亡血者亡津液。今人不饮，津液来源不足，血脉乏津，脉道不利，故见脉涩。肌肤、口唇失其津液滋润，故而唇口干燥。

〔原文〕阴阳相搏①，名曰动。阳动②则汗出，阴动③则发热。形冷恶寒者，此三焦伤也。若数脉见于关上，上下无头尾，如豆大，厥厥动摇④者，名曰动也。（辨—7）

〔词解〕

①阴阳相搏：阴阳之气互相搏击。

②阳动：寸部动脉。

③阴动：尺部动脉。

④厥厥动摇：厥厥，举发貌。厥厥动摇，形容动脉的搏动有根不移。

〔语译〕阴阳之气互相搏击，即形成动脉。寸口脉动，则见汗出；尺中脉动，则见发热。若身冷恶寒，这是三焦受到伤害。动脉与数脉相近，比如关上脉数，但其脉形态如豆大，无头无尾，搏动有根不移，名叫动脉。

〔提要〕辨动脉。

〔释义〕动脉是阴阳之气互相搏击形成的。寸部脉动主阳盛于外，故见汗出；尺部脉动主阴虚内热，故见发热。形冷恶寒，是三焦阳气不能外温分肉的表现。动脉与数脉相近，属于数脉类，若以关部为例描述其特征，则可见关部脉数而上下无头尾，其形态如豆大，动摇有根不移，这是辨识动脉的要领。

〔原文〕脉来缓①，时一止复来者，名曰结。脉来数，时一止复来者，名曰促（赵本注：一作纵）。脉阳盛则促，阴盛则结，此皆病脉。（辨—6）

〔校勘〕“时一止复来者”，《金匱玉函经》均无“者”字。

〔词解〕

①缓：此指脉的至数缓慢。

〔语译〕脉来的至数缓慢，时一止复来的，名叫结脉。脉来数，时一止复来的，名叫促脉。阳盛表现促脉，阴盛表现结脉，这都是病脉。

〔提要〕辨结脉、促脉。

〔释义〕脉来缓中时一止而复来，为结脉。脉来数中时一止而复来，为促脉。可见结脉、促脉皆属间歇脉，且二者都见止无定数，故并举以为鉴别。结脉属迟脉类，一息不足四至；促脉属数脉类，一息在五至以上。促脉主阳盛，结脉主阴盛，都是病脉。

〔原文〕脉弦而大，弦则为减①，大则为芤②；减则为寒③，芤则为虚，寒虚相搏④，此名为革。妇人则半产、漏下，男子则亡血、失精。（辨—10）

〔校勘〕文中所有“则”字，《金匱玉函经》皆作“即”字。“此名为革”，《金匱玉函经》作“脉即为革”。

〔词解〕

①弦则为减：谓脉象举之劲急有力，中取无力，外急中空之象。如《医宗金鉴》说：“弦则为劲，减其中取之劲，外急象也。”

②大则为芤：谓脉大而中空。如《医宗金鉴》说：“脉形粗大有力，谓之大；浮沉有力，中取无力，状如葱管谓之芤”。

③减则为寒：弦减之脉（外急中空）主真阳不足，阳虚则寒。如成无己说：“减则为寒，寒者谓阳气少也。”（《注

解伤寒论》)

④芤则为虚：芤脉主血虚。如成无己说：“芤则为虚，虚者谓血少不足也。”（《注解伤寒论》）

⑤寒虚相搏：寒者真阳不足，虚者精血亏虚。真阳不足而精亏血少，即所谓“寒虚相搏”，这是形成革脉的机理。

〔语译〕脉的形态弦而大，但弦而外急中空，大而中取无力，这是真阳不足、精血亏虚所致，这种脉象就叫做革脉。女子见此脉主流产、崩漏下血，男子见此脉主亡血、失精。

〔提要〕辨革脉。

〔释义〕本条以弦、大、芤三脉来形象地说明革脉的形态及主病。革脉举之劲急粗大有力，这与弦、大脉类似；但按之中空无力，这又似芤脉。真阳不足与精亏血少，是形成革脉的机理。故其主病，在女子主流产、崩漏下血，在男子主亡血、失精。

〔讨论〕本条以弦、大、芤三脉来描述革脉形态，形神毕肖。如《医宗金鉴》说：“脉形粗大有力，谓之大；浮沉有力，中取无力，状如葱管谓之芤；沉而且大，按之劲急有力，谓之牢；浮而且大，举之劲急有力，谓之革。革者，以鼓革而得名，外急中空之象也。弦则为劲，减其中取之劲，外急象也；大则为实，小其中取之实，中空象也，此以弦减、芤虚二脉，形容革脉也。女子得之半产漏下，男子得之亡血失精，寒虚相搏故也。”

从上述诸条可见，仲景论脉形象生动，具体实用，堪为后世典范。

第三章 平脉辨证

本章条文主要讨论如何辨识脉象以推断病情，这是辨脉法、平脉法二篇的主要内容。仲景脉法，以《难经》独取寸口诊法为主，辅用简化的《内经》遍诊法，且其遍诊法实际只诊趺阳和少阴脉。辨脉法、平脉法二篇的诊法亦然。故本章按寸口脉、趺阳脉、少阴脉、趺阳脉与少阴脉合参分节解析。

一、寸口脉

本节计25条。主要论述寸、关、尺三部脉象及主病。观其所论之脉，以相兼脉为主，这与临床实际所见是相一致的。本节条文，具体论述了多种脉象的成因及主病，反映了仲景平脉辨证的特点和规律。

（一）诸脉概说

〔原文〕寸口脉①，浮为在表，沉为在里；数为在府，迟为在藏。假令脉迟，此为在藏也。（辨—18）

〔校勘〕本条在《金匱玉函經》为：“夫寸口脉，浮在表，沉在里，数在府，迟在藏。假令脉迟，此为在藏。”

〔词解〕

①寸口脉：此指寸、关、尺三部脉象。以下不另加注者，均同此。

〔语译〕寸口部脉浮主病在表，脉沉主病在里，脉数主病在腑，脉迟主病在脏。假使寸口脉迟，这就是病在脏。

〔提要〕以脉之浮、沉定病之表、里，以脉之迟、数别病之脏、腑。

〔释义〕正邪相争于表，其脉应之而浮，故脉浮主病在表，如“太阳之为病，脉浮……”（《伤寒论》1条）；正邪相争于里，其脉应之而沉，故脉沉主病在里，如“伤寒四五日，脉沉而喘满，沉为在里……”（《伤寒论》223条）。六腑为阳，其病多阳热之证，如三阳病即是，数脉属阳主热，故六腑为病脉多应之而数；五脏为阴，其病多阴寒之证，如三阴病即是，迟脉属阴主寒，故五脏为病脉多应之而迟。但必须指出，这不过是言其常。临床实际所见脉证是非常复杂的，如程知说：“然伤寒中之传变，亦有数而入藏，迟而入府者，熟读经文自知也。”故此不能概括其变，切忌胶柱鼓瑟。

〔讨论〕本条以浮、沉、迟、数四脉分候表、里、脏、腑之病，具有一定的理论和实际指导意义，至今仍为医家所宗。但以迟、数别脏、腑之疾，究其实质不出寒、热之辨。正如《难经》九难所说：“何以别知脏腑之病耶？然：数者，腑也；迟者，脏也。数则为热，迟则为寒。诸阳为热，诸阴为寒。故以别知脏腑之病也。”因此，本条以浮、沉、

迟、数别表、里、脏、腑之病，实质为表、里、寒、热之辨，堪称八纲辨证的范例。关于如何认识本条所论之常与变的关系，程知之说堪称中的。

〔原文〕问曰：何以知乘腑①？何以知乘脏②？师曰：诸阳③浮、数为乘腑；诸阴④迟、涩为乘脏也。

（平—44）

〔词解〕

①乘腑：病邪侵犯六腑。

②乘脏：病邪侵犯五脏。

③诸阳：概指阳脉。

④诸阴：概指阴脉。

〔语译〕问：怎样知道病邪侵犯六腑和五脏呢？老师答：凡是阳脉，如浮、数脉，主病邪侵犯六腑；凡是阴脉，如迟、涩脉，主病邪侵犯五脏。

〔提要〕概论病邪入腑、入脏之脉象。

〔释义〕六腑属阳，为表，病多阳证，故其病多为诸阳脉所主，如浮、数脉等。五脏属阴，为里，病多阴证，故其病多为诸阴脉所主，如迟、涩脉等。本条精神内容与上条（辨—18）相同，亦承《难经》九难之说。但此也是概言一般，实际病情错综复杂，脉象随之多变，切不可机械执一。

〔原文〕寸口诸微亡阳，诸濡亡血，诸弱发热，诸紧为寒。诸乘寒者①，则为厥，郁冒不仁②，以胃

无谷气③，脾涩不通④，口急⑤不能言，战而慄⑥也。

(平—42)

〔词解〕

①乘寒者：受寒邪侵袭的患者。

②郁冒不仁：郁冒，昏瞢。不仁，无知觉。

③胃无谷气：谷气，水谷之气（水谷精微）。胃为水谷之海，生化之源，以谷气为本。胃无谷气，即胃气虚弱，谷气不充。

④脾涩不通：指脾虚失运。

⑤口急：口唇紧急。

⑥战而慄：恶寒战抖。

〔语译〕凡寸口脉微多主亡阳，脉濡多主亡血，脉弱多主发热，脉紧多主寒。凡受寒邪侵袭者，则可发生厥逆，昏瞢而无知觉，这是因为胃气虚弱而谷气不充，脾虚失运，故口唇紧急不能说话，恶寒战抖。

〔提要〕概论微、濡、弱、紧等脉主病。

〔释义〕成无己注曰：“卫，阳也。微为卫气微，故云亡阳。荣，血也。濡为荣气弱，故云亡血。弱为阴虚，虚则发热。紧为阴胜，故为寒。诸乘寒者，则阴阳俱虚，而为寒邪乘之也。寒乘气虚，抑伏阳气不得宣发，遂成厥也。郁冒，为昏冒不知人也。不仁，为强直而无觉也。为尸厥焉。以胃无谷气，致脾涩不通于上下，故使口急，不能言。战者，寒在表也，慄者，寒在里也。”（《注解伤寒论》）可供领会本条义理参考。成氏对“诸微亡阳，诸濡亡血”的阐

释，可以说是根据平脉法22条“卫气弱，名曰慄；荣气弱，名曰卑”（参见第一章“平脉总则”）的精神。而《医宗金鉴》则认为：“濡，浮而无力，候阳虚也，岂有亡血之理？弱，沉而无力，候阴虚也，岂止发热而已？”言之亦有理。说明一脉可主多病，不可囿于成见。现今以脉微主阴阳气血诸虚，脉濡主虚、主湿，脉弱主气血不足，脉紧主寒、主痛、主宿食，即应当本此精神来认识。

〔讨论〕

1. 关于“诸乘寒者则为厥”：感受寒邪为患，并非都见厥证，故不可囿于“诸乘寒者则为厥”。引起厥证的病因很多，病机复杂。如《素问》生气通天论记载有煎厥、薄厥，缪刺论记载有尸厥，厥论记载有寒厥、热厥以及六经脉之厥等。《伤寒论》337条说：“凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷者是也。”指出无论何种厥证，及其成因有何不同，但都以阴阳失调，即所谓“阴阳气不相顺接”为基本病机。成无己认为，本条所谓“诸乘寒者则为厥”系尸厥。从厥而郁冒不仁来看，似类尸厥。“诸乘寒者则为厥”，指出此尸厥的病因是感受寒邪，寒邪客于“手足少阴太阴足阳明之络”使然。“以胃无谷气，脾湿不通”，又揭示了受寒袭而为尸厥的内因。如《医宗金鉴》所说：“以平日胃虚损谷，脾虚不运，中虚不胜外邪也。”脾胃内虚，气血失其生化之源，阳虚血少，更遇寒邪侵袭，客于手足少阴、太阴、足阳明脉络，致阴阳、气血逆乱，发为昏脊厥逆，表现郁冒不仁、口急不能言、战而慄等尸厥之候。

2.寸口脉源于脾胃：原文“以胃无谷气，脾涩不通”，还揭示了寸口脉源于脾胃的基本原理。脉象是荣卫气血在经脉中运行搏动的外部征象。胃为水谷之海，乃荣卫气血生化之源；脾主运化，为胃行其精气。五脏六腑皆禀气于脾胃，得胃气之助而变现于寸口（或称气口）。如《素问》奇病论说：“夫五味入口，藏于胃，脾为之行其精气……”。《素问》痹论说：“岐伯曰：荣者，水谷之精气也，和调于五藏，洒陈于六府，乃能入于脉也，故循脉上下，贯五藏，络六府也。卫者，水谷之悍气也，其气慄疾滑利，不能入于脉也，故循皮肤之中，分肉之间。熏于盲膜，散于胸腹……”。

《灵枢》五味篇说：“胃者，五藏六府之海也，水谷皆入于胃，五藏六府皆禀气于胃……”。《素问》五藏别论说：

“帝曰：气口何以独为五藏主？岐伯曰：胃者，水谷之海，六府之大源也。五味入口，藏于胃以养五藏气，气口亦太阴也。是以五藏六府之气味，皆出于胃，变见于气口（寸口）。”综上所述，说明寸口脉与脾胃的功能有着密切关系，所以说寸口脉源于脾胃。脾胃虚弱，水谷运化无权，即所谓“胃无谷气，脾涩不通”，则寸口即可表现“诸微亡阳，诸濡亡血，诸弱发热，诸紧为寒”等病脉。

〔原文〕问曰：脉有阳结①、阴结②者，何以别之？答曰：其脉浮而数，能食，不大便者，此为实，名曰阳结也，期十七日当剧；其脉沉而迟，不能食，身体重，大便反鞕，名曰阴结也，期十四日当剧。

(辨—2)

〔校勘〕本条在《金匱玉函經》为：“问曰：脉有阳结、阴结者，何以别之？答曰：其脉自浮而数，能食，不大便，名曰阳结，期十七日当剧，其脉自沉而迟，不能食，身体重，大便反坚，名曰阴结，期十四日当剧。”

〔词解〕

①阳结：阳热壅滞致腑气闭结的病证。

②阴结：阴寒内结致阳不化阴的病证。

〔语译〕问：脉象有阳结脉、阴结脉，如何分别呢？答：阳结脉浮而数，证见能食，大便秘结，这是实证，名叫阳结，等到十七日病当加重；阴结脉沉而迟，证见不能食，身体重，大便反坚硬，名叫阴结，等到十四日病当加重。

〔提要〕辨阳结与阴结脉证及预后。

〔释义〕阳结病机为阳热内盛，故其脉应之而浮数，阳能消谷，故能食；阳热壅滞，腑气闭结，阴不济阳，故大便秘结，其证属实。阴结病机为阴寒内结，故其脉应之而沉迟，阴盛阳虚，中阳失运，故不能食而身重；阴寒内结阳不化阴，故大便反硬。关于阳结“期十七日当剧”，阴结“期十四日当剧”，仅宜作临床参考，不可拘泥。

〔讨论〕关于阳结与阴结“当剧”之期的推断，注家主要有两种解释。其一，根据六经的传经日期来解释：阳结“期十七日当剧”，是经行三周而值少阴主气之期，阳结属阳热证，得少阴之阴气济之可解，若病不解，可知阳结太甚，故病将加剧；阴结“期十四日当剧”，是经行三周而值

阳明主气之期，阴结属阴寒证，得阳明之阳气济之可解，若病不得解，可知阴结太甚，故病将加剧。其二，根据“阳数七，阴数六”来解释：十七日为阴旺三期，其阳结不解，说明孤阳独亢，故病必加剧；十四日为阳旺二期，其阴结不解，说明孤阴独盛，故病必加剧。以上两种解释，立论虽异，但其精神则同，皆认为阳结当得阴而解，阴结当得阳而解，阴阳和调，其病乃愈；若当愈而不愈，则其病必加剧。至于十七日、十四日之谓，但当领会其精神实质，不可拘泥，更无须究其三传、两传之说。

阳结与阴结都以大便秘结为主要特点，但其病机有阳热与阴寒之别，脉象有浮数与沉迟之异，证候有能食与不能食之殊，其治法则自当不同，示人脉证合参以辨证论治之例。如章虚谷说：“脉浮而数，能食者，此阳偏亢而结实为滞，可用疏利开结之法也；脉沉迟者，阴胜阳虚，故不能食而身体重，以阴性重浊也。夫津液由阳气蒸化水谷以生者，阳虚而饮食不进，津液不生，则肠枯燥而大便艰，此当补阳以生阴，非可通利以开结也。俗学闻大便艰结，即认为火，而用凉泻，杀人而不知其故，所以仲景特标有阴阳虚实之亢异也。”可资参考。

〔原文〕脉（赵本注：一云秋脉）蔼蔼如车盖①者，名曰阳结也；脉（赵本注：一云夏脉）累累如循长竿②者，名曰阴结也。脉瞥瞥如羹上肥③者，阳气微也；脉萦萦如蜘蛛丝④者，阳气（赵本注：一云阴气）衰

也。脉绵绵如泻漆之绝⑤者，亡其血也。（辨一5）

〔校勘〕“车盖”，《金匱玉函经》作“车盖”。“脉累累”，成本及《金匱玉函经》均作“脉累累”。“名曰阴结也”后，《金匱玉函经》还有一句“脉萁萁如吹榆莢者，名曰散也。”“阳气微也”，《金匱玉函经》作“阳气脱也”。“脉紫紫”，成本作“脉紫紫”。《脉经》载本条不全：“寸口脉激激如羹上肥，阳气微；连连如蜘蛛丝，阴气衰。”赵本之注“一云阴气”衰，似可能据此。

〔词解〕

①脉蔼蔼如车盖：蔼蔼(ǎi ǎi)，树木繁茂的意思。此形容阳结脉象如车之篷盖一样，于浮数中而有上拥洪实之象。

②脉累累如循长竿：累累(léi léi)，连续成串的意思。此形容阴结脉象如摸到竹竿一样，于沉迟中而有连连不断的弦硬之象。

③脉臂臂如羹上肥：臂臂(piē piē)胥现，形容肉汤上漂浮的浮油貌。羹(gēng)，指肉汤。肥，指油脂。此形容阳气微的脉象轻浮，如肉汤上漂浮的浮油一样。

④脉紫紫如蜘蛛丝：紫，即紫(yīng)；紫紫，旋绕的意思。此形容阳气衰的脉象微细，如旋绕的蜘蛛丝一样细微难寻。

⑤脉绵绵如泻漆之绝：绵绵，连绵柔软的意思。此形容亡血的脉象空虚，如泻漆将尽一样，前大后细而连绵柔软，空虚无力。

〔语译〕脉象如车之篷盖一样，于浮数中而有上拥的洪

实之象，名叫阳结脉；脉象如摸竹竿一样，于沉迟中而有连连不断的弦硬之象，名叫阴结脉。脉象虚浮，如肉汤上漂浮的浮油一样浮泛无力，主阳气微；脉象微细，如旋绕的蜘蛛丝一样细微难寻，主阳气衰。脉象空虚，如泻漆将尽一样，前大后细而连绵柔软无力，主失血。

〔提要〕形象描述阳结、阴结、阳微、阳衰及亡血的脉象特征。

〔释义〕本条以具体生动的形象比喻来描述脉象特征，绘声绘色，形神活现，启后世脉学之门径。“蔼蔼如车盖”，形象描述了阳结脉浮数而洪实的特征。阳结为阳热壅“滞腑气闭结的阳热实证，故脉象于浮数中而显洪实之象。累累如循长竿”，形象描述了阴结脉沉迟而显弦硬的特征。阴结为阴寒内结阳不化阴的阴寒实证，故脉象于沉迟中而显弦硬之象。“瞥瞥如羹上肥”，形象描述了阳气微者脉象虚浮的特征。阳气微则卫气不足，脉来不及，所谓“卫气弱，名曰慄”（平一22），故脉象虚浮而浮泛无力。“萦萦如蜘蛛丝”，形象描述了阳气衰者脉象微细的特征。阳气衰为阳气极虚，脉来不足至甚，如《素问》脉要精微论说：“细则气少”，故脉象如旋绕的蜘蛛丝一样细微难寻。“绵绵如泻漆之绝”，形象描述了亡血者脉象空虚的特征。亡血则荣血亏虚，血脉不充，故脉象如泻漆将尽一样，前大后细而连绵柔软，空虚无力。

〔讨论〕据赵本注，脉萦萦如蜘蛛丝者当为“阴气”衰。如上述，“脉萦萦如蜘蛛丝”是对脉微细的形象描述。

实则脉微细乃阳气、阴血双亏的脉象。阳气衰微，鼓动无力，故脉微；阴血不足，脉道不充，则脉细。如“少阴之为病，脉微细，但欲寐也。”（《伤寒论》281条）即其例。据一脉主多病之理，赵本注“一云阴气”亦可为一说。

〔参考〕《难经》六难说：“脉有阴盛阳虚，阳盛阴虚，何谓也？然：浮之损小，沉之实大，故曰阴盛阳虚。沉之损小，浮之实大，故曰阳盛阴虚。是阴阳虚实之意也。”

（二）浮数脉

〔原文〕脉浮而数，浮为风①，数为虚②，风为热③，虚为寒④，风虚相搏⑤，则洒淅恶寒⑥也。

（辨—32）

〔校勘〕“浮为风，数为虚，风为热，虚为寒”，《金匱玉函经》在四个“为”字前均有“即”。“则洒淅恶寒也”，《金匱玉函经》作“则灑淅恶寒而发热也。”

〔词解〕

①浮为风：风寒外袭皮毛，正邪相争于表，脉应之而浮，故曰“浮为风”。风，概指风寒之邪。

②数为虚：此脉“数”是风寒束表卫阳被郁而肌表热盛，即所谓“表热”盛，非有形实热为患，故曰“数为虚”。

③风为热：风寒袭表，卫阳与之相争，遂见发热，故曰“风为热”。

④虚为寒：风寒束表卫阳被郁，卫气不温分肉，遂见洒淅恶寒，故曰“虚为寒”。

⑤风虚相搏：指风寒袭表卫气与之相争而发热，肌表失于温煦而恶寒的病机。

⑥洒淅恶寒：洒淅（sǎxī），冷水浇身之状。此形容恶寒的状态如冷水浇身一样，瑟瑟颤抖。

〔语译〕脉象浮数，浮主风寒之邪外袭皮毛，数是卫阳被郁肌表热盛，风寒袭表卫阳与之相争遂发热，肌表失于卫阳温煦遂恶寒，风寒外袭而肌表失于卫阳温煦，即见如冷水浇身一样的恶寒表现。

〔提要〕论外感风寒表证脉浮数与洒淅恶寒的机理。

〔释义〕本条指出，脉浮数亦可见于外感风寒表证。文中所言“风”，当从风寒理解。发热而洒淅恶寒，是外感风寒表证热型，何以脉浮数？风寒袭表，卫阳抗邪于外，故脉应之而浮，即所谓“浮为风”。若风寒束表，卫阳被郁，郁阳化热，致肌表热盛，则可见脉浮数，但此非实热为患，故强调“数为虚”。其“风为热”，则又是指卫阳与风寒之邪相争发热而言。风寒束表，卫气不温分肉，则见恶寒，即所谓“虚为寒”。风寒袭表卫阳与之相争而发热，肌表失于温煦而恶寒，这是外感风寒表证恶寒发热的基本病机，即所谓“风虚相搏”。

〔讨论〕表寒证脉浮紧，表热证脉浮数。本条指出，脉浮数亦可见于表寒证。何以言之？表寒证脉浮紧与表热证脉浮数，是言其常；而表寒证脉浮数，是言其变。风寒束表，卫阳被遏，以致肌表热盛，脉象即应之而浮数。但此肌表热盛乃卫阳被遏所致郁阳之热，其病机仍为风寒束表，故其证候

仍为表寒证，虽见脉浮数而不得认为是表热证，治疗仍当用辛温解表之法。《伤寒论》谓“脉浮而数者，可发汗，宜麻黄汤。”（52条）即其例。

本条对脉浮数与发热而洒淅恶寒机理的分析，教人分析脉理的一般方法。对“浮为风，数为虚，风为热，虚为寒”不可割裂开来理解，必须结合起来认识，所谓“风虚相搏”之义即在此。文中分别而言，是为分析说明问题的需要。从中可以看出，仲景时对相兼脉象的认识，即是通过对其组成脉象的分析而加以综合概括的。

〔原文〕诸脉浮数，当发热而洒淅恶寒。若有痛处，饮食如常者，畜积有脓也。（辨一27）

〔校勘〕“饮食如常者”，《金匱玉函经》作“食饮如常者”。《脉经》载本条为：“诸浮数脉，应当发热，而反洒淅恶寒，若有痛处，当发其痈”。

〔语译〕凡脉浮数，应当有发热和如冷水浇身一样的恶寒症状。如果身体有疼痛处，饮食和平常一样的，这是有痈疡酿脓的表现。

〔提要〕脉浮数主痈疡之候。

〔释义〕如上条（辨一32）所说，脉浮数多见于表证，或表热，或表寒，都可见发热而洒淅恶寒。风寒表证除见脉浮数外，还应见头项强痛、体痛、身疼、腰痛或骨节疼痛等症状。如果身体局部有痛处，饮食正常，则应当考虑是否有痈疡，不可认为是表寒证。

〔讨论〕本条指出，风寒表证与痈疡在脉证上有类似之处，临证当注意鉴别。特别是痈疡在成脓期，亦有发热恶寒，或憎寒壮热，脉浮数的表现，决不可认为是风寒表证，以免误用辛温发汗而致变。“若有痛处，饮食如常者”，指出了痈疡与风寒表证的鉴别要点。兹归纳如下表所示：

病证	风 寒 表 证	痈 疡
类似脉证	脉浮数，发热而洒淅恶寒	脉浮数，发热而洒淅恶寒，或憎寒壮热（成脓期）
鉴别要点	头项强痛，体痛，身疼腰痛，骨节疼痛，无汗，呕逆、或干呕	若有痛处（局部红肿热痛），饮食如常（无呕逆等证）

本条指出脉浮数还可见于痈疡证，其成脓期可见与风寒表证类似的发热恶寒的临床表现，应当注意鉴别。

（三）浮紧脉

〔原文〕寸口脉浮而紧，浮则为风①，紧则为寒②，风则伤卫③，寒则伤荣④，荣卫俱病⑤，骨节烦疼，当发其汗也。（辨一20）

〔校勘〕文中诸“则”字，《金匱玉函经》皆作“即”。“寸口脉”，《脉经》无“寸口”二字。“当发其汗也”，《脉经》作“可发其汗，宜麻黄汤”。

〔词解〕

①浮则为风：风寒犯表，脉应之而浮，故曰“浮则为

风”。风，概指风寒。

②紧则为寒：风寒束表，脉象应之而紧，故曰“紧则为寒”。寒，概指风寒。

③风则伤卫：风寒束表，卫阳被遏，故曰“风则伤卫”。

④寒则伤荣：寒凝经脉，荣阴郁滞，故曰“寒则伤荣”。

⑤荣卫俱病：风寒袭表，卫阳被遏，荣阴郁滞，故曰“荣卫俱病”。

〔语译〕寸口脉浮而紧，浮为风寒犯表，紧为风寒外束，风寒束表则卫阳被遏，寒凝经脉则荣阴郁滞，荣气和卫气都发生病变，骨节疼痛而烦，应当用发汗来治疗。

〔提要〕论太阳伤寒表实脉浮紧机理及治则。

〔释义〕脉浮紧，主太阳伤寒表实证。如《伤寒论》3条说：“太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名为伤寒。”风寒束表，卫阳被遏，荣阴郁滞，太阳经脉不利，经气运行不畅，故脉象应之浮紧，并见骨节疼痛而烦等证。治当辛温解表，用汗法，可用麻黄汤。

〔讨论〕“浮则为风，紧则为寒，风则伤卫，寒则伤荣，荣卫俱病”，旨在阐明脉浮紧主外感风寒表实的机理。其说理虽分别风与寒，但其意义则不可割裂。风与寒不宜截然划分，更不可凿分风伤卫、寒伤荣、风寒两伤荣卫。仲景对脉理的分析，特别是对相兼脉主病机理的分析均同此，不可不知。后世一些注家，尤其是以方有执为代表的错简派诸家，将风伤卫、寒伤荣、风寒两伤荣卫截然分开，如方有执据此把太阳篇分为“卫中风”、“营伤寒”、“营卫俱中伤风

寒”三篇，形成了所谓太阳病的“三纲鼎立”说，未免有违原义。如张隐庵说：“后人不参旨意，谓风必伤卫，寒必伤荣，欲以一言而该全论，不思寒亦可伤卫，风亦可伤荣，不思既在荣卫，何以复病骨节，既病骨节，何以复当发汗，只袭糟粕而违圣理，致本论终于蒙蔽也。”

再者，本条所论“脉浮而紧”，是浮与紧的相兼脉。这与“脉浮而紧者，名曰弦也”（辨一9）所说的弦脉有浮紧之象不同，必须加以区别。

（四）浮大脉

〔原文〕脉浮而大，心下①反鞣，有热属藏②者，攻之③，不令发汗；属府④者，不令溲数⑤，溲数则大便鞣。汗多则热愈，汗少则便难；脉迟尚未可攻⑥。

（辨一23）

〔校勘〕“心下反鞣”与“溲数则大便鞣”，其“鞣”字在《金匱玉函经》及《脉经》均作“坚”。“汗少则便难”，《金匱玉函经》作“汗少即便难”。

〔词解〕

①心下：此指胃脘部。

②藏：此代表“里”，非指五脏。

③攻之：概指祛邪治法。

④府：此代表“表”，非指六腑。

⑤溲数：此指利小便的治法。

⑥尚未可攻：尚，还（hái）。未，不。尚未可攻，还

不可攻。

〔语译〕脉浮而大，心下反而硬满，有热属里的，用攻法治疗，不可用发汗的方法；属表的，不可使用利小便的治法，小便多则大便硬。出汗多则热随汗泄而愈，出汗少则大便难，脉迟的还不可用攻法。

〔提要〕脉浮大与发汗和利小便的宜忌。

〔释义〕脉浮大，主热盛于表，不应见心下硬之证，今见心下硬，故曰“反”，若证属里热，则治疗当用清泄之法，即所谓“攻之”，不可概以脉浮大主表而用汗法，若虽心下硬，而仍见表热，又不可以为饮结而利小便，小便数则津液偏渗膀胱，必大便硬，治疗可用发汗解表，或表里双解法。“汗多则热愈，汗少则便难”，是指阳热炽盛的两种转归：热炽于内，若汗出多者，热随汗泄，故曰热愈；若汗出少者，邪热不得外泄，热灼津伤，必致燥热内结，故大便难。热结便秘，法当攻下，但脉迟里虚或表未解者，又不可妄用攻下。

〔讨论〕本条揭示了三个重要问题：

1. 误用发汗与利小便致伤津化燥：按原文分析如下：

脉浮大 (有力)	{	心下反硬，有热属藏	治则：攻之（清泄里热）
		（邪热在里）	治禁：不冷发汗（误汗必伤津化燥）
		（“本先下之而反汗之，为逆，若先下之，治不为逆”——《伤寒论》92条）	
		有热属府	治则：（解表，可汗之）
		（邪热在表）	治禁：不令洩数，洩数则大便难（津液偏渗膀胱）
		（“本发汗而复下之，此为逆也，若先发汗，治不为逆”——《伤寒论》92条）	

以上在《伤寒论》中不乏其例。如186条：“问曰：何缘得阳明病？答曰：太阳病，若发汗，若下，若利小便，此亡津液，胃中干燥，因转属阳。不更衣，内实，大便难，此名阳明也。”说明太阳表证汗不如法、误下、误利小便，伤津化燥成实，大便难，转属阳明病。关于小便与大便的关系，小便数即“小便利，尿定鞭”（253条），所谓“津液偏渗于膀胱”，故小便频数，肠中干燥，大便因鞭；小便少者，“以津液当还入胃中”（208条），则大便必利。

关于“攻之”，不宜专指攻下，以概指清泄祛邪之法为妥。因“心下反鞭”，在不可下之例者不少。《伤寒论》中即告诫：“阳明病，心下鞭满者，不可攻之……”说明病邪偏上，尚未入腑成实，不可攻下。如林澜说：“心下鞭与腹鞭满不同，腹鞭邪已结聚成实，此但在心下，自与非下不可者异矣。府与藏对举而言，见一为入里，一犹属表之义也。”

2. 阳热炽盛转归：“汗多则热愈，汗少则便难”，指出了阳热炽盛的两种转归：

阳热炽盛转归 { 汗多——热愈（热随汗泄而解）
汗少——便难（热炽津伤成实）

《灵枢》五癯津液别篇说：“天暑衣厚则腠理开，故汗出。”这是人体为适应外界高热环境而通过出汗排热的生理机能。在病理情况下，热迫津泄，汗出加甚，邪热随之外泄，这是阳热发泄的特征。《素问》生气通天论说：“体若燔炭，汗出而散”；《素问》热论说：“暑当与汗皆出，勿止。”均明确指出了在阳热炽盛的情况下，汗出泄热的原理。若汗

出少，邪热内闭，必致热灼津伤成实，而见大便难。这里必须指出，阳热炽盛虽有汗出热泄的转归，但汗出同时亦能耗伤津液。如《伤寒论》所说：“阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必鞕，鞕则谵语……”（218条）这又指出了多汗伤津的原理，示人热病存津液的要义。因此，阳热炽盛者急当以清泄邪热为法，不可坐待“汗多则热愈”。

3. 脉迟慎攻下：脉迟有虚实之别，还有缓迟之异。所谓“脉迟尚未可攻”，主要指脉迟属虚者、或表未解者。如《伤寒论》200条：“阳明病，脉迟，食难用饱……虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。”这是阳明中寒证；故当禁下，其脉必迟而无力。236条：“阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤。”此为阳明兼表之证，也在不可下之例，其脉迟必显迟缓之象。以上说明“脉迟尚未可攻”。若里实已成，脉迟而有力者，则可议下。如213条：“阳明病，脉迟，虽汗出，不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也，手足濇然汗出者，此大便已鞕也，大承气汤主之……”即为脉迟可下之证。

〔原文〕寸口脉浮大，而医反下之，此为大逆①。浮则无血②，大则为寒③，寒气相搏④，则为肠鸣。医乃不知，而反饮冷水，令汗大出，水得寒气⑤，冷必相搏⑥，其人即餧⑦。（辨—25）

〔校勘〕《金匱玉函经》该条“而医反下之”一句，无“而”字，“而反饮冷水”一句，作“而反饮之水”，诸“则”

字，均作“即”。《脉经》该条“而反饮冷水”一句，作“而反饮水”，余皆同《金匮玉函经》。

〔词解〕

①大逆：逆，此指医疗错误。大逆，大的医疗错误。

②浮则无血：此谓血虚而阳浮在外的脉象，故曰“浮则无血”。

③大则为寒：此谓脉大因于阳浮而中寒，故曰“大则为寒。”

④寒气相搏：即阴寒之邪与阳气相争。

⑤水得寒气：指饮入的冷水与体内阴寒之气相遇。

⑥冷必相搏：冷水与里寒相互搏激。

⑦飧：音义同噎（yē），气逆噎塞之义。其症类哕，但哕有声，较重；飧无声，较轻。

〔语译〕寸口脉浮大，医生不详究其原因，误用下法，这是很大的医疗错误。因其脉浮大是血虚而阳浮在外的脉象，阳浮则脉大，寒邪乘虚内客胃肠，阴寒之邪与阳气相争，就发生肠鸣。医生不明其理，反而给饮冷水，使汗大出，饮入的冷水与体内阴寒之气相遇，相互搏激，病人即发生气逆噎塞的变证。

〔提要〕亡血阳浮脉浮大者禁汗、下。

〔释义〕脉浮大，有虚实不同。上条（辨—23）为实，其脉浮大有力，主阳热炽盛，治疗当“攻之”。本条脉浮大属虚，必按之无力，是亡血阳浮之象。荣血亏虚，阴不恋阳，阳气虚浮于外，故脉应之浮大。脉似有余而实不足，治

疗应当以补中祛寒为法，方如当归建中汤之属，禁用攻下之法。若医生不审虚实，误认为里有实热而反下之，致犯虚虚之戒，故曰“大逆”。阳浮于外，寒邪乘虚内客胃肠，阴寒之邪与阳气相争，即发生肠鸣。所谓“肠中寒，则肠鸣飧泄”

（《灵枢》师传篇）。医生不察其为里寒，反而给饮冷水，使汗大出，阳气更虚，饮入的冷水与体内阴寒之气相遇，互相搏激，以致气失升降，而致气逆噎塞，即所谓“衄”。治疗可用和胃降逆之法，旋复代赭汤之属可据证选用。

〔讨论〕以上辨脉法23条与25条，均论脉浮大，前主阳热炽盛而属实（23条），后主亡血阳浮而属虚（25条）。其脉象虚实之辨全在有力与无力，临证当细心体会，并结合脉证详参，方不致误。

〔参考〕《灵枢》口问篇说：“黄帝曰：人之哕者，何气使然？岐伯曰：谷入于胃，胃气上注于肺。今有故寒气与新谷气，俱还入于胃，新故相乱，真邪相攻，气并相逆，复出于胃，故为哕。”

《素问》三部九候论说：“帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以调其气之虚实，实则泻之，虚则补之。必先去其血脉而后调之，无问其病，以平为期。”《难经》十二难说：“阳绝补阴，阴绝补阳，是谓实实虚虚，损不足益有余。如此死者，医杀之耳。”

〔原文〕寸口脉浮而大，浮为虚①，大为实②，在尺为关③，在寸为格④，关则不得小便⑤，格则吐逆⑥。

(平—25)

〔词解〕

①浮为虚：借脉象说明病机，即谓此脉浮是因于正气虚。

②大为实：亦借脉象说明病机，即谓此脉大是因于邪气实。

③在尺为关：尺，尺脉。关，关闭，指不得小便之证。在尺为关，脉浮大在尺部主不得小便之关证。

④在寸为格：寸，寸脉。格，格拒，指吐逆之证。在寸为格，脉浮大在寸部主吐逆之格证。

⑤关则不得小便：关证主见小便不通。

⑥格则吐逆：格证主见吐逆。

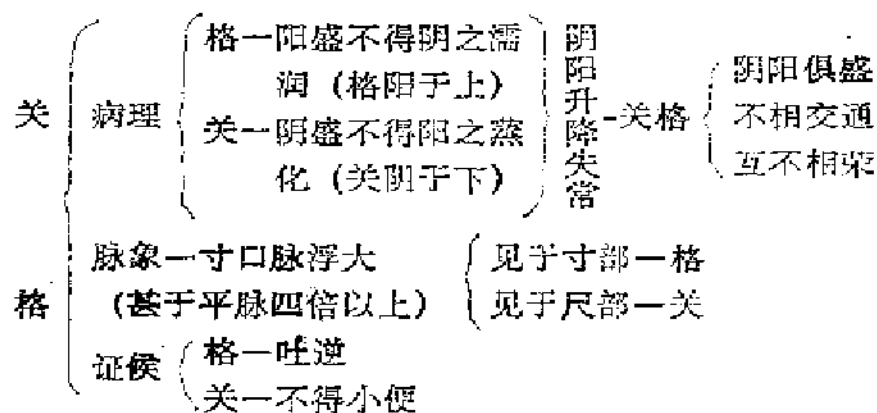
〔语译〕寸口脉浮而大，浮因正气虚，大因邪气实，尺部脉浮大主关证，寸部脉浮大主格证，关证主见小便不通，格证主见吐逆。

〔提要〕脉浮大主关格。

〔释义〕关格之证，为阴阳俱盛，互不相荣形成，是阴阳升降失常的病证。本条借脉象以说明关格之正虚邪实的病机和主证。尺为阴，候下焦病。尺脉浮大，是正虚而阴邪实于下。阴气不能上交，关阴于下而不得阳气蒸化，邪气闭阻下焦，气化不通，故主见不得小便，名曰“关”。寸为阳，候上焦病。寸脉浮大，是正虚而阳邪实于上。阳气不能下交，格阳于上而不得阴液之资，邪气格拒上焦，食不得入，故主见吐逆，名曰“格”。

〔讨论〕“关格”名称出《内经》与《难经》，主要论关格的脉象和病理概念。本论之“关格”为病证名，指小便不通与吐逆并见的病证（参见第二章平脉与病脉“平脉法13条”词解）。小便不通名“关”，吐逆不已名“格”，概称关格。其病实为癃闭的严重阶段，以小便不通为主要临床表现，且常并见吐逆不已，故多概称关格。后世有的医家所说之“关格”与本论有所不同，如《诸病源候论》以大便不通名“内关”，小便不通名“外格”，大小便都不通名“关格”；《医醇腋义》以呕吐而渐致大小便不通者名“关格”，此实系噎膈的严重阶段。

本论对关格的认识，与《内经》和《难经》是一脉相承的。本论以《内经》和《难经》关于关格的脉象和病理概念为基础，与临床相结合，确立了关格的病名概念。兹将《内经》、《难经》和本论对关格的认识小结如下：



〔参考〕《灵枢》脉度篇说：“阴气太盛，则阳气不能荣也，故曰关。阳气太盛，则阴气弗能荣也，故曰格。阴阳俱盛，不得相荣，故曰关格。关格者，不得尽期而死也。”《难

《灵枢》三十七难说：“阴气太盛，则阳气不得相荣也，故曰格。阳气太盛，则阴气不得相荣也，故曰关。阴阳俱盛，不得相荣也，故曰关格。关格者，不得尽其命而死矣。”以上《灵枢》与《难经》对关与格病理的认识似相反，实则是从阴阳的不同角度而言，其实质是相同的。《灵枢》指出，阴气太盛，阳气不能下荣，以致关阴于下，故谓之关；《难经》则指出，如阳气太盛，也能使阴气不能正常运行，以致关阴于下，故亦谓之关。因此，无论阴气太盛还是阳气太盛，凡致关阴于下者皆谓之关。同理，《灵枢》指出阳气太盛，阴气不能上荣，以致格阳于上，谓之格；《难经》则指出阴气太盛也能使阳气不能正常运行，以致格阳于上，亦谓之格。据此，无论阳气太盛还是阴气太盛，凡致格阳于上者皆谓之格。所以二者都指出：“阴阳俱盛，不得相荣，故曰关格。”正是《素问》脉要精微论所说：“阴阳不相应，病名曰关格。”

《素问》六节藏象论说：“故人迎一盛病在少阳……四盛已上为格阳。寸口一盛病在厥阴……四盛已上为关阴。人迎与寸口俱盛四倍已上为关格，关格之脉羸，不能极于天地之精气，则死矣。”《灵枢》终始篇说：“人迎四盛，且大且数，名曰溢阳，溢阳为外格。……脉口四盛，且大且数者，名曰溢阴，溢阴为内关，内关不通，死不治。人迎与太阴脉口俱盛四倍以上，命曰关格。关格者，与之短期。”《难经》三难说：“脉有太过，有不及，有阴阳相乘，有复有溢，有关有格，何谓也？然：关之前者，阳之动也，脉当见九分而浮，过者，法曰太过；减者，法曰不及。遂上鱼为溢，为外

关内格，此阴乘之脉也。关以后者，阴之动也，脉当见一寸而沉，过者，法曰太过；减者，法曰不及。遂入尺为复，为内关外格，此阳乘之脉也。故曰复溢，是其真脏之脉，人不病而死也。”

〔原文〕脉浮而大，浮为风虚①，大为气强②，风气相搏③，必成隐疹④，身体为痒，痒者名泄风⑤。久久为痲癩⑥（赵本注：眉少、发稀，身有干疮而腥臭也）。（平—27）

〔校勘〕“隐疹”，成本为“癰疹。”

〔词解〕

①浮为风虚，脉浮主风邪乘卫虚而袭表，故曰“浮为风虚”。

②大为气强：气强，即“卫强”。风邪犯表，卫气与之相争，其气为强，脉应之而大，故曰“大为气强”。

③风气相搏：风邪与卫气相争。

④隐疹：疹，即“疹”。隐疹（隐疹），名出《素问》四时刺逆从论，又名风癰疹、痞痛。

⑤泄风：即隐疹身痒之疾。其病机为风邪发泄于肌肤，但因荣郁卫遏，发泄不畅而成，故名为泄风。参见《素问》风论。

⑥痲癩：即痲风，出《素问》风论。又名大风、癰病、大风恶疾、大麻风、麻风。即今之麻风病。

〔语译〕脉浮而大，浮是风邪乘卫虚而袭表，大是卫与

邪争而强。风邪与卫气相争，必然形成隐疹，身体发痒，发痒者名叫泄风。感受痹风之邪留而不去，久久就会发生皮肤溃烂结痂如癰的麻风病。

〔提要〕脉浮大主泄风、癰癰。

〔释义〕本条借脉浮大，说明泄风、癰癰的成因及证候。邪风乘卫虚而袭表，卫气与风邪相争，脉应之而浮大。风邪与卫气相争，脉道不利，卫遏荣郁，逼风邪外泄，然荣郁卫遏，发泄不畅，郁于皮肤，现为斑点，时隐时显，即为隐疹。隐疹身痒者，名叫泄风。所谓“癰癰”是感受痹风之邪，留而不去，荣卫壅热，久久热蒸肉腐所形成，并非由隐疹迁延而来。因其发病缓慢，故曰久久为癰癰。如黄坤载说：“癰者，营气热腐，其气不清，故使鼻柱坏而色败，皮肤痂溃，风寒客于脉而不去，名曰癰风。肺统卫气而主皮毛，开窍于鼻，是以鼻柱坏而皮肤溃也。”对癰癰之病机、证候议论颇精。

〔讨论〕本条论述了泄风、癰癰的成因及主要临床表现。泄风与癰癰是两种不同的皮肤病，但二者都为邪风所致，且均可见隐疹，故仲景列此以资鉴别。原文说“久久为癰癰”，是指麻风病发病缓慢，并非是由隐疹久久不已而形成。麻风病初起患处麻木不仁，次见红斑，继之皮肤溃烂，出现眉落、目损、鼻崩、唇裂、足底穿等重症。可见，癰癰之初确有先发隐疹而为先兆者，当与泄风相鉴别。《甲乙经》序载仲景为侍中王仲宣诊病，能预测时年二十余岁的王仲宣“君有病，四十当眉落；眉落半年而死。”据此记载，

王仲宣很可能患的就是麻风病。这说明早在仲景时代对麻风病已能作出早期诊断，并预断其病情的严重性。本条提示麻风病有发隐疹之先兆，诚为宝贵经验。

〔参考〕《素问》风论说：“黄帝问曰：风之伤人也，或为寒热，或为热中，或为寒中，或为痹风，或为偏枯，或为风也，其病各异，其名不同，或内至五藏六府，不知其解，愿闻其说……风气与太阳俱入，行诸脉俞，散于分肉之间，与卫气相干，其道不利，故使肌肉愤膜而有疡，卫气有所凝而不行，故其肉有不仁也。痹者，有荣气热胜，其气不清，故使其鼻柱坏而色败，皮肤疡溃，风寒客于脉而不去，名曰痹风，或名曰寒热……外在腠理，则为泄风……泄风之状，多汗，汗出泄衣上，口中干，上演其风，不能劳事，身体尽痛，则寒。”

（五）浮迟脉

〔原文〕脉浮而迟，面热赤而战惕①者，六七日当汗出而解；反发热者差迟②，迟③为无阳④，不能作汗，其身必痒也。（辨—28）

〔词解〕

①战惕：颤抖。

②差迟：差，音义同瘥（chāi），病愈。差迟，病愈延迟。

③迟：指“脉浮而迟”之“迟”。

④无阳：阳气虚弱。

〔语译〕脉浮而迟，颜面发热潮红而颤抖的病人，到六七日当汗出病解，若反而发热的，病愈会延迟，因脉迟是阳气虚弱，不能作汗，这样的病人身上必然发痒。

〔提要〕脉浮迟主邪郁肌表，阳虚不能作汗。

〔释义〕邪郁肌表，脉应之而浮，阳气虚弱，脉应之而迟。邪郁正虚，怫郁不解，故面热潮红；正邪相争，正气一时不能胜邪，故而战惕。至六七日，为六经病经过一个病程，是正气来复之时，正胜邪却，遂汗出而病解。但若阳气素虚，虽值正气来复之时，而阳虚不能作汗，所谓“阳加于阴谓之汗”，因此不得汗出而解，邪无从出，致表郁加重而反发热，病愈就要延迟。邪郁肌表不得汗出，则其身必痒。如《伤寒论》所说：“面色反有热色者，未欲解也，以其不得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。”（23条）

（六）弱迟脉

〔原文〕寸口脉弱而迟，弱者卫气微①，迟者荣中寒②。荣为血，血寒则发热；卫为气，气微者心内饥③，饥而虚满④，不能食也。（平—28）

〔词解〕

①弱者卫气微：平脉法22条（见第一章平脉总则）：“卫气弱，名曰慄”。慄，怯弱，即脉来软弱无力之谓。故此曰“弱者卫气微”。

②迟者荣中寒：脉迟主寒。荣中寒，指寒邪客于经脉，因荣行脉中，故谓之。如成无己说：“迟者，荣中寒，经中

客邪也”。

③气微者心内饥：气微，卫气微。心内，此指胃中。心内饥，胃中饥。

④虚满：与实满相对而言。此指中虚失运，以致气滞胀满。所谓有形为实，无形为虚。

〔语译〕寸口脉弱而迟，弱是卫气不足，迟是荣中客寒。荣为血，血受寒邪则发热；卫为气，卫气微的病人自觉胃中饥饿，但虽饥而虚满，因此又不能食。

〔提要〕脉弱迟主卫气微、荣中寒，责之于中虚失运、气血生化不足。

〔释义〕卫行脉外，为荣之使；荣行脉中，为卫之守。寸口脉弱而迟，弱为卫气虚失于卫外之职；迟为寒邪乘卫虚而入客于经脉，以致荣中寒。荣血俱行脉中，荣中寒则血亦寒，卫气奋力与寒邪相争，则发热。荣卫为脾胃运化水谷所化生，其清者为荣，浊者为卫。荣卫虚微，则中虚失运、气血生化不足可知，即所谓“胃无谷气，脾涩不通”（参见“诸脉概说”平脉法42条）。中虚失运，以致气滞胀满，故曰虚满。因此虽觉胃中饥饿，但终因虚满而又不能食。

〔讨论〕本条“寸口脉弱而迟，弱者卫气微，迟则荣中寒。”与辨脉法20条（参见“浮紧脉”）所谓“寸口脉浮而紧，浮则为风，紧则为寒，风则伤卫，寒则伤荣”均论风寒中伤荣卫，但有虚实之别。二条互参，可以比较全面地认识风寒中伤荣卫的虚实脉象及其机理。本条关于“卫为气，气微者心内饥，饥而虚满，不能食也”的论述，可以说是寸口

脉源于脾胃的实例。

（七）弱缓脉

〔原文〕寸口脉弱而缓，弱者阳气不足①，缓者胃气有余②，噫而吞酸③，食卒不下④，气填于膈上⑤（赵本注：一作下）也。（平—30）

〔词解〕

①阳气不足：此指胃阳不足。

②胃气有余：指胃中食积气滞。黄坤载曰：“缓者胃气有余，有余者，胃气上逆，壅满不降，名为有余，实则胃阳之不足也。”

③噫而吞酸：噫，噫气，指呃逆。噫而吞酸，呃逆吞酸。

④食卒不下：卒（zú），完毕、終了。食卒，食后。食卒不下，谓食后饮食停积胃中不下。

⑤气填于膈上：填，壅满。气填于膈上，浊气壅满于膈上。

〔语译〕寸口脉弱而缓，弱是胃阳不足，缓是食积气滞，故见呃逆吞酸，食后饮食停积胃中不下，这是浊气壅满于膈上的缘故。

〔提要〕脉弱缓主胃虚食滞，噫气吞酸。

〔释义〕阳能消谷，胃阳不足，则不能腐熟消化水谷。以致食积气滞，胃气上逆，浊气壅满于膈上，故见噫气吞酸，食后饮食停积胃中不下，胸膈满闷。其证似胃气有余，

而实为中虚不运、胃阳不足。

〔参考〕《灵枢》口问篇说：“黄帝曰：人之噫者，何气使然？岐伯曰：寒气客于胃，厥逆从下上散，复出于胃，故为噫。”

（八）微缓脉

〔原文〕寸口脉微而缓，微者卫气疏①，疏则其肤空②；缓者胃气③实，实则谷消而水化④也。谷入于胃，脉道乃行⑤，水入于经⑥，其血乃成。荣盛则其肤必疏⑦，三焦绝经⑧，名曰血崩⑨。（平一36）

〔校勘〕“水入于经”，成本作“而入于经”。

〔词解〕

①卫气疏：疏，疏松。此言卫气不固。

②肤空：皮肤不致密之义。

③胃气实：此“实”作充实解，非虚实之“实”。故胃气实，指胃气充实。

④实则谷消而水化：胃气充实，水谷得以腐熟消化。

⑤脉道乃行：血脉流通畅行。

⑥水入于经：水，此指津液。即津液输入经脉。

⑦荣盛则其肤必疏：荣气虽盛而卫气不固，则其皮肤必然疏松。有荣盛而卫虚的意思。

⑧三焦绝经：经，常也。意指三焦失其正常功能。

⑨血崩：病名。以下血如崩，故名之。

〔语译〕寸口脉微而缓，微是卫气不固，卫失固护则皮

肤空虚，缓是胃气充实，胃气充实则水谷得以腐熟消化。水谷得胃气腐熟消化，血脉即能流通畅行，津液输入经脉，即能化生荣血。荣气虽盛而卫气不固，则其皮肤必然疏松，三焦失其正常功能，就会发生名叫血崩的病证。

〔提要〕脉微缓主卫虚荣盛，气不摄血。

〔释义〕本条根据气血相依的理论，论述了脉微缓主卫虚荣盛、气不摄血的机理。《灵枢》本藏篇说：“卫气者，所以温分肉，充皮肤，肥腠理，司开阖者也。”故“卫气和，则分肉解利，皮肤调柔，腠理致密矣。”脉微主卫气不固，故而皮肤空虚。脉缓主胃气充实，胃气充实则能发挥腐熟消化水谷的功能。《灵枢》营气篇说：“营气之道，内谷为宝”。说明胃气充实，荣气充盛。《灵枢》邪客篇说：

“营气者，泌其津液，注之于脉，化以为血”。这就是“谷入于胃，脉道乃行，水入于经，其血乃成”的道理。荣与卫，都是由水谷精微所化生，何以胃气实独荣气盛而卫气虚？这与三焦的功能有密切的关系。《灵枢》营卫生会篇说：“营出于中焦，卫出下焦（据上下文义疑为“上焦”之误）。“营出于中焦”，胃气实故营气充盛。如《灵枢》营卫生会篇说：“中焦亦并胃中，出上焦之后。此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血，以奉生身，莫贵于此。故得独行于经隧，命曰营气。”而“卫出于上焦”，如《灵枢》决气篇说：“上焦开发，宣五谷味，熏肤、充身、泽毛，若雾露之溉，是谓气。”这是卫气的主要生理功能。今卫气不固，皮肤空虚，则上焦失于开

发，皮毛、肌肤失于温煦可知。因此荣气虽盛而卫气不固，以致皮肤疏松，故曰“荣盛则其肤必疏”。三焦功能不相协调，即所谓“三焦绝经”。《难经》三十二难说：“血为荣，气为卫，相随上下，谓之荣卫”。荣卫相随，气血相依。气为血之帅，血为气之母。荣盛则血盛，卫虚则气虚。今荣血虽盛而卫气虚弱，故外失于固密，内失之统摄。气不摄血，以致下注为崩，病名曰血崩。

〔讨论〕张卿子说：“玩实字，乃胃病也，实则谷消而水化，是胃虚不能使水谷入经，循其脉道，故外则肤空，内则血崩。荣盛二字，谓不能与卫和，肤疏二字，谓不能固其荣，非云荣强而卫弱也。”认为“胃气实”应作“胃气虚”，“实”字应作“虚”字讲。但从上下文义来看，实难吻合。岂有胃虚反能“谷消而水化”之理？故此解似属不妥。

黄坤载说：“营血独盛，则血愈温散，而气不清敛，汗孔开泄，是以其肤必疏，疏则三焦经络之血尽化汗液，泄于皮毛，是以名曰血崩。所谓夺汗者勿血，夺血者勿汗，汗即血之酝酿而成者也。”认为所谓“血崩”指汗“泄于皮毛”。若从“夺汗者勿血，夺血者勿汗”的原理来看，似属有理，可备一说。但从“血崩”的病名涵义看来，仍以指下血如崩之说为妥。证之临床，气不摄血而致崩血者确属多见。

本条借脉象阐述了血崩的病理生理及辨证要点。血为荣气所化生，荣与卫俱行脉中，循经脉运行，周而复始，如环无端，即所谓“谷入于胃，脉道乃行，水入于经，其血乃

成。”今卫与气虚，上焦失于开发，皮毛、肌肤失于温煦，三焦功能失调，外则卫气不固、皮肤疏松，内则气不摄血、下血如崩，即所谓“荣盛则其肤必疏，三焦绝经，名曰血崩。”这是气不摄血，血不循经使然。其证由于卫气不固、皮肤疏松，必见自汗、短气、乏力等气虚之证，所谓“微则卫气疏，疏则其肤空”，正是气不摄血而为血崩的辨证要点。但必须指出，这里“卫虚荣盛”是相对而言，意在突出血崩的病理在气不摄血。荣卫皆由水谷之精气所化生，其不足多互相影响，又不可绝对而论。

（九）微涩脉

〔原文〕寸口脉微而涩，微者卫气不行①，涩者荣气不逮②。荣卫不能相将③，三焦无所仰④，身体痹不仁⑤。荣气不足，则烦疼，口难言；卫气虚者，则恶寒数欠。三焦不归其部⑥，上焦不归者，噫而酢吞⑦；中焦不归者，不能消谷引食；下焦不归者，则遗洩⑧。（平—32）

〔词解〕

①卫气不行：方中行曰：“卫主气，不行，言不用事也。”即有运行失度，不能发挥卫外功能之义。

②荣气不逮：逮（dài），到、及。荣气不逮，荣气不及，即有运行迟涩之义。

③荣卫不能相将：将（jiāng），扶助。荣卫不能相将，荣卫不能相助，上下不能相随。

④三焦无所仰：仰，依赖。三焦无所仰，三焦失去依靠。

⑤身体痹不仁：痹，麻痹。不仁，无感觉，不知痛痒。身体痹不仁，身体麻痹而无感觉。

⑥三焦不归其部：归、归循。部，部署。三焦不归其部，三焦不能归循其部署。意指三焦所属不能各司其职，即上焦不能宣发敷布，中焦不能受纳运化，下焦不能泌别清浊。

⑦噫而酢吞：噫，噫气，即呃逆。酢，音义同“醋”（cù）。酢吞，吞酸。噫而酢吞，呃逆吞酸。

⑧遗洩：洩，大、小便。遗洩，大、小便失禁。

〔语译〕寸口脉微而涩，微是卫气运行失度，不能发挥卫外功能，涩是荣气不足运行迟涩。荣卫不能相助运行，三焦失去依靠，身体麻痹无感觉。荣气不足，则身体疼痛而烦，说话困难；卫气虚，则恶寒而频频呵欠。三焦所属不能各司其职，上焦失职的，呃逆吞酸；中焦失职的，水谷不消而不能进食；下焦失职的，则大、小便失禁。

〔提要〕脉微涩主荣卫俱虚，三焦失司。

〔释义〕寸口脉微而涩，脉微主卫气虚，脉涩主荣血不足。《难经》三十一难说：“三焦者，水谷之道路，气之所终始也。”指出三焦与水谷的运化、输布密切相关，主持人体的气化功能。所谓“上焦如雾，中焦如沤，下焦如渫”。卫气根于下焦，开发于上焦，与荣气俱出于中焦，荣卫气血游行出入于三焦，三焦得荣卫资助而各司其职。今荣卫俱

虚，运行失常，不能相助，则三焦必然失去依靠。《素问》逆调论说：“荣气虚则不仁”。《灵枢》刺节真邪篇说：“卫气不行，则为不仁”。今“卫气不行”，“荣气不逮”，故身体麻痹不仁。荣气不足，筋脉失养，则烦疼；荣血不足，心气亏虚，则口难言。卫为阳，卫阳虚失于温煦，则洒淅恶寒，卫主气，气虚则数欠。“三焦不归其部”，即三焦所属不司其职。《灵枢》决气篇说：“上焦开发，宣五谷味，熏肤、充身、泽毛，若雾露之溉，是谓气。”上焦失职，水谷精气不得宣发敷布，谷气郁遏于中焦，故而呃逆吞酸。《灵枢》营卫生会篇说：“中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血，以奉生身，莫贵于此，故独得行于经隧，命曰营气。”中焦失职，不得受纳运化，故不能消谷引食。

《灵枢》营卫生会篇说：“下焦者，别迴肠，注于膀胱，而渗入焉。故水谷者，常并居于胃中，成糟粕而俱下于大肠，而成下焦，渗而俱下，济泌别汁，循下焦而渗入膀胱焉。”下焦失职，清浊不别，不能约束，则二便失禁。

〔讨论〕本条根据脉微涩主“卫气不行”与“荣气不逮”，分析了荣卫俱虚与三焦不司其职的密切的病理生理关系，这是学习本条应当着重领会的中心内容。所论身体痹不仁、烦疼、口难言、恶寒数欠是荣卫俱虚的表现；噫而酢吞、不能消谷引食、遗洩则分别是三焦不能各司其职的表现。见证虽有不同，而荣卫俱虚不能相将的病机则一。且所列证候，意在举例，必须活着。其证治不外从荣卫俱虚着

眼，以益气和荣、气血双补为法，庶不致误。

〔原文〕寸口脉微而涩，微者卫气衰，涩者荣气不足。卫气衰，面色黄；荣气不足，面色青。荣为根，卫为叶，荣卫俱微，则根叶枯槁，而寒慄咳逆，唾腥吐涎沫也。（平—34）

〔语译〕寸口脉微而涩，微是卫气衰弱，涩是荣气不足。卫气衰弱，则面色萎黄；荣气不足，则面色为青。荣如根本，卫如枝叶，荣卫俱衰微，根本、枝叶皆枯槁，则恶寒颤抖，咳嗽气逆，唾痰腥臭，泛吐涎沫。

〔提要〕脉微涩主荣卫俱衰，气血不荣。

〔释义〕寸口脉微而涩，主荣卫俱虚。卫为气，卫气衰则脾气虚，故面色萎黄。荣为血，荣血不足则肝血亏虚，故面色为青。此皆由气血不荣使然。荣行脉中，为卫之守，故喻为根本；卫行脉外，为荣之使，故喻为枝叶。今荣卫俱衰微，故谓之根叶枯槁。脾胃居中土，为生化之源。荣卫衰微，则化源不足、中土虚衰可知。若土微不能生金，则变生肺损之候，证见寒慄咳逆、唾腥吐涎沫等证。

〔讨论〕寸口脉微而涩，主荣卫俱虚，上条（平—32）言致三焦失司，本条则言致气血不荣。二条均从荣卫俱虚立论，但临床证候各不相同，示人凭脉辨证的临床意义。所论卫虚则面黄，荣虚则面青，堪称经验之谈。其中，虽未论及荣卫俱虚之面色，但据此可推知其面色当见青黄。所举寒慄咳逆、唾腥吐涎沫的肺损之候，意在示例。

〔原文〕师曰：病人脉微而涩者，此为医所病也。大发其汗，又数大下之，其人亡血，病当恶寒，后乃发热，无休止时。夏月盛热，欲着复①衣；冬月盛寒，欲裸其身。所以然者，阳微则恶寒，阴弱则发热。此医发其汗，使阳气微；又大下之，令阴气弱。五月之时，阳气在表，胃中虚冷，以阳气内微，不能胜冷，故欲着复衣；十一月之时，阳气在里，胃中烦热，以阴气内弱，不能胜热，故欲裸其身。又阴脉②迟涩，故知亡血也。（辨一22）

〔校勘〕《金匱玉函經》：“后乃发热，无休止时”，作“而发热，无休止时”；“欲着复衣”，作“而欲着複衣”；“欲裸其身”，作“而欲裸其体”；“阳微则恶寒，阴弱则发热”，其“则”均为“即”；“此医发其汗”，无“此”字；“以阳气内微”，作“内以阳微”；“以阴气内弱”，作“内以阴弱”；“故欲裸其身”，作“故欲裸其体”。成本：“欲着复衣”，均作“欲著复衣”；“使阳气微”，作“令阳气微”；“故知亡血也”，作“故知血亡也”。

〔词解〕

①欲着复衣：着（zhuó），同著，穿（衣）。复，同複，多数。欲着复衣，想多穿些衣服。

②阴脉：此指尺脉。

〔语译〕老师说：病人脉微而涩的，这是医生所造成的病变。由于误用大发汗，又多次误下，病人荣血亏损，则病

当恶寒，而后又发热，没有休止的时候。夏季酷热，却想多穿些衣服；冬季严寒，却想光着身体。所以如此，阳气虚微则恶寒，阴血虚弱则发热。这是医生误汗，使阳气虚微；又误用大下，致使阴血虚弱。五月时节，阳气在表，胃中虚冷，因阳气内虚，不能胜冷，所以想多穿些衣服；十一月时节，阳气在里，胃中烦热，由于阴血内弱，不能胜热，所以想光着身体。又据尺脉迟涩，所以知道荣血亏虚。

〔提要〕脉微涩主误汗、下劫伤阳气、阴血。

〔释义〕医生误汗、下，劫伤阳气、阴血，可见脉微而涩。误汗伤阳，误下伤阴，即所谓“此医发其汗，使阳气微；又大下之，令阴气弱。”而所说“大发其汗，又数大下之，其人亡血”，则旨在强调无论误汗伤阳，还是误下伤阴，均导致阴血耗伤的转归。“夺血者无汗，夺汗者无血”，即说明了误汗亡血的道理。如张隐庵说：“汗为血液，发之所以亡之也，而又下之，伤其阴，阴血亦随之以亡，正不必失血后，而始称之为亡血也。”而其“病当恶寒，后乃发热，无休止时”，即是误汗、下所致阳微阴弱的变证。其证见“夏月盛热，欲着复衣；冬月盛寒，欲裸其身。”这是因为“阳微则恶寒，阴弱则发热”，如《素问》调经论所说：

“阳虚则外寒，阴虚则内热”。人与自然相适应，五月盛夏，人体阳气应之而盛于体表，阳微者里阳更微，不胜胃中虚冷，故虽酷暑而欲着复衣；十一月严冬，人体阳气应之内蓄，阴虚者不胜其阳热，胃中则烦热，故虽严寒而欲裸其身。又据尺脉候阴，则尺脉迟涩主荣血亏虚。如《伤寒论》

明确指出：“假令尺中迟者，不可发汗，何以知然？以营气不足，血少故也。”（50条）进一步强调了误汗、下致阴阳两伤而亡血的转归，并以尺脉迟涩为凭。

〔讨论〕本条论脉微涩主误汗、下伤阳劫阴及其变证，即阳虚恶寒与阴虚发热的表现和机理，颇为精当。其中义理，至今为医家所宗。所谓“此为医所病也”，旨在告诫医生切忌误治，以免给病人造成不良后果。本条未论及治法，但总不外以扶阳益阴为法。

综观上述三条，均论脉微主卫与阳气虚，脉涩主荣与阴血虚，并将《内经》、《难经》理论与临床实践相结合，阐述了荣卫气血俱虚的脉理及主病。从三焦不司其职、气血不荣及阳虚恶寒与阴虚发热等方面列举了临床所见多种证候，体现了凭脉辨证的丰富内容，至今不失其指导意义。

（十）微弱脉

〔原文〕师曰：伏气①之病，以意候之②，今月之内，欲有伏气。假令旧有伏气，当须脉之③。若脉微弱者，当喉中痛，似伤，非喉痹④也。病人云：实咽中痛，虽尔⑤，今复欲下利。（平—6）

〔词解〕

①伏气：感受时令之邪，不即发病，伏藏体内，过时乃发的一类疾病。

②以意候之：意，意识、理论。此指以五运六气的理论来推断伏气之发病。

③脉之：此指诊察。

④喉痹：喉中红肿疼痛闭塞之证。

⑤虽尔：虽然如此。

〔语译〕老师说：伏气的疾病，可以根据理论来判断，这个月内，可能有伏气发病。假使以前已经感受了伏气，则应当进行诊察。若脉微弱的，应当喉中疼痛，象受了伤一样，但不是喉痹。病人说：确实咽中疼痛，虽然如此，现在又欲下利。

〔提要〕辨伏气发病，脉微弱主寒邪深伏于少阴。

〔释义〕六淫时令之邪，感而不即发，潜匿于肌腠、募原，甚或深伏于少阴，过时乃发病者，谓之伏气。其发病情况，可根据五运六气的理论来推断。如冬时寒气太过，来春之日，即当早防伏气春温，正如《素问》生气通天论所说：

“冬伤于寒，春必病温”。这就是所谓“以意候之”。若已感伏邪，则当运用四诊进行诊察，以审伏气发于何经。若诊得脉微弱，多为伏气发于少阴。冬寒伏于少阴，至来春阳气生发之际，即发为春温。少阴属肾，其经脉循行咽喉，主司二便。故病者咽喉象受伤一样疼痛，同时并见下利，这是春温的常见证候。其咽喉疼痛却非喉痹之咽喉红肿闭塞，当注意鉴别。“实咽中痛，虽尔，今复欲下利”，指出少阴温病之咽痛与下利并见。

（十一）寸脉与尺脉

〔原文〕问曰：病有洒淅恶寒，而复发热者，何？

答曰：阴脉①不足，阳往从之②；阳脉③不足，阴往乘之④。曰：何谓阳不足？答曰：假令寸口脉⑤微，名曰阳不足，阴气上入阳中⑥，则洒淅恶寒也。曰：何谓阴不足？答曰：尺脉弱，名曰阴不足，阳气下陷入阴中⑦，则发热也。（辨一3）

〔校勘〕《金匱玉函經》：“……而復發熱者，何？”作“……而複發熱者，何也？”；“何謂陽不足”前无“曰”字；“名曰陽不足”，作“為陽不足”；“則洒淅惡寒也”，无“也”字；“何謂陰不足”前无“曰”字；“名曰陰不足”，作“為陰不足”；“則發熱也”，无“也”字。成本：“尺脈弱”，作“假令尺脈弱”。

〔詞解〕

①陰脈：此指尺脈。

②陽往從之：往，去。從，音義同“縱”（zòng），放縱，此有乘襲的意思。之，指示代詞，此代表陰。陽往從之，意指陰不足，陽去乘襲陰。

③陽脈：此指寸脈。

④陰往乘之：往，去。乘，乘襲。之，指示代詞，此代表陽。陰往乘之，意指陽不足，陰去乘襲陽。

⑤寸口脈：此指寸脈。

⑥陰氣上入陽中：指陰入陽分，即指“陰往乘之”。

⑦陽氣下陷入陰中：指陽入陰分，即指“陽往從之”。

〔語譯〕問：病有洒淅惡寒，而又發熱的，這是什麼病變呢？答：這是尺脈不足，陽去乘襲陰；寸脈不足，陰去乘襲

阳的病变。问：什么叫阳不足呢？答：假使寸脉微，就名叫阳不足，阴气侵入阳分，则洒淅恶寒。问：什么叫阴不足呢？答：尺脉弱，就名叫阴不足，阳气侵入阴分，则发热。

〔提要〕从寸、尺脉微弱辨阳虚恶寒与阴虚发热机理。

〔释义〕本条所论“病有洒淅恶寒，而复发热者”是指内伤杂病之阳虚恶寒与阴虚发热，不可与外感表证之恶寒发热混同。这是由于阴阳偏虚所引起的。本条据寸脉与尺脉微弱，对其阳虚恶寒与阴虚发热的机理进行了分析。尺脉为阴脉，主阴，尺脉不足则主阴不足。寸脉为阳脉，主阳，寸脉不足则主阳不足。如寸脉微，即是阳不足，阳虚则阴乘其阳，即表现洒淅恶寒。尺脉弱，即是阴不足，阴虚则阳乘其阴，即表现发热，阴阳交虚，互相乘袭，则恶寒而又发热。

〔讨论〕本条据寸脉微与尺脉弱对阳虚恶寒与阴虚发热机理的分析，言简意赅，说理透彻，至今不失其理论指导意义。但必须指出，所说寸脉微与尺脉弱，是举阳脉与阴脉不足之例，以此说明阴阳偏虚之理，不可拘泥。

〔原文〕阳脉①浮（赵本注：一作微），阴脉②弱者，则血虚，血虚则筋急也。其脉沉③者，荣气微也。其脉浮④，而汗出如流珠者，卫气衰也。荣气微者，加烧针⑤，则血留不行，更发热而躁烦也。（辨一4）

〔校勘〕《金匱玉函经》：“血虚则筋急也”，无“也”字；“荣气微者”，无“者”字；“则血留不行”，

无“则”字。成本：“血留不行”，作“血流不行”。《脉经》：“阴脉弱者”，无“者”字；“血虚则筋急也”，作“血虚则筋惕”；“荣气微者”，无“者”字；“则血留不行”，无“则”字。

〔词解〕

①阳脉：此指寸脉。

②阴脉：此指尺脉。

③其脉沉：此指尺脉沉。

④其脉浮：此指寸脉浮。

⑤烧针：又称火针，指预先将针体烧红后再迅即刺入穴位的针刺法。一般用粗针外裹棉花蘸麻油烧之，或直接将针体频涂麻油置油灯明火上烧之。主治风寒筋急、痉挛痹痛、瘫痪不仁等证。

〔语译〕寸脉浮、尺脉弱的，则血虚，血虚则筋脉挛急。尺脉沉的，是荣气衰微。寸脉浮，且出汗象流珠一样的，是卫气虚衰。荣气衰微，施以烧针，就会引起血液留而不行，以致更加发热与躁烦不宁。

〔提要〕以寸、尺脉浮弱辨荣卫衰微。

〔释义〕卫为阳，寸脉候阳，故寸脉可以候卫气的盛衰，荣为阴，尺脉候阴，故尺脉可以候荣气的盛衰。卫气虚衰阳浮于外，寸脉应之而浮，显然其浮而必无力；荣气衰微血亏于内，则尺脉应之而沉弱。寸脉浮尺脉弱者，卫气虚阳浮于外，荣气微血虚于内。荣血亏虚，筋脉失养，则挛急。卫虚阳浮，汗随阳泄，必见汗出如流珠。荣血亏虚者，治当益气

养荣。若反用烧针治疗，火热内攻，更伤荣血，必致血留不行，造成更发热而躁烦的变证。

〔讨论〕本条具体介绍寸脉以候卫阳，尺脉以候荣阴的平脉辨证，至今仍为临床医家所宗。所举寸浮尺弱以辨卫衰荣微，意在示人规矩；且卫气虚衰者汗出如流珠、荣血虚微者则筋急等见证，亦仅是举例。临证还当脉证详参，以全面辨证。关于烧针致变的告诫，体现了辨证论治的精神，可从中举一反三。

这里还必须指出，虽寸浮尺沉主荣卫衰微，而平脉亦显寸浮尺沉之象，必须加以鉴别。此寸浮尺沉，必寸脉浮而无力，尺脉沉而弱，为病脉，而平人所见则以和缓有力为特征，属平脉。

〔原文〕寸口脉阴阳俱紧①者，法当清邪②中于上焦，浊邪③中于下焦。清邪中上，名曰洁④也；浊邪中下，名曰浑⑤也。阴中于邪⑥，必内慄⑦也，表气微虚⑧，里气不守⑨，故使邪中于阴也。阳中于邪⑩，必发热，头痛项强，颈挛，腰痛胫酸，所为阳中雾露之气，故曰清邪中上。浊邪中下，阴气为慄⑪，足膝逆冷，便溺妄出⑫。表气微虚，里气微急⑬，三焦相溷⑭，内外不通⑮。上焦怫郁⑯，藏气相熏⑰，口烂食断⑱也。中焦不治，胃气上冲，脾气不转⑲，胃中为浊⑳，荣卫不通㉑，血凝不流。若卫

气前通②者，小便赤黄，与热相搏，因热作使③，游于经络，出入藏府，热气所过，则为痈脓。若阴气前通④者，阳气厥微⑤，阴无所使⑥，客气⑦内入，噦而出之，声喑咽塞⑧；寒厥相迫⑨，为热所拥，血凝自下，状如豚肝⑩。阴阳俱厥⑪，脾气孤弱⑫，五液注下⑬，下焦不盍，清便下重⑭，令便数难⑮，齐筑湫痛⑯，命将难全。（辨—29）

〔校勘〕《金匱玉函經》：“陰陽俱緊者”，无“者”字；“清邪中于上焦，浊邪中于下焦”，作“清邪中上，浊邪中下”，“名曰洁也”、“名曰浑也”与“必内慄也”，均无“也”字；“里气不守”，作“里气失守”；“头痛项强，颈挛”，无“颈挛”二字；“便溺妄出”，作“溲便妄出”；“上焦怫郁”、“中焦不治”前均有“若”字；“若卫气前通者”与“若阴气前通者”，均无“若”与“者”字；“下焦不盍”，作“若下焦不阖”；“齐筑湫痛”之“齐”，作“脐”。成本：“三焦相溷”，作“三焦相混”；“寒厥相迫”，作“寒厥相逐”；“下焦不盍”之“盍”，作“阖”（赵本注“一作阖”）；“齐筑湫痛”之“齐”，作“脐”。

〔词解〕

①寸口脉阴阳俱紧：阴，尺部。阳，寸部。即寸口尺部和寸部脉都呈紧象，实际寸、关、尺三部脉俱紧。

②清邪：指雾露之邪，属湿邪一类。

③浊邪：指水湿之邪。

④洁：指雾露之邪伤于上焦的病证。以雾露具轻清之

性，在天，故名。

⑤浑：指水湿之邪伤于下焦的病证。以水湿具重浊之性，在地，故名。

⑥阴中于邪：阴，指下焦，有注家认为指少阴。即指下焦（少阴）外中水湿之邪。

⑦内慄：自觉心中惕惕然而寒慄。

⑧表气微虚：表气，肌表、经络之气。表气微虚，肌表、经络之气虚微。

⑨里气不守：里气，五脏六腑之气。里气不守，五脏六腑之气不能内司其职。

⑩阳中于邪：阳，指上焦，有注家认为指太阳。即指上焦（太阳）外中雾露之邪。

⑪阴气为慄：阴气，此指水湿之邪。阴气为慄，水湿之邪引起寒慄。

⑫便溺妄出：便，此指大便。溺（niào），音义同“尿”。便溺妄出，大、小便失禁。

⑬里气微急：里气虚而急迫。

⑭三焦相渎：渎（hùn），混乱。三焦相渎，三焦功能紊乱。

⑮内外不通：表里不通。

⑯上焦怫郁：怫郁（fú yù），抑郁之义。上焦怫郁，上焦清阳之气不得宣发。

⑰藏气相熏：内脏郁热之气熏蒸。

⑱口烂食断：食，同“蚀”。断，同“齟”。口烂食断，

口腔和牙龈腐烂。

⑱脾气不转：脾失运化转输。

⑲胃中为浊：《金匱要略》黄疸病脉证并治篇说：“谷气不消，胃中苦浊”。意指胃失受纳腐熟，水谷不得消化，以致胃生湿热秽浊之气。

⑳荣卫不通：荣卫不能畅通运行。

㉑卫气前通：卫气先得畅通运行。

㉒因热作使：因，依、顺着。热，此指邪热。作使，支使。因热作使，意指卫气受邪热所支使，即受邪热煎迫的意思。

㉓阴气前通：阴气，此指荣阴。意指荣阴先得畅通运行。

㉔阳气厥微：阳气，此指卫阳。厥，犹“乃”。阳气厥微，卫阳乃微。

㉕阴无所使：阴，此指荣阴。《素问》阴阳应象大论说：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”。今卫阳衰微，故曰“阴无所使”。

㉖客气：侵袭人体之邪气。

㉗声喑咽塞：喑（wǒ），吞咽。声喑，形容声音混浊难出之状。咽塞，咽喉噎塞。声喑咽塞，声音混浊难出而咽喉噎塞。

㉘寒厥相迫：寒，外受之寒邪。厥，体内之逆气。寒厥相迫，即外受之寒邪与体内之逆气相互搏击。

㉙豚肝：豚（tún），猪。豚肝，猪肝。

㉚阴阳俱厥：厥，乖逆。阴阳俱厥，阴阳乖逆，即阴阳失和的意思。

③②脾气孤弱：孤，独。脾气孤弱，脾气独弱，即脾气特别虚弱的意恩。

③③五液注下：五液，如《素问》宣明五气篇所说：“五脏化液，心为汗，肺为涕，肝为泪，脾为涎，肾为唾，是为五液”。此意为津液尽泄于下。

③④清便下重：清，通“圊”（qīng），此作排便解。下重，里急后重。清便下重，大便里急后重，此当指下利而言。

③⑤令便数难：令，使。意指大便频数而困难。

③⑥齐筑湫痛：齐，音义同“脐”。筑，古代一种打击乐器，此喻筑然而动，有拘急的意思。湫，通“绞”。齐筑湫痛，脐部拘急绞痛。

〔语译〕寸口尺部和寸部脉都现紧象的，按理应当是雾露之清邪中于上焦，水湿之浊邪中于下焦。清邪中上焦，叫做“洁”，浊邪中下焦，叫做“浑”。下焦少阴外中浊邪，必自觉心中惕然而寒慄，这是由于表气虚微，里气不守，所以致外邪中伤了下焦少阴。上焦太阳外中清邪，必然发热，头痛项强，颈挛，腰痛胫酸，这就是所说的阳中雾露之气，所以叫做清邪中上。浊邪中下，则引起寒慄，足膝逆冷，大、小便失禁。由此导致表气虚微，里气急迫，三焦功能紊乱，表里不通。若上焦清阳之气不得宣发，内脏郁热之气熏蒸，就会发生口腔和牙龈腐烂。若中焦失职，胃气上冲，脾失运化转输，就会使胃中内蕴湿热秽浊之气，荣卫不能畅通运行，血液凝滞不行。若卫气先得畅通运行，可见小便黄赤，卫气与邪热相互搏结，受邪热煎迫，游行于经络，

出入于脏腑，邪热所过之处，就会形成痈脓。若荣阴之气先得畅通运行，由于卫阳衰微，则荣阴失于护卫，外邪乘虚内入，遇里气抗拒就发生喷嚏，声音混浊难出，咽喉噎塞；寒邪与逆气相互搏击，致邪热壅遏，则致血液凝滞随大便而下，其状如猪肝。若进而阴阳乖逆失和，脾气特别虚弱，津液尽泄于下，下焦不固，下利里急后重，大便频数困难，脐部拘急绞痛，这样生命就难以保全了。

〔提要〕从寸口脉阴阳俱紧，辨雾露、水湿之邪中上、下焦之疾，以及由此导致的中焦不治、三焦紊乱之危候和死证。

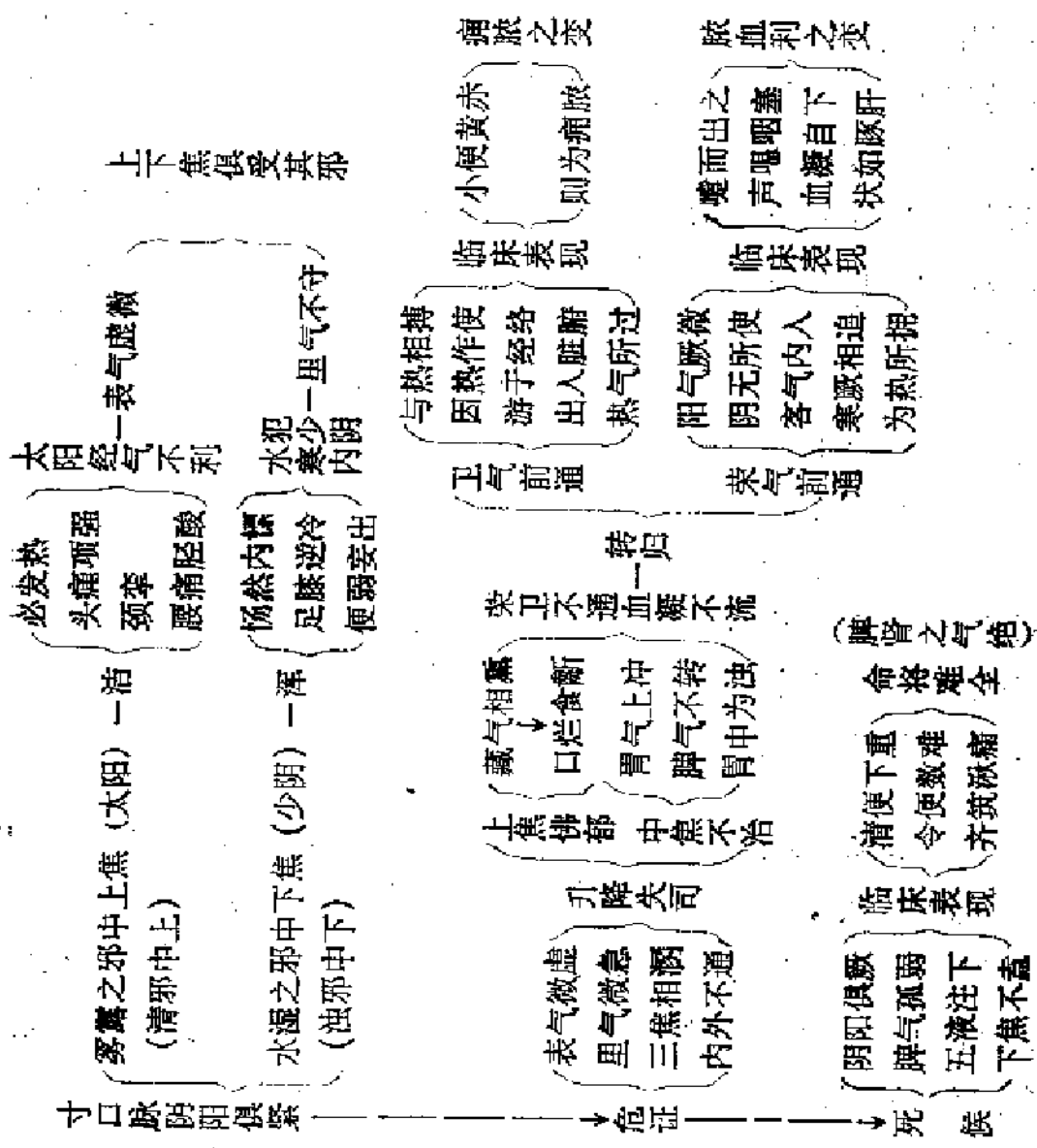
〔释义〕寸脉为阳，候上焦病；尺脉为阴，候下焦病。脉紧主邪实，寸脉紧主雾露之邪中于上焦，尺脉紧主水湿之邪中于下焦。雾露在天，具轻清之性，故称清邪，中于上焦为患叫做“洁”。水湿在地，具重浊之性，故称为浊邪，中于下焦为患叫做“浑”。这里所谓雾露之邪（清邪）、水湿之邪（浊邪）都属湿邪一类，但清与浊寓有阴阳之意。雾露之邪犯上焦，太阳经气不利，故见发热，头痛项强，颈挛，腰痛胫酸。水湿之邪犯下焦，因表气虚弱、里气不守使然，水寒内犯少阴之阳，故自觉心中惕惕然寒慄，足膝逆冷，小便失禁。上、下焦俱受邪，表气虚微，里气急迫，必影响中焦升降之机，三焦功能为之紊乱，以致表里、上下、阴阳之气不得畅行。上焦清阳之气不得宣发，内脏郁热于上，则致口腔和牙龈腐烂。中焦升降失司，胃气逆上冲，脾失运化转输，水谷不得腐熟消化，内蕴湿热秽浊之气。荣卫化源受阻，不能畅通运行，则血脉凝滞。病情至

此，堪称危候。但是，荣卫之气于此还可见流通。若卫气先通，邪热随卫气外泄，表现小便黄赤；又邪热与卫气相持游行于经络，出入于脏腑，热气所过之处，由于邪热蒸迫，热蒸肉腐，就会形成痈脓。若荣阴之气先通，由于卫气衰微，荣阴失于护卫，外邪乘虚而入，遇里气抗拒，即发生喷嚏，其声音混浊难出，咽喉噎塞。这是寒邪犯肺所致。肺主声，鼻为肺之窍，咽喉为升降出入之门户，正邪相争于此，故使然。客寒与逆气相互搏击，致邪热壅塞，热灼荣血，则致血液凝滞随大便而下，其状如猪肝。这些证候虽属严重，但还可救治。若进而阴阳乖逆失和，脾气衰败，津液尽泄于下，下焦不固，证见下利后重，大便频数困难，脐腹部拘急绞痛，这是脾肾先后天之气绝，故曰“命将难全”。

〔讨论〕

1. 原文分析：关于“寸口脉阴阳俱紧”有不同解释：其一，认为阴阳指浮沉，如成无己说：“浮为阳，沉为阴，阳脉紧则雾露之气中于上焦，阴脉紧则寒邪中于下焦”；其二，认为阴阳指尺寸，如《伤寒论译释》说：“寸口的脉象，尺部和寸部都紧，以理推断，应该是雾露等清邪侵害了上焦，水湿等浊邪侵害了下焦”；其三，认为阴阳概指尺寸与浮沉，如张令韶说：“寸口脉阴阳俱紧，概尺寸浮沉而言也。”从仲景寸口脉法来看，以寸脉为阳候上焦病，尺脉为阴候下焦病，而浮沉则主候表里（详见辨脉法18条），故以阴阳指尺寸说为妥。

本条原文内容繁杂，颇难索解。试以图示分析如下：



2.对本条所论病证性质的认识：本条所论病证似属湿温。湿温初起，有类伤寒表实之候，惟脉象一般不浮紧，而现濡缓，今曰脉阴阳俱紧，是感受水寒之邪蕴热所致。从本条可见，湿温之为病，见证甚为复杂。初起上下焦分别外中雾露与水湿之邪，寸口脉阴阳俱紧，似为邪犯募原之证，治疗可用雷氏宣透募原法。上下焦俱受其邪，以致升降失司，上焦佛郁，中焦不治，三焦相润，似属湿热弥漫三焦，治宜苦辛开泄，可用杏仁滑石汤之属。而卫气前通所致痲疹之变，似为湿热蕴毒，治疗宜用甘露消毒丹；荣气前通所致脓血利之变，似为邪犯营血，可考虑选用犀角地黄汤之属。若进而出现脾肾气绝的死候，是气虚欲脱之象，当急用独参汤固脱，继予黄土汤扶阳益阴、养血固脱。

3.本条洁与浑脉阴阳俱紧与太阳伤寒表实的鉴别：本条所论洁与浑之“寸口脉阴阳俱紧”与太阳伤寒表实之“脉阴阳俱紧”，其脉证均有一些类同之处，并均为外感六淫之邪为患，应当注意鉴别。兹列表鉴别如下页表：

〔原文〕脉阴阳俱紧①者，口中气出②，唇口干燥，踡卧足冷，鼻中涕出，舌上胎滑③，勿妄治也。到七日以来，其人微发热，手足温者，此为欲解；或到八日以上，反大发热者，此为难治。设使恶寒者，必欲呕也；腹内痛者，必欲利也。（辨—30）

〔校勘〕《金匱玉函经》：“脉阴阳俱紧者”、“手足温者”、“反大发热者”，均无“者”字；“设使恶寒者”，

证 型		太阳伤寒表实	洁 与 浑
脉 象		脉 阴 阳 俱 紧	脉阴阳俱紧
类 证		恶寒发热，头项强痛，体痛，身痛腰痛，骨节疼痛	发热，头痛项强，颈挛，腰痛胫酸；惕然内慄，足膝逆冷
鉴 别 要 点	病 因	风寒	雾露与水湿
	病 机	外感风寒束表，卫阳被遏，荣阴郁滞	雾露及水湿之邪中上、下焦，表气微虚，里气不守（雾露之邪中上焦太阳，太阳经气不利；水湿之邪犯下焦少阴，少阴阳气不行）
	性 质	伤寒表实	湿温邪犯募原
	证 候	无里证	惕惕然内慄，足膝逆冷，便溺妄出

无“使”字，“必欲呕也”，无“也”字，“腹内痛者”，无“内”字。成本：“到七日以来”、“或到八日以上”，其“以”字均作“已”。

〔词解〕

①脉阴阳俱紧：阴，尺部。阳，寸部。即尺脉和寸脉俱紧，实际寸、关、尺三部脉均显紧象。

②口中气出：张口呼吸。

③舌上胎滑：胎，通“苔”。即舌苔滑腻。

〔语译〕寸脉和尺脉都紧的，并见张口呼吸，口唇干燥，踡卧足冷，鼻中流涕，舌苔滑腻，切勿随便治疗。等到七

日以后，病人轻微发热，手足温暖的，这是将愈；或到八日以上，反而大发热的，这就难以治疗了。假使恶寒的，必然想呕；腹内疼痛的，必将要下利。

〔提要〕从寸、尺脉俱紧辨表里、寒热、虚实、阴阳混淆之证及其转归。

〔释义〕仲景脉法，以寸脉主阳、主表、主气，候上焦病；尺脉主阴、主里、主血，候下焦病。脉尺寸俱紧，主邪气盛。鼻塞流涕、张口呼吸，为表邪闭郁肺气不利之象；踡卧足冷、舌苔滑腻，当是阳虚阴盛的表现；口唇干燥，则为阴伤之征。此证候表里、寒热、虚实、阴阳混淆，变化不测，疑似难明，不可冒然施治。值此，可稍待时日，以观察病情变化，审慎从事。若到七、八日后，病情经过一个病程，病人微发热，手足转温，这是正复邪却的佳兆，其病将愈；若病人反大发热，则是正虚邪盛的表现，为难治。如果病人仍然恶寒，是表邪仍盛，表寒外束，肺胃气阻，则致气逆欲呕；若为阳虚阴寒内盛，寒主收引，则致腹内疼痛，腹痛者寒湿内盛，故又必欲下利。

〔讨论〕本条与上条（辨脉法29条）相承，似亦属湿温的复杂证候。如《医宗金鉴》说：“此承上条互详其证，戒人临此阴阳混淆之病，慎勿妄治也。”文中特别以发热之微与甚作为判断病情好转与恶化的预后标志，以恶寒与腹痛辨邪之表里，诚属外感热病辨证的宝贵经验，至今不失其临床指导意义。正如方有执说：“渐发热邪退也，大发热邪胜也，恶寒在表也，腹内痛入阴也。”

〔原文〕寸口脉①微，尺脉紧，其人虚损多汗，知阴常在②，绝不见阳③也。（平—41）

〔词解〕

①寸口脉：此指寸脉。

②知阴常在：阴，此指阴寒之邪。知阴常在，意指阴寒至盛。

③绝不见阳：阳，此指人体阳气。绝不见阳，意指阳气亡绝。

〔语译〕寸脉微，尺脉紧，病人虚损而多汗，可以断定这是阴寒至盛，阳气亡绝。

〔提要〕据寸脉微尺脉紧辨阴盛阳绝。

〔释义〕寸脉候阳，寸脉微主阳气衰微。尺脉候阴，尺脉紧主阴寒内盛。若其人虚损而多汗，则可知阴寒至盛于内而阳气亡绝于外，即所谓阴盛阳绝。除此之外，还必见厥逆、吐利等证。治疗急当用四逆辈回阳救逆。

二、趺阳脉

本节计9条。趺阳脉，又称冲阳脉，属足阳明胃经，在足阳明经冲阳穴动脉处候之（足背动脉搏动处）。趺阳脉是仲景简化的三部诊法的诊脉部位之一，用以候脾胃之气，常与独取寸口诊法并用。除用以候脾胃之气外，还根据脾胃为后天之本、生化之源的理论，以辨荣卫气血的盛衰。

〔原文〕趺阳脉迟而缓①，胃气如经②也。趺阳脉浮而数，浮则伤胃③，数则动脾④，此非本病，医特下之所为也。荣卫内陷⑤，其数先微⑥，脉反但浮⑦，其人必大便鞲，气噫而除⑧。何以言之？本以数脉动脾，其数先微，故知脾气不治⑨，大便鞲，气噫而除；今脉反浮，其数改微，邪气独留⑩，心中⑪则饥，邪热不杀谷⑫，潮热发渴。数脉当迟缓，脉因前后度数如法⑬，病者则饥；数脉不时⑭，则生恶疮也。（辨一21）

〔校勘〕《金匱玉函经》：“大便鞲”，均作“大便坚”；“何以言之”后多“脾脉本缓一句”；“本以数脉动脾”，作“今数脉动脾”。《脉经》：除“脉因前后度数如法”作“脉因前后度数如前”（《脉经》注：仲景前字作法）外，余同《金匱玉函经》。

〔词解〕

①趺阳脉迟而缓：此指趺阳脉从容和缓之平脉。

②胃气如经：经，常也。即胃气和调。

③浮则伤胃：胃气受伤，趺阳脉应之而浮。

④数则动脾：动，扰动、伤伐。脾气受到伤伐，脉应之而数。

⑤荣卫内陷：陷，陷落。此可作“虚”字解。意指荣卫因误下受到伤伐而亏虚。

⑥其数先微：指“数则动脾”之数脉转变成微脉。

⑦脉反但浮：指数脉虽转微但不现沉象，反现浮象。

⑧气噫而除：气噫，即噫气，此指暖气。气噫而除，暖气后觉舒适。

⑨脾气不治：指脾失运化转输之职。

⑩邪气独留：指胃中邪热独盛。

⑪心中：指胃。

⑫邪热不杀谷：邪热不能腐熟水谷。

⑬脉因前后度数如法：因，依，顺着。前后，指未病前与邪退后。度数，次数。如法，此有“如一”的意思。脉因前后度数如法，意指邪退后与未病前的脉象至数相同。

⑭数脉不时：意指数脉持续不变。

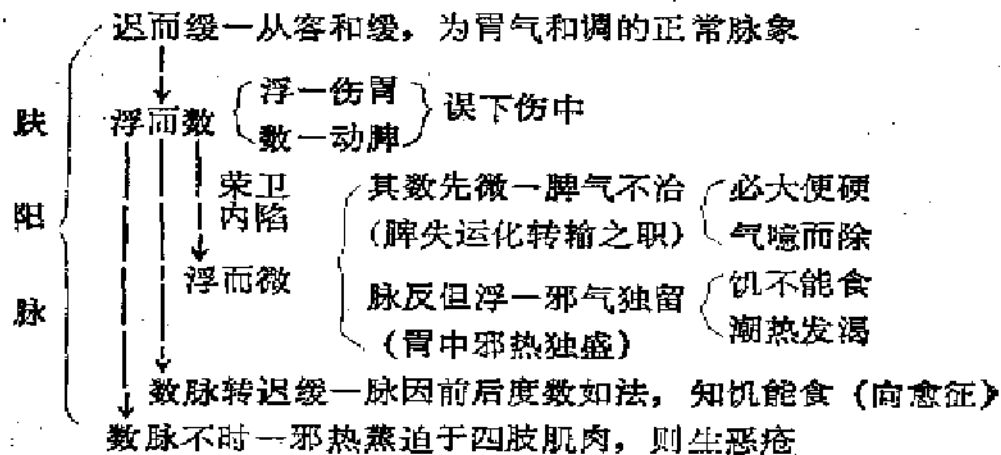
〔语译〕趺阳脉迟而缓，是胃气和调的正常脉象。趺阳脉浮而数，浮是胃气受伤的脉象，数是脾气受伐的脉象，这不是原来的病，是医生误下所造成的。误下后荣卫受到伤伐而亏虚，数脉先转微，但仍现浮象，病人必然大便硬，暖气后觉得舒服。为什么这样说呢？本来数脉是脾气受到伤伐，而数脉转微，因此知道脾失运化转输之职，所以大便硬，暖气后觉得舒服，现在脉反现浮象，只是数脉转微，这是胃中邪热独盛，所以胃中感到饥饿，但邪热不能腐熟消化水谷，就表现潮热发渴。若邪退则脉当迟缓，邪退后与未病前的脉象至数相同，病人就会知饥能食了；如果数脉持续不变，就要发生恶疮。

〔提要〕趺阳脉迟缓（从容和缓）为平，浮数及浮微主误下伤胃动脾致变。

〔释义〕趺阳脉候脾胃之气。趺阳脉迟而缓，指从容和

缓，是胃气和调的正常脉象，属平脉。若其脉浮数，多是误下伤伐脾胃的脉象。误下胃气受伤，脉应之而浮，脾气受伐，脉应之而数。若误下后荣卫受到伤伐而亏虚，则数脉转微，且一般还应显沉象，今仍现浮象，故曰“脉反但浮”，这样病人必大便硬，且噎气后觉得舒服。这是因为跌阳脉数说明误下伤脾，今数又转微，可知误下进一步造成脾气虚弱，脾失运化转输之权，不能为胃行其津液，水谷之气不得运化转输，故见大便硬，气噎而除。然而今浮脉仍在，只是数改微，故其浮是“浮则胃气强”（《伤寒论》249条），这是胃中邪热独盛，即“邪气独留”。而邪热不能腐熟消化水谷，故虽饥而不能食；胃中燥热，则潮热、发渴。如果数脉转迟缓，与未病前的脉象至数相同，是脾胃之气恢复，其病将愈，病人即知饥能食；若数脉持续不变，为邪热留滞之征，以四肢肌肉为脾胃所主，邪热蒸迫于四肢肌肉，热蒸肉腐，就要发生恶疮。

〔讨论〕本条亦难索解，兹用图示分析如下，以资参考：



〔原文〕趺阳脉浮，浮则为虚①，浮虚相搏②，故令气餒③，言胃气虚竭④也。脉滑，则为哕⑤。此为医咎⑥，责虚取实⑦，守空迫血⑧；脉浮，鼻中燥者，必衄也。（辨—26）

〔校勘〕“浮则为虚”，《金匱玉函经》作“浮即为虚”。“鼻中燥者”，《金匱玉函经》作“鼻口燥者”。“必衄也”，《金匱玉函经》无“也”字。

〔词解〕

①浮则为虚：此指胃气虚，胃阳虚浮于外，故趺阳脉应之而浮。

②浮虚相搏：趺阳脉浮与胃气虚并见。

③气餒：餒，通噎（见辨脉法25条词解）。气餒，气逆噎塞。

④虚竭：竭，尽。虚竭，虚之极。

⑤哕：此指呃逆。

⑥医咎：咎，过错。即指医生的过错。

⑦责虚取实：治疗虚证采取治疗实证的方法。

⑧守空迫血：守空，荣为卫之守，故称荣阴为守，守空即指荣阴空虚。迫血，即迫血妄行。

〔语译〕趺阳脉浮，浮是胃气虚，趺阳脉浮与胃气虚并见，所以致气逆噎塞，这说的是胃气虚竭。若趺阳脉滑，则发生呃逆，这是医生的过错，治疗虚证采取了治疗实证的方法，造成荣阴空虚而迫血妄行；趺阳脉浮，鼻中干燥的，必然衄血。

〔提要〕从趺阳脉浮与滑辨噎、哕、衄。

〔释义〕趺阳脉浮，是胃气虚浮于外的脉象，显然其浮而必无力。胃虚气逆，升降失司，故发生气逆噎塞，即所谓气膈。治疗应当以益气和胃为法。若误用诸如汗、下等治疗实证的方法来治疗，即所谓责虚取实，必然异致虚气上逆加重，表现趺阳脉滑而呃逆，即所谓哕。同时徒伤荣血，导致荣血空虚失守，受迫妄行，即所谓守空迫血；若趺阳脉浮且鼻中干燥的，是阳络受伤血不循经，就会出现衄血。

〔讨论〕上条（辨脉法21条）讲趺阳脉浮主胃中“邪气独留”，本条说趺阳脉浮主“胃气虚竭”，说明平脉辨证应当以脉证相参为原则。一种脉象可见于多种病证，反之一种病证可以见多种脉象，故不可为脉象主病所拘泥。

〔原文〕趺阳脉浮而芤，浮者卫气虚，芤者荣气伤，其身体瘦，肌肉甲错。浮芤相搏①，宗气微衰，四属断绝②。（平一35）

〔校勘〕“浮者卫气虚”，成本作“浮者卫气衰”。“宗气微衰”，成本作“宗气衰微”。

〔词解〕

①浮芤相搏：意指浮与芤脉并见，主卫气虚与荣气伤。

②四属断绝：四属，四肢；赵本注：四属者，谓皮、肉、脂、髓……。此以四肢为是。断绝，意指失去营养。

〔语译〕趺阳脉浮而芤，浮是卫气虚，芤是荣气伤，病人身体消瘦，肌肤甲错。浮与芤脉并见，主卫气虚与荣气

伤，则宗气衰微，四肢百骸失去营养。

〔提要〕从趺阳脉浮而芤辨卫气虚与荣气伤，宗气衰微四肢失养。

〔释义〕卫为气，荣为血，荣卫气血之运行赖乎心肺，其生化则源于脾胃。故荣卫气血的盛衰，既可独取寸口以候之，亦可从趺阳脉候之。平脉法23条指出，荣卫气血充盛，则其人皮色鲜明，容颜光泽，语声清脆，毛发荣长，骨髓充盈，肌肉丰腴结实，身体健壮，谓之“强”（见第二章平脉）。今趺阳脉浮而芤，主卫气亏虚荣气耗伤，荣卫虚损，不能熏肤、充身、泽毛，故身体消瘦，肌肤甲错。荣卫两虚，即所谓“浮芤相搏”，宗气亦必衰微。因宗气乃由脾胃所化生的水谷之气与呼吸所吸入的大自然之清气相结合，积于胸中而成。“宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心脉，而行呼吸焉。”

（《灵枢》邪客篇）说明宗气主宰荣卫气血的运行。今宗气衰微，荣卫气血不能布达四肢百骸，四肢百骸失其营养，故曰“四属断决”。

〔原文〕趺阳脉滑而紧，滑者胃气实①，紧者脾气强②，持实击强③，痛还自伤④，以手把刃，坐作疮⑤也。（平—24）

〔词解〕

①胃气实：指胃中有宿食实邪。

②脾气强：指脾感受的邪气强盛。

③持实击强：指胃之邪实与脾之邪强相互搏击，说明脾

胃俱受邪而相互干犯的病机。

④痛还自伤：痛，此概指病痛。意指脾胃俱受邪，互相干犯，脏腑自伤。

⑤坐作疮：疮，通“创”。意指脾胃受邪相互受累，脏腑自己造成创伤。

〔语译〕趺阳脉滑而紧，滑是胃中有宿食实邪，紧是脾中之邪气强盛，胃之邪实与脾之邪强互相搏击，病为自伤，好比用手握住刀刃，自己造成创伤。

〔提要〕趺阳脉滑紧主胃实脾强为患。

〔释义〕本条示人以趺阳脉滑紧辨脾胃邪实。趺阳脉候脾胃之疾，滑与紧皆为邪气有余之脉。趺阳脉滑主胃中有宿食实邪，趺阳脉紧主脾中之邪气强盛，即所谓胃实脾强，是脾胃邪实之候。脾胃同居中州，互为表里。胃实脾强，互相干犯，脾胃自受其害，即所谓“以手把刃，坐作疮也”，比喻颇为精当。

〔原文〕趺阳脉微而紧，紧则为寒，微则为虚，微紧相搏①，则为短气。（平—37）

〔词解〕

①微紧相搏：趺阳脉微主中虚，紧主寒，中虚受寒即微紧相搏的意思。

〔语译〕趺阳脉微而紧，紧主中焦受寒，微主脾胃气虚，中虚受寒，就会短气。

〔提要〕趺阳脉微紧主脾胃虚寒短气。

〔释义〕本条示人以趺阳脉辨脾胃虚寒。趺阳脉候脾胃之疾，趺阳脉紧主脾胃受寒，而趺阳脉微则主脾胃气虚。微紧相搏，中虚受寒，则脾胃虚寒可知。脾胃虚寒，土不生金，肺气即虚，故见短气。

〔讨论〕上条(平脉法24条)以趺阳脉滑紧辨脾胃邪实，本条以趺阳脉微紧辨脾胃虚寒，中焦虚实之辨，可见一斑。

〔原文〕趺阳脉大而紧者，当即下利，为难治。

(平—29)

〔语译〕趺阳脉大而紧的，应当有下利的证候，这是难以治疗的。

〔提要〕趺阳脉大而紧主下利正虚邪实，为难治之候。

〔释义〕本条所说的下利，当指虚寒下利，其脉应以微细迟缓为顺。今趺阳脉大而紧，大为病进，紧为寒甚，乃虚寒下利正虚邪实之象，为逆。下利正虚邪实，攻补两难，故曰“难治”。

〔讨论〕平脉法24条论趺阳脉滑而紧，37条论微而紧，本条论大而紧，虽都论脉紧，但各有滑、微、大的不同兼脉，因此所主虚实各不相同，前后互参，自可相得益彰。

〔原文〕趺阳脉沉而数，沉为实①，数消谷②。紧者，病难治。(平—33)

〔词解〕

①沉为实。沉主里，此指脾胃。沉为实，此指脾胃邪实。

②数消谷：数主脾胃有热，热则消谷。如《脉经》说：“趺阳脉数者，胃中有热，即消谷引食。”

〔语译〕趺阳脉沉而数，沉是脾胃邪实，数是脾胃有热，热则消谷。若出现脉紧的，其病就难以治疗。

〔提要〕趺阳脉沉数主脾胃实热；沉紧主脾胃寒盛，其病难治。

〔释义〕本条以趺阳脉沉数与沉紧示人脾胃寒热与阴阳的辨证及预后。趺阳脉沉而数，主脾胃实热，故消谷引食。此为脾胃阳热过盛所致，其证属阳，较易治疗。若趺阳脉沉而紧，为脾胃客寒至盛，中阳受伐，其证属阴，治疗就困难了。由此说明，阳热证易治，阴寒证难治。

〔原文〕趺阳脉伏①而涩，伏则吐逆，水谷不化，涩则食不得入，名曰关格②。（平—26）

〔词解〕

①伏：《脉经》：“伏脉，极重指按之，着骨乃得。”

②关格：病证名。一般称中焦不纳而吐逆名格，下焦不出为壅闭名关，并称关格（详见第二章平脉法15条与本章平脉法25条）。此称吐逆而食不得入名关格，系指其概称。

〔语译〕趺阳脉伏而涩，伏主吐逆，水谷不能腐熟消化，涩主饮食不能入口，病名叫做关格。

〔提要〕趺阳脉伏涩主关格。

〔释义〕趺阳脉伏是胃气壅实的脉象，涩是脾气失运的脉象。胃气壅实，脾气失运，中焦气阻，升降失司，故致吐

逆，水谷不化，食不得入，名曰关格。此虽名关格，是言其概称，实指格证而言。

〔讨论〕第二章平脉法15条与本章平脉法25条和本条（平脉法26条）均论关格，三条互参，即可对仲景关于关格的论述获得比较全面的认识。平脉法15条从心脉以论关格，平脉法25条从寸口脉以论关格，本条从趺阳脉以论关格，描述了关格的不同脉象，教人凭脉辨证不可偏执一端。一般称吐逆和不得小便并见名关格，只有吐逆者名格，何以此称关格？章虚谷解释说：“中焦病则上下之气不通，故亦名关格”。可备一说。

〔原文〕趺阳脉不出①，脾不上下②，身冷肤硬③。
（平—39）

〔词解〕

①趺阳脉不出：趺阳脉伏匿不现。

②脾不上下：指脾胃失其升降之权。

③肤硬：皮肤不柔和。

〔语译〕趺阳脉伏匿不现，这是脾胃失其升降之权，以致身冷、皮肤不柔和。

〔提要〕趺阳脉不出主脾不上下，身冷肤硬。

〔释义〕脉搏是荣卫气血在经脉中的运行搏动。趺阳脉不出，是中土虚衰，中焦升降失司，荣卫气血不能上下周流所致。脾为阴土，胃为阳土，同居中州，互为表里。脾气主升，胃气主降。中土虚衰，脾胃升降失权，故曰“脾不上

下”。中焦受纳运化失司，荣卫气血失其生化之源，经脉空虚，鼓运无力，因而荣卫气血不能上下周流，故致趺阳脉不出。卫气不温分肉则身冷，荣血不荣肌肤则肤硬。

三、少 阴 脉

本节计2条。少阴脉，属足少阴肾经，在足少阴经太溪穴动脉处候之。少阴脉也是仲景简化的三部诊法的诊脉部位之一，以候肾气。心肾相交，心主血，肾藏精，故少阴脉还可候心肾之气及精血之盛衰。

〔原文〕少阴脉弱而涩，弱者微烦，涩者厥逆。

（平—38）

〔语译〕少阴脉弱而涩，弱则微烦，涩则手足逆冷。

〔提要〕少阴脉弱涩主微烦、厥逆。

〔释义〕本条揭示了少阴脉候心肾精血盛衰的经验，可资临床参考。少阴脉候肾气，而心肾相交，故亦可候心肾之气。心主血，肾藏精。少阴脉弱涩，是精血亏虚、脉道不利之象。阴虚火旺，故见微烦。血少则脉道滞涩不利，以致阴阳之气不相顺接，四肢失于温养，故为厥逆。如《伤寒论》337条说：“凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷者是也。”

〔参考〕《素问》三部九候论说：“故人有三部，部有三候，以决死生，以处百病……下部也，足少阴也……地以

候肾……”《灵枢》动输篇说：“黄帝曰：足少阴何因而动？岐伯曰：冲脉者，十二经之海也，与少阴之大络，起于肾下，出于气街，循阴股内廉，邪入腠中，循胫骨内廉，并少阴之经，下入内踝之后，入足下，其别者，邪入踝，出属附上，入大趾之间，注诸络，以温足胫，此脉之常动者也。”

〔原文〕少阴脉不至①，肾气微，少精血，奔气促迫②，上入胸膈，宗气反聚③，血结心下④，阳气退下⑤，热归阴股⑥，与阴相动⑦，令身不仁⑧，此为尸厥⑨，当刺期门、巨阙。（平—40）

〔词解〕

①少阴脉不至：指少阴脉（太溪穴动脉搏动处）无搏动，少阴脉按不到。

②奔气促迫：奔气，冲逆之气，通称厥气。奔气促迫，即逆气（厥气）促迫。

③宗气反聚：宗气聚积不行。

④血结心下：血结，此指血行逆乱而壅滞不行，非指血液凝结。心下，此概指心下所属部位，非专指胃脘。

⑤阳气退下：阳气下陷。

⑥热归阴股：意指随阳气下陷，阳热归聚于阴部。

⑦与阴相动：阴，此指下焦阴气。动，此指相争的意思。意为下陷之阳热与逆上之阴气相争。

⑧令身不仁：使身体失去知觉。

⑨尸厥：病证名。厥逆而昏不知人，身体失去知觉，

其状如尸，故名。

〔语译〕少阴脉按不到，是肾气微弱，精血不足，逆气促迫，上入胸膈，宗气反而聚积不行，气血壅滞于心下，阳气下陷，阳热归积于阴部，与下焦逆上之阴气相争，使身体失去知觉，这就发生尸厥，治疗应当刺期门、巨阙穴。

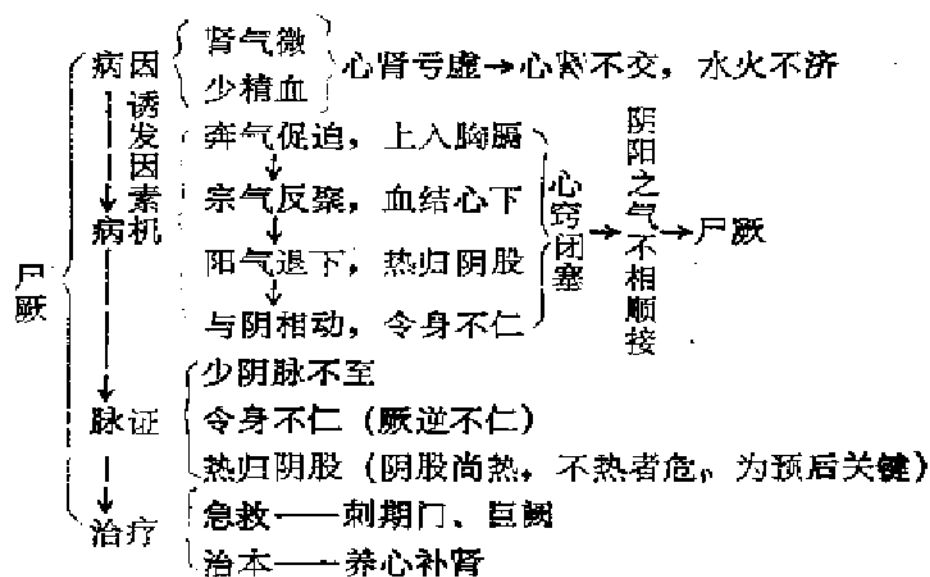
〔提要〕少阴脉不至主尸厥。

〔释义〕本条从少阴脉不至，辨尸厥之因、证及治。少阴脉不至，是肾中真气虚微，精血不足，心肾亏虚，则心肾不交，心火不能下温于肾，肾水不能上滋于心。下焦厥气冲逆，上入胸膈，致宗气聚而不行。宗气者，“积于胸中，出于喉咙，以贯心脉，而行呼吸焉”，为气血运行之始。今宗气聚而不行，则气血壅滞于心下，即所谓“血结心下”。气血壅滞心下，闭塞心窍，则致昏不知人，身体不仁。气血壅滞心下，又致气血逆乱不循常道，上下阴阳乖错。厥气上逆，阳气下陷，阳热归聚于阴部，与逆上之阴气相争，形成阴阳之气对峙，则阴阳之气不相顺接，发为尸厥。其证厥逆不仁，其状若尸，故名尸厥。治疗急当刺厥阴期门穴以运转气机，刺任脉巨阙穴以调和气血，气顺血行，而奏通窍醒神、复脉除厥之功。此示救急之法，惟养心补肾乃治其本。

〔讨论〕本条对尸厥的脉、因、证、治作了精辟论述，理论结合临床，可资参考。“尸厥”出《素问》缪刺论等篇。《素问》缪刺论说：“邪客于手足少阴太阴足阳明之络，此五络皆会于耳中，上络左角，五络俱竭，令人身脉皆动，而形无知也，其状若尸，或曰尸厥……”王冰注曰：“言

其卒冒闷而如死尸，身脉犹如常人而动也。然阴气盛于上，则下气熏上而邪气逆，邪气逆则阳气乱，阳气乱则五络闭结不通，故其状若尸也。以是从厥而生，故或曰尸厥。”道出了尸厥的基本病机，即是因于阴阳乖错，气血逆乱。这与本条所述的精神内容是相一致的。但《素问》说：“令人身脉皆动，而形无知也”，本条则谓“少阴脉不至”，说明对尸厥的辨识又不可囿于诸脉之有无，仍当以脉证合参为凭。

兹将本条原文分析如下：



四、趺阳脉与少阴脉合参

本节计 2 条。趺阳脉候后天脾胃之气，少阴脉候先天之肾气。趺阳脉与少阴脉合参，以候先后天之气。

〔原文〕趺阳脉浮而涩，少阴脉如经①者，其病在脾，法当下利。何以知之？若脉浮大者，气实血虚②也，今趺阳脉浮而涩，故知脾气不足，胃气虚也。以少阴脉弦而浮（赵本注：一作沉）才见，此为调脉③，故称如经也；若反滑而数者，故知当尿（赵本注：玉函作溺）脓④也。（辨—19）

〔校勘〕“少阴脉如经者”，《金匱玉函经》无“者”字，成本“者”作“也”。“若脉浮大者”，《金匱玉函经》作“脉浮而大者”。“故称如经也”，《金匱玉函经》无“也”字。“若反滑而数者，故知当尿脓也”，《金匱玉函经》作“而反滑数者，故知当溺脓也”。

〔词解〕

①少阴脉如经：经，常也。即指少阴脉正常。

②气实血虚：成无己说：“经曰：脉浮而大，浮为气实，大为血虚。若脉浮大，当为气实血虚。”张令韶说：“若脉浮大者，阳明之气实而少阴之血虚也。”以上二注可资参考。

③调脉：经气和调的脉象。

④尿脓：解脓样大便。

〔语译〕趺阳脉浮而涩，少阴脉正常的，是病在脾，按理应当下利。这是根据什么知道的呢？假若脉浮大，是气实血虚，现在趺阳脉浮而涩，所以知道是脾气不足，胃气虚。至于少阴脉才现的弦而浮之脉，这是经气和调的脉象，所以也说是正常的；如果反现滑而数的，则知道是要解脓样的大便了。

〔提要〕趺阳脉浮而涩，少阴脉如经，主中虚下利，少

趺阳脉滑而数，主脓血利。

〔释义〕趺阳脉候脾胃之气，少阴脉候肾气。趺阳脉浮而涩，少阴脉正常，故知病在脾胃而不在肾。《脉经》说：“趺阳脉浮而涩，浮即胃气微，涩即脾气衰，微衰相搏，即呼吸不得，此为脾家失度。”可知趺阳脉浮而涩主脾胃气虚，中虚失运，故曰“法当下利”。“若脉浮大者，气实血虚也”，是插叙趺阳脉不见浮而涩可能出现的脉象及主病，此又当别论。今趺阳脉浮而涩，故可以断定是脾胃气虚。若少阴脉弦而浮，弦为肝脉，浮为肺脉，是少阴脉现肝木与肺金之象，是子母相生，必经气和调，故亦属正常脉象。若少阴脉滑而数，则是下焦客热，火热内伤阴络，就会下利脓血。

〔讨论〕本条揭示水谷下利多属脾胃，脓血下利多属少阴，至今仍有一定的理论和临床意义，可供临证参考。

〔原文〕趺阳脉紧而浮，浮为气①，紧为寒，浮为腹满，紧为绞痛，浮紧相搏②，肠鸣而转③；转即气动④，膈气乃下⑤；少阴脉不出⑥，其阴肿大而虚⑦也。（平一31）

〔词解〕

①浮为气：指为气病。

②浮紧相搏：浮主气病与紧主客寒并见，即所谓寒凝气滞之义。

③肠鸣而转：肠鸣漉漉而运转。

④转即气动：转，指“肠鸣而转”。气动，指壅滞之气

得以运行。意指随着肠鸣漉漉而运转，壅滞之气得以运行。

⑤膈气乃下：膈气，胸膈之气。意指胸膈之气下行。

⑥少阴脉不出：少阴脉伏匿不现。

⑦阴肿大而虚：阴，此指阴部（外生殖器部位）。意指阴部肿大，内无实物，即寒疝瘕聚之类疾患。

〔语译〕趺阳脉紧而浮，浮主气病，紧主客寒，气病则腹满，寒主绞痛，寒凝气滞，则肠鸣漉漉而运转，若壅滞之气得以运行，则胸膈之气下行，若少阴脉伏匿不现，则病人阴部肿大，但内无实物。

〔提要〕从趺阳与少阴脉辨腹满、寒疝。

〔释义〕趺阳脉紧而浮，浮为气病，故主腹满；紧主客寒，寒则收引，故主绞痛。寒凝气滞，即所谓“浮紧相搏”，气与寒相互搏击，则证见肠鸣漉漉而转，即所谓“寒气相搏，则为肠鸣”（见本章一节辨脉法25条）。若转则气动，可使胸膈壅滞之气得以下行。若少阴脉伏匿不现，是肾气亦虚，阳气不行，则寒气下转，积结于下焦，聚结于阴器，以致阴部肿大。但以其为阴寒之气聚而内无有形之物，故谓之“肿大而虚”，取有形为实，无形为虚之义。此属寒疝瘕聚之类疾患。

〔讨论〕《医宗金鉴》认为：“阴肿大而虚之‘虚’字，当是‘痛’字。”认为阴肿大而痛，乃为疝。可备一说。

《脉经》载有与本条类似条文，但文字出入很大。兹录于下，以供参考：“趺阳脉紧而浮，紧则为痛，浮则为虚，虚则肠鸣，紧则坚满。”

第四章 平脉预后

本章归纳了辨脉法、平脉法二篇有关平脉预后的条文，主要内容包括预后原则及一些预后脉象。

一、预后总则

本节计4条。主要论述了平脉预后的一些基本原则，如脉象对预后的意义及平脉预后的理论法则等。

〔原文〕师曰：脉病①人不病，名曰行尸②，以无王气③，卒④眩仆，不识人⑤者，短命则死。人病脉不病，名曰内虚⑥，以无谷神⑦，虽困无苦⑧。（平—19）

〔词解〕

①脉病：脉表现出病象。

②行尸：行尸走肉的意思，喻虽生犹死。

③王气：王，通“旺”。即旺气。此指脏腑生机。

④卒：通“猝”（cù），忽然。

⑤不识人：不省人事。

⑥内虚：此指谷气不充。

⑦谷神：即谷气。因其为水谷之精气，故称谷神。

⑧虽困无苦：困，此可作“病”解。苦，此可作“害”解。虽困无苦，意指虽病无害。

〔语译〕老师说：脉象有病而人不觉得有病的，名叫做行尸，由于脏腑已无生机，因此随时可能突然晕倒，不省人事，短命而死。人觉得有病而脉象正常的，名叫内虚，这主要是谷气不充，所以虽病无害。

〔提要〕脉病与人病的预后吉凶。

〔释义〕脉象反映脏腑、气血、荣卫、阴阳的盛衰强弱，生命不息则脉搏不已。故成无己说：“脉者，人之根本也。”若脉象有病，虽形体未见有病，但脏腑气血已亏，生机欲绝，即所谓“以无王气”，虽生犹死，故名行尸。一旦脏腑生机竭绝，突然晕倒，昏不识人，即短命死亡，而不能尽其天年。对此，医生若能早察脉象之隐患，图机于早，或可防患于未然。若形体虽有亏损，而脉象正常，是根本未亏，这不过是谷气一时不充，故名“内虚”。这种情况，一待谷气充盛，自得康复，所以说“虽困无苦”。

〔讨论〕本条揭示了脉象对预后的重要意义。《内经》与《难经》均有类似的论述（详见本条参考），足证古人之重视。脉象一般反映人体正气的盛衰强弱，与疾病的发生、发展及变化有密切的关系，因此对预后具有重要的意义。作为一个临床医生，必须对诊察脉象给予高度重视，这不仅是对脉辨证所必须，也是对疾病的预后所必须，甚至可以防

患于未然。当然，也不能夸大脉诊的作用。总之，应持实事求是的科学态度。

本条指出，脉病“无王气”者预后不良，随时可能猝死，故名行尸；而人病“无谷神”者尚无大害，可以康复，而名内虚。从现代医学来看，的确“王气”比“谷神”更为重要。谷气虽为后天之本，但从现代的医疗技术来说，不足者是可以采取有效的手段（如输液等）给以补充的。而脏腑的生机，即所谓“王气”，一旦受到损伤，尽管现代医学关于脏器移植的技术取得了很大成就，还是难以靠人为的手段来有效地维持。特别是对一些心血管疾病患者来说，对其脉象进行细致的诊察和认真的研究，以决“王气”的盛衰，这对及早查出隐患，进行有效防治，确有重要的临床意义。

本条对人病而脉不病的论述，只能说是相对而言。虽说脉象反映正气的盛衰，但不能说与形病就毫无关系。正气与形体是密切相关的，是本质与现象的对立统一。因此，不可泥于“虽困无苦”之说，应当辩证地看待。正如徐灵胎所说：“病有浅深，浅则仅属形病，深则脉亦病矣”，堪称中的。

〔参考〕《素问》方盛衰论说：“形气有余，脉气不足死；脉气有余，形气不足生。”《难经》二十一难说：“经言人形病脉不病曰生，脉病形不病曰死，何谓也？然，人形病脉不病，非有不病者也，谓息数不应脉数也，此大法。”

〔原文〕问曰：脉有相乘①，有纵②有横③，有

逆④有顺⑤，何谓也？师曰：水行乘火，金行乘木，名曰纵；火行乘水，木行乘金，名曰横；水行乘金，火行乘木，名曰逆；金行乘水，木行乘火，名曰顺也。

（平—11）

〔校勘〕“纵”，《脉经》均作“从”。“何谓也”，成本作“何也”。“名曰顺也”，《脉经》无“也”字。

〔词解〕

①相乘：此概指五行相乘、相侮。

②纵：纵(zōng)，竖、直，与横相反。此指五行相乘，乘其所胜，即五行克之过度，如水克火、金克木等（见原文）。

③横：与纵相反。此指五行侮其所不胜，即指五行反克，如火侮水、木侮金等（见原文）。

④逆：与顺相反。此指五行之子乘母，如水乘金、火乘木等（见原文）。

⑤顺：与逆相反。此指五行之母乘子，如金乘水，木乘火等（见原文）。

〔语译〕问：脉有互相乘侮，有纵、有横、有逆、有顺，这说的是什么呢？老师答：水乘火、金乘木，名叫纵；火乘水、木乘金，名叫横；水乘金、火乘木，名叫逆；金乘水、木乘火，名叫顺。

〔提要〕以五行乘侮释脉理，并作为预后的依据。

〔释义〕脉应五脏，五脏各禀五行之气，故脉亦应五行。肝属木，其脉应于春而微弦；心属火，其脉应于夏而微钩（洪）；脾属土，其脉应于长夏而微濡弱（缓），肺属

金；其脉应于秋而微毛（浮）；肾属水，其脉应于冬而微石（沉）。四时各现本脉，是谓平脉。若五脏有所克贼，则至其时而不应其脉，或非其时而现其脉，这就是脉之五行乘、侮所然，是为病脉，并有纵、横、逆、顺等不同表现。如夏不现心脉之微洪，反现冬令肾脉之沉象，这就是水行乘火，是乘其所胜，叫做“纵”；反之，冬不现肾脉之微沉，反现夏令心脉之洪象，这就是火行乘水，是侮其所不胜，叫做“横”。若秋不现肺脉之微浮，反现冬令肾脉之沉象，这就是水行乘金，是子盗母气，叫做“逆”；反之，冬不现肾脉之微沉，反现秋令肺脉之浮象，这就是金行乘水，是母病及子，叫做“顺”。若以寸、关、尺三部分候脏腑脉法而论，亦可仿此。总之，本条说明四时五脏之脉，贵得和平，太过或不及者则殃。

〔原文〕问曰：脉病①，欲知愈未愈者，何以别之？答曰：寸口、关上、尺中三处，大小、浮沉、迟数同等，虽有寒热不解者，此脉阴阳为和平，虽剧当愈。（辨—15）

〔校勘〕“欲知愈未愈者”，《金匱玉函經》无“者”字。《脉经》载本条为：“问曰：假令病人欲差，脉而知愈，何以别之？师曰：寸、关、尺，大小、迟疾、浮沉同等，虽有寒热不解者，此脉阴阳为平复，当自愈。”

〔词解〕

①脉病：脉，此作诊察解。脉病，意指诊察疾病。

〔语译〕问：诊察疾病，想知道是否向愈，怎样辨别呢？答：如果寸口、关上、尺中三部脉象的大小、浮沉、迟数同等，虽然还有寒热不退的症状，但脉象已显示阴阳和平，这时尽管病情看来还较重，但必当向愈。

〔提要〕脉阴阳和平者，其病虽剧当愈。

〔释义〕本条以寸口、关上、尺中三部脉象的大小、浮沉、迟数同等为阴阳和平之脉，旨在说明寸、关、尺三部所候五脏六腑之气和调，脉来应四时阴阳五脏之气。这是正气已和之象，所以说是阴阳和平之脉。这里所谓“同等”，是取其“匀调”之意。意指寸、关、尺三部脉象各现其本位，协调一致。并非指此三部脉大者均大，小者均小，浮者皆浮，沉者皆沉，迟者都迟，数者都数。若是如此，岂能谓之病愈？如程知所说：“大小、沉浮、迟数同等，谓三部九候无相失也。盖大不甚大，小不甚小，浮不甚浮，沉不甚沉，迟不甚迟，数不甚数，为冲和平等之象也。”因此，虽有寒热不解，甚还病情虽剧，而脉象已归平和，故曰当愈。这与本节平脉法19条所论“人病脉不病，名曰内虚，以无谷神，虽困无苦”的精神，是相一致的。诚如成无己所说：“三部脉均等，即正气已和，虽有余邪。何害之有。”

〔讨论〕诊察疾病，理当脉证合参。一般来说，脉证相符或阴病见阳脉者，预后良好；脉证不符或阳病见阴脉者，预后不良。此但凭脉象以预后，是本“脉者，人之根本”的精神，强调脉象对预后的重要意义。若据此以重脉轻证，那又是十分错误的了。

〔原文〕问曰：凡病欲知何时得，何时愈？答曰：假令夜半得病者，明日日中愈；日中得病者，夜半愈。何以言之？日中得病夜半愈者，以阳得阴则解也；夜半得病明日日中愈者，以阴得阳则解也。（辨一17）

〔校勘〕“假令夜半得病者”及“日中得病者”，成本均无“者”字。“明日日中愈”及“夜半得病明日日中愈者”，《金匱玉函经》均无“明日”二字。

〔语译〕问：凡是得病后，如何判断何时得的病应当在何时愈呢？答：假使夜半得病的，明日中午可以好转；中午得病的，夜半可以好转。为什么这样说呢？中午得病夜半好转的，这是阳得阴则解的缘故；夜半得病明日中午好转的，这是阴得阳则解的缘故。

〔提要〕阴阳自和者，其病必愈。

〔释义〕本条以阴阳学说作为平脉预后的理论法则。人与自然息息相通，人体阴阳之气随昼夜阴阳之气而相应变化，这与疾病的发生、发展及变化不无关系。日中得病病在阳，夜半主阴，故可得阴阳调和而解；夜半得病病在阴，日中主阳，故亦可得阴阳调和而解。正如成无己所说：“日中得病者，阳受之；夜半得病者，阴受之。阳不和，得阴则和，是解以夜半；阴不和，得阳则和，是解以日中。经曰：用阳和阴，用阴和阳。”深得本条要旨。

〔讨论〕阴阳调和，是中医学的基本生理观；阴阳失调，是中医学的基本病理观。凡病，阴阳得和者，必自愈。

这是仲景对疾病预后的基本指导思想。如《伤寒论》说：

“凡病，若发汗，若吐，若下，若亡血，亡津液，阴阳自和者，必自愈。”（58条）本条即以此作为平脉预后的理论法则，并作为预测病解机转的理论依据，确有重要的理论指导意义。然而，临床实际病情是非常复杂的，本条只是列举阴阳自和而病解之例，因此只宜领会其精神，决不能局限于具体病解之时。

二、预后脉象

本节计11条。主要论述了一些预后的具体脉象，如汗出而解脉、不汗出而解脉、欲解脉、死证脉等。

（一）濈然汗出而解脉

〔原文〕问曰：伤寒三日，脉浮数而微，病人身凉和者，何也？答曰：此为欲解也，解以夜半。脉浮而解者，濈然汗出也？脉数而解者，必能食也；脉微而解者，必大汗出也。（辨一14）

〔校勘〕“脉浮数而微”，《金匱玉函经》作“其脉浮数而微”。

〔语译〕问：患伤寒病三天，脉象浮数而微，病人身上凉和的，这是什么征象呢？答：这是病将解除的现象，并且将在夜半时解除。脉浮而病解，必见濈然汗出；脉数而解，必然能食；脉微而解，必然大汗出。

〔提要〕脉浮数而微主正胜邪却，濇然汗出而解。

〔释义〕伤寒三日，若脉浮数而大，病人身热不退，是病进的表现；今脉浮数而微，病人身凉和，是正胜邪却，病将得解的佳兆。阳不和者得阴则和，故知解以夜半，这与上节辨脉法17条所论的精神一致。从浮数而微的脉象来分析，脉浮主邪在表，数为胃气盛，微则邪气衰，是正胜邪却之征。正气驱邪达表而出，故见濇然汗出而病解，并见能食。这里必须指出，浮、数、微的主证与机理是统一的，必须综合起来认识才能正确理解。原文分而言之旨在析理，不能据此而将其割裂。

（二）战汗而解脉

〔原文〕问曰：病有战①而汗出，因得解者，何也？答曰：脉浮而紧，按之反芤，此为本虚②，故当战而汗出也。其人本虚，是以发战；以脉浮，故当汗出而解也。若脉浮而数，按之不芤，此人本不虚，若欲自解，但汗出耳，不发战也。（辨一11）

〔校勘〕“因得解者”，《金匱玉函经》作“自得解者”。“脉浮而紧”，《金匱玉函经》作“其脉浮而紧”。

“此人本不虚”，《金匱玉函经》无“人”字。“不发战也”，《金匱玉函经》作“即不发战也”。

〔词解〕

①战：寒慄颤抖。

②本虚：意指原本正气不足。

〔语译〕问：有些病先经战慄而后汗出，因此而得解除的，这是什么道理呢？答：脉象浮而紧，但按之反现芤象，这是正气本虚，所以必当先战抖而后汗出。因为病人原本正气不足，所以发生战抖；又根据脉浮，所以必当汗出而解。如果脉浮而数，按之不芤，这样的病人原本正气不虚，若自行病解，则只出汗，不发生战抖。

〔提要〕脉浮紧而芤主本虚，得战汗而解；浮数而不芤，主本不虚，得汗出不战而病解。

〔释义〕本条揭示战汗的机理，乃因正气本虚。脉浮紧或浮数，都是正邪相争于表的脉象。脉浮主表，正气驱邪达表而出，其病必从汗解。但若其脉按之反芤，芤则为虚，是正气不足之象，如果正虚不甚，还能奋起抗邪，但因其虚而又一时不能胜邪，值正气奋力抗邪达表之际，可见寒慄振颤，即所谓“发战”，这是正气奋力抗邪而相持的表现。但脉浮之象不变，说明正邪仍相争于表，一旦正胜邪却，则遂汗出而病解。这就是所谓战汗而解。若其脉按之不芤，是正气不虚，正气能直驱外邪出表，故但汗出得解，而不发战。从上述可见，正气的虚与不虚，是战汗与否的主要机理。

〔讨论〕凡正气驱邪外出欲解，若正气虚者必得战汗而解，不虚者但汗出而解，这对于外感病的预后及护理确有重要指导意义，故为历代医家所宗。这里所谓“本虚”，既可是原本正气不足，也可见于误治而伤正，这在《伤寒论》中即有实例。如104条：“凡柴胡汤病证而下之，若柴胡汤

证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。”即其例。柴胡证虽经误下，但柴胡证仍在，惟误下后伤正，正气较弱，今得柴胡汤之助，使正气振奋，能驱邪达表，但正气尚未胜邪时，即见发战，及至正胜邪却，遂发热汗出而解。

（三）不战而汗出得解脉

〔原文〕问曰：病有不战而汗出解者，何也？答曰：脉大而浮数，故知不战汗出而解也。（辨一12）

〔校勘〕“脉大而浮数，故知不战汗出而解也”，《金匱玉函经》作“其脉大而浮数，故不战汗出而解也”。

〔语译〕问：有的病不发生战慄，而汗出病解，这是什么道理呢？答：这是因为脉大而浮数，所以知道不战慄而汗出病解。

〔提要〕脉大而浮数主正气充足，可见不战而汗出得解。

〔释义〕脉象大而浮数，是表病而正气旺盛之象，正气足以驱邪外出，故见不战而汗出得解。这与上条（辨一11）“若脉浮而数，按之不芤，此人本不虚，若欲自解，但汗出耳，不发战也”同理。一云浮数之脉按之不芤，一云浮数之脉而兼洪大，互文见义。

（四）不战不汗出而解脉

〔原文〕问曰：病有不战不汗出而解者，何也？答

曰：其脉自微，此以曾发汗，若吐、若下、若亡血，以内无津液，此阴阳自和，必自愈，故不战不汗出而解也。（辨—13）

〔校勘〕本条在《金匱玉函经》为：“问曰：病有不战复不汗而解者，何也？答曰：其脉自微，此以曾发汗，若吐、若下、若亡血，内无津液，阴阳自和，必自愈，故不战不汗而解也”。“此以曾发汗”，成本作“此以曾经发汗”。

〔语译〕问：有的病不战慄不汗出而自然病解，这是什么道理呢？答：这是因为脉微，脉微的原因是曾经使用过发汗，或催吐、攻下等治疗，或曾经失血，以致体内津液亏耗，象这样的情况阴阳自和的可以自行向愈，所以说是不战慄也不汗出而得病解。

〔提要〕脉微而阴阳自和者不战不汗出而解。

〔释义〕有不战慄也不汗出而自然向愈的病证，其证必脉自微。此脉微，是正与邪俱衰的表现，多见于外感病后期。由于病中曾经使用过发汗、催吐、攻下等治疗，或病中曾经失血，以致津液亏耗，故而正气见衰；但同时既经汗、吐、下等治疗，邪气亦衰，正与邪俱衰而见脉微。津液耗伤无以作汗，而邪气已微亦无须汗解；同时正与邪微亦无相争，因而也无战慄可言。所以，其病解则不战慄也不汗出。惟此正邪俱衰之际，若得阴阳自和，正复邪自却，则其病可得自愈，即不战慄也不汗出而解。必须指出，此脉微示正邪俱衰，除仅见微弱之象外必不相兼其它病脉，若兼现外邪不

解脉象，则就如本节辨脉法11条所说，要得病愈就要战汗而解了。

〔讨论〕本条精神，与《伤寒论》所说“凡病，若发汗，若吐，若下，若亡血，亡津液，阴阳自和者，必自愈。”（58条）是完全一致的。在正邪俱衰的情况下，若借人体内部自身的调节作用，阴阳之气能趋于新的平衡统一，其病可不经战慄及汗出而自愈。但必要时仍可借助药物的治疗作用，本条着重强调人体自身调节功能的防病作用，确具有重要的理论意义；即使药物治疗，仍需通过机体内部的作用而发挥效果，这一认识已越来越为医家所重视。

（五）欲解脉

〔原文〕脉阴阳俱紧①，至于②吐利，其脉独③，不解；紧去入安④，此为欲解。若脉迟，至六、七日不欲食，此为晚发⑤，水停故也，为未解；食自可者，为欲解。病六、七日，手足三部脉皆至⑥，大烦而口噤⑦不能言，其人躁扰者，必欲解也。若脉和⑧，其人大烦，目重⑨，脸内际黄⑩者，此欲解也。（辨—31）

〔校勘〕《金匱玉函经》：“紧去入安”，作“紧去人安”；“大烦而口噤不能言”，无“而”字；“必欲解也”，作“此为欲解”；“脸内际黄者”，无“者”字；“此欲解也”，作“亦为欲解”。成本：“脸内际黄者”，作“脸内际黄者”，“此欲解也”，作“此为欲解也”。

〔词解〕

①脉阴阳俱紧：阴，尺脉。阳，寸脉。即尺、寸脉俱紧，实则寸、关、尺三部均现紧脉。

②至于：此作“已经”解。

③其脉独：此意指上述阴阳俱紧之脉独甚。

④紧去入安：紧，即上述脉阴阳俱紧。入，此作“里”解。紧去入安，意指紧脉退去则里气安和。《金匱玉函经》作“紧去人安”，亦可备一说。

⑤晚发：指续发的疾病。

⑥手足三部脉皆至：手足三部脉，指寸口、趺阳、少阴脉。皆至，此可作“协调”解。

⑦口噤：口唇紧闭不开。

⑧脉和：脉象平和，即脉象正常。

⑨目重：眼胞微肿，自觉坠重。

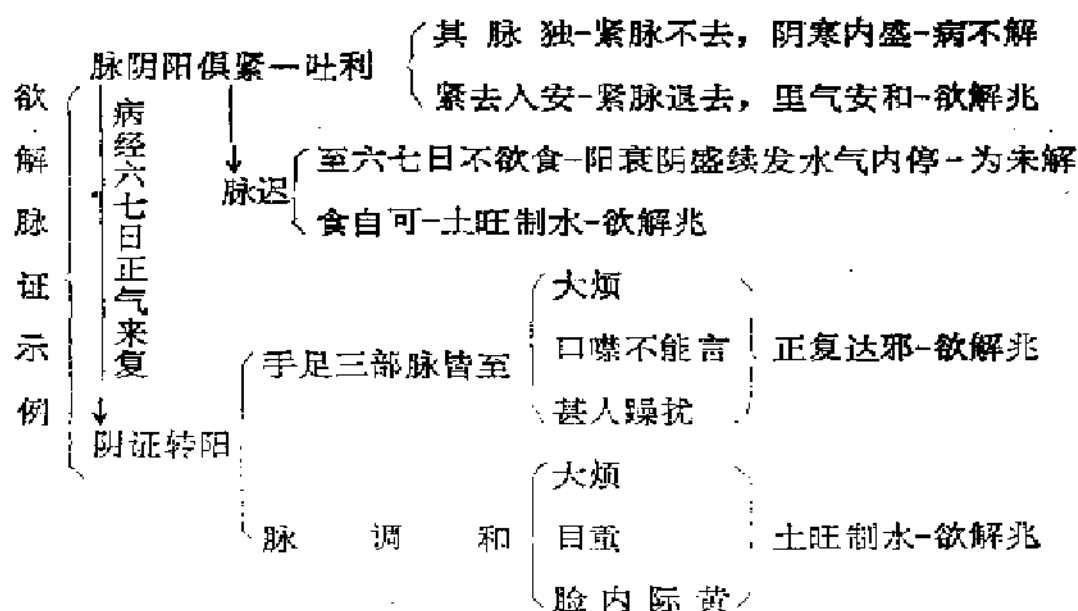
⑩脸内际黄：脸中央部分色黄。成本作“脸内际黄”，可作参考。

〔语译〕尺、寸脉俱紧，已经吐利，其紧脉独甚者不解；紧脉退去，则里气安和，这是向愈佳兆。如果脉迟，到六、七日不想吃，这是续发的疾病，是由于水气内停的缘故，为未解；饮食正常的，是将愈。病经六、七日，手足寸口、趺阳、少阴脉协调，虽见大烦而口唇紧闭不能说话，病人躁扰，必然向愈。如果脉象平和，而病人大烦，眼胞微肿坠重，脸中央部分色黄，这也是向愈的表现。

〔提要〕欲解脉证示例。

〔释义〕病人寸脉、尺脉俱紧，阴寒内盛，必见吐利之证。如《伤寒论》283条说：“病人脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也，此属少阴，法当咽痛而复吐利。”若脉紧独甚，则病不解。紧脉退去，是邪去正安之象，为欲解佳兆。如《伤寒论》287条说：“少阴病，脉紧，至七八日，自下利，脉暴微，手足反温，脉紧反去者，为欲解也，虽烦，下利必自愈。”若脉象转迟，至六、七日不欲食，这是阳衰阴寒内盛而续发水气内停所致，为病情加重，自是未解；但若饮食自可，这是土旺能制水，故曰“为欲解”。病经六、七日，寸口、趺阳、少阴三部脉协调，是正气来复的征兆，虽见大烦、口噤不能言、躁扰不安，而这正是正复达邪的表现，故曰“必欲解也”。如果脉象调和如常，更是正气康复之征，虽见大烦、目重、脸内际黄，这都是土旺制水的表现，故亦曰“此欲解也”。正如本章上节辨脉法15条所说：“寸口、关上、尺中三处，大小、浮沉、迟数同等，虽有寒热不解者，此脉阴阳为和平，虽剧当愈。”

〔讨论〕本条列举欲解脉证，教人要作正确的预后判断，必须脉证合参。文中多次提到的“欲解”，意在说明预后良好，并非说是定能坐以待愈。就其所举欲解之证来看，尚须注意随证施治，方不致耽误患者病情。因此，应着重领会文中关于预后判断的原则精神。兹将原文精神分析如下：



〔原文〕问曰：上工①望而知之，中工①问而知之，下工①脉而知之，愿闻其说。师曰：病家人请云，病人苦发热，身体疼，病人自卧；师到，诊其脉，沉而迟者，知其差也。何以知之？若表有病者，脉当浮大，今脉反沉迟，故知愈也。假令病人云腹中卒痛②，病人自坐；师到，脉之，浮而大者，知其差也。何以知之？若里有病者，脉当沉而细，今脉浮大，故知愈也。（平—3）

〔校勘〕“若表有病者”，成本无“若”字。“腹中卒痛”，成本作“腹内卒痛”。

〔词解〕

①上工、中工、下工：工，此指医生。上、中、下，是对医生技术高低的划分。

②卒痛：卒，通猝。即指忽然疼痛。

〔语译〕问：高明的医生，望病人的形色就能知道病情；中等水平的医生，要通过问诊才能知道病情；普通的医生，还要借助脉诊才能知道病情。我希望知道其中的道理。老师说：病家人来请医生说，病人发热难受，身体疼痛，但能安卧；医生到，诊得病人脉象沉而迟的，即知其病将愈了。如何知道的呢？因为发热，身痛有表证，脉象应当浮大，现在脉象反而沉迟，所以知道将愈。假使病人说腹中突然疼痛，但病人却能安然自坐；医生到，诊得其脉浮而大的，就知道其病将愈了。如何知道的呢？因为腹痛是有里证，脉象应当沉而细，现在脉浮大，所以知道将愈。

〔提要〕表病脉沉迟、里病脉浮大者，其病将愈。

〔释义〕病人发热、身体疼痛、脉浮大，是表邪未解，自当不能安卧；今虽发热、身疼，但病人能安卧，浮大之脉转沉迟，是正复邪却，故知将愈。必须指出，此所说的脉“沉迟”是与浮大相对而言，意在说明浮大的脉象转现平和，以示正复邪却的病愈机转，非里寒之脉沉迟可言。若真为里寒之沉迟脉，岂能说“知其差也”。又如病人说腹中突然疼痛，这是里气不和，痛则必碾转号叫，不能安坐，脉象沉细；今病人自坐，脉象浮大，这是里气已和，故知将愈。这里所谓脉“浮大”，同样是与沉细相对而言，意在说明沉细的脉象转现和平，以示里气转和的病愈机转，也非上述表证之脉浮大可言。若是，亦不能说“知其差也”。

〔讨论〕本条精神内容可分析如下：

脉证预后示例	表病	发热，身痛	望诊—不能安卧 脉诊—脉当浮大	表未解—不差
		发热，身痛	望诊—病人自卧 脉诊—脉沉而迟	正复邪却—知其差
	里病	腹中卒痛	望诊—不能安坐 脉诊—脉当沉细	里不和—不差
		腹中卒痛	望诊—病人自坐 脉诊—脉浮而大	里气和—知其差

从以上可以看出，示例中虽强调脉象的预后，但对病情总的诊察仍是以四诊合参为凭。这里特别突出了望诊的配合运用，说明细致观察病情的重要实际意义。有其病，必有其脉；有其脉，必有其病。但在临床复杂的病情中，还多有脉证不符的情况。因此，不可能单凭一种诊法而能全面了解病情，必须四诊合参。正如《素问》五藏生成篇所说：“能合脉色，可以万全。”文中所谓“上工望而知之，中工问而知之，下工脉而知之”，不过是强调四诊中尤以望诊难以掌握，非高明的医生不能运用如神，并非割裂四诊的运用。所以下文即列举对表病与里病的预后为例，说明“脉色”的结合运用。古人是非常重视四诊的结合运用的。如《灵枢》邪气藏府病形篇说：“故善调尺者（此指诊尺肤），不待于寸，善调脉者，不待于色。能参合而行之者，可以为上工，上工十全九；行二者，为中工，中工十全七；行一者，为下工，下工十全六。”运用每一种诊法所掌握到的病情，都只是疾病本质的一个方面的表现，这些方面的病情是紧密联系的，共同反映疾病的本质。因此，只有四诊合参，才可能对疾病作出

比较全面的准确判断。正如《灵枢》邪气藏府病形篇所说：

“夫色脉与尺之相应也，如桴鼓影响之相应也，不得相失也。此亦本末根叶之出候也，故根死则叶枯矣，色脉形肉不得相失也。故知一则为工，知二则为神，知三则神且明矣”。

（六）死证脉

〔原文〕脉浮而滑，浮为阳，滑为实；阳实相搏①，其脉数疾，卫气失度②，浮滑之脉数疾，发热汗出者，此为不治。（辨—33）

〔校勘〕“浮为阳，滑为实”，《金匱玉函经》作“浮即为阳，滑即为实”。

〔词解〕

①阳实相搏：脉浮主阳热盛于外，脉滑主邪热实于内，表里热实，即所谓阳实相搏”。

②卫气失度：意指卫气失去运行常度。

〔语译〕脉浮而滑，浮为阳热盛于外，滑为邪热实于里，表里热实，其脉数疾，卫气失去运行常度，浮滑之脉转数疾，发热汗出的，这是不治之候。

〔提要〕浮滑之脉转数疾，阳亢阴竭者不治。

〔释义〕脉浮滑主阳热亢盛，浮为阳热盛于外，滑为邪热实于里，表里热实，即“阳实相搏”。浮滑之脉转数疾，是阳热亢极，其病理基础是卫气运行急速而失去常度，即所谓“卫气失度”。若更见发热汗出，这是孤阳独亢、阴液将竭的表现。如《素问》生气通天论说：“阳强不能密，阴气乃绝，

阴平阳秘，精神乃治，阴阳离决，精气乃绝。”故曰“此为不治”。

〔讨论〕本条所论不治之候，辨证关键在脉数疾而发热汗出不止。阳热亢极而津液随汗泄不止，必将致阴竭而亡。究其证，似与“阴阳交”相类。如《素问》评热病论说：“黄帝问曰：有病温者，汗出辄复热，而脉躁疾不为汗衰，狂言不能食，病名为何？岐伯对曰：病名阴阳交，交者死也。”临床见高热不退，汗出不止，更出现脉数疾者，确是阳亢阴竭之危候，急当清热救阴。

〔原文〕伤寒咳逆上气①，其脉散者死，谓其形损②故也。（辨一34）

〔校勘〕《金匱玉函经》载本条为：“脉散，其人形损，伤寒而咳上气者死。”

〔词解〕

①咳逆上气：咳逆，咳喘。上气，气壅于膈上而不得下行。本条所论咳逆上气与《金匱要略》“咳嗽上气”的病因病机有所不同：本条所论咳逆上气主要是外感风寒伤肺，《金匱要略》咳嗽上气多为水饮内停，因外感风寒而触发。

②形损：形体损伤。

〔语译〕外感风寒，发生咳逆上气，脉散的是死候，这是脉散并见形损的缘故。

〔提要〕脉散形损为死候。

〔释义〕外感风寒犯肺，咳逆上气，一般并非死候。此条之所以论其死者，完全取决于“脉散”与“形损”。散脉，是

浮散无根之脉，主元气离散，脏腑之气将绝。今伤寒咳逆上气见脉散，是肺气上脱之征。《灵枢》决气篇说：“上焦开发，宣五谷味，熏肤、充身、泽毛，若雾露之溉，是谓气。”肺气上脱，上焦失于开发，致皮毛枯槁，大肉脱落，即所谓形损。今脉散而又见形损，肺气之绝不亦明乎。故谓此脉散而形损是藏真告竭、形气皆绝的死候。《灵枢》玉版篇说：“咳脱形，身热，脉小以疾，是谓五逆也，如是者，不过十五日而死矣”。可资佐证。

〔原文〕问曰：二月得毛浮脉①，何以处言②至秋当死？师曰：二月之时，脉当濡弱③，反得毛浮者，故知至秋死，二月肝用事④，肝属木，脉应濡弱，反得毛浮脉者，是肺脉也，肺属金，金来克木，故知至秋死。他皆仿此⑤。（平—16）

〔校勘〕“肝属木，脉应濡弱”，成本作“肝脉属木，应濡弱”。“反得毛浮脉者”，成本无“脉”字。

〔词解〕

①毛浮脉：毛，《难经》十五难说：“轻虚以浮，故曰毛”。此指秋令肺脉。

②处言：告诉。

③脉当濡弱：指脉当现春令肝脉之微弦濡弱而长。

④二月肝用事：二月为肝当令之期，肝气发挥主持作用。

⑤他皆仿此：指其余各季相克脉象的预后判断，均可按此例类推。

〔语译〕问：二月现毛浮脉象，为什么可以说到秋季当死？
老师答：二月时节，脉象应当微弦濡弱而长，反而现毛浮脉，所以知道至秋季当死，这是因为二月是肝当令之期，肝气发挥主持作用，肝属木，脉象应当现春令肝脉之微弦濡弱而长，今反而出现毛浮脉，这是肺脉，肺属金，金克木，所以预知到秋季当死。其余各季相克脉象的预后判断，均可按此例类推。

〔提要〕以春令肝脉为例，说明现相克脉象者预后不良。

〔释义〕二月仲春，为肝木当令，脉应五脏四时，故其脉应以微弦濡弱而长者为平。若反现毛浮脉，是春令见肺脉，为金克木之象。虽然如此，但时值二月肝当令之期，靠春令生发之气资助，尚可暂时不见受其大害。若至秋令肺金主气，则肺金必持其旺气克之，肝无所持，遂不堪克伐，生机告绝，必见死候，故曰至秋当死。余皆可仿此。

〔讨论〕本条即本章上节平脉法11条所说“金行乘木，名曰纵”之例。通过本条之例，说明脉现纵、横、逆、顺等乘侮之象者，多预后不良。对本条死期预断的认识，只宜领会其意义，即脉象反映脏腑生机受害者则预后不良，不宜拘于具体季节。但从生理活动与昼夜、四时的周期性联系来看，似尚有道理。其间是否真有一定的科学道理，还待研究验证。

〔原文〕师曰：寸脉下不至关为阳绝①；尺脉上不至关为阴绝②。此皆不治，决死也。若计其余命③生死之期，期以月节克之④也。（平—18）

〔校勘〕“生死之期”，成本作“死生之期”。

〔词解〕

①阳绝：有两种解释：其一，绝作“尽”解，则阳绝指“阳竭”；其二，绝作“极”解，则阳绝指“阳极”。

②阴绝：与阳绝同样有两种解释：一作“阴竭”；一作“阴极”。

③余命：指还能生存的时间。

④期以月节克之：期，此指生死之期。月节，月令、季节。之，代词，此代阳绝、阴绝。全句意思说，生死之期根据月令、季节与阳绝、阴绝发生相克的时期来决定。

〔语译〕老师说：寸脉不下行至关是阳绝；尺脉不上行至关为阴绝。这都是不治之证，决定要死。如果要计算其还能生存多久的生死之期，可以根据月令、季节与阳绝、阴绝发生相克的时期来决定。

〔提要〕辨阳绝、阴绝脉象及生死之期。

〔释义〕寸脉主阳，尺脉主阴，关脉主阴阳升降出入。平人寸、关、尺三部脉象，上下脉气交通，是阴阳相交，升降出入不息之象。若寸脉下不至关，是阳不能下交于阴，故谓之阳绝；尺脉上不至关，是阴不能上交于阳，故谓之阴绝。二者都是阴阳离决之象。《素问》生气通天论说：“阴阳离决，精气乃绝。”故曰“此皆不治，决死也。”若要计其余命生死之期，可以根据月令、季节与阳绝、阴绝相克之期来推断。如肝病死于秋，是依据金克木。余脏皆可仿此。若从阴阳之盛衰与季节的关系来看，阳极死于春夏，阴极死于秋冬，阳竭耐夏不耐冬，阴竭耐冬不耐夏。

〔讨论〕本条精神，旨在说明阴阳亢极无制或衰竭无援者死。分析原文内容，当从此点着眼。而对其生死之期的推断，则是以四时、五脏的五行生克规律为依据，可与上条合参。

〔原文〕脉浮而洪，身汗如油，喘而不休，水浆不下，形体不仁，乍静乍乱，此为命绝也。又未知何藏先受其灾？若汗出发润，喘不休者，此为肺先绝也；阳反独留①，形体如烟熏，直视摇头者，此为心绝也；唇吻②反青，四肢皴习③者，此为肝绝也；环口黧黑④，柔汗发黄⑤者，此为脾绝也；溲便遗失⑥，狂言，目反直视者，此为肾绝也。又未知何藏阴阳前绝⑦？若阳气前绝，阴气后竭者，其人死，身色必青；阴气前绝，阳气后竭者，其人死，身色必赤，腋下温，心下⑧热也。（辨—24）

〔校堪〕《金匱玉函經》：“身汗如油”，作“軀汗如油”；“此为命绝也”，无“也”字；“喘不休者”，作“喘而不休”；“此为肺先绝也”，无“先”及“也”字；“此为心绝也”，无“也”字；“四肢皴习者”，无“者”字；“此为肝绝也”，无“也”字；“柔汗发黄者”，无“者”字；“此为脾绝也”，无“也”字；“狂言”，作“狂语”；“目反直视者”，无“者”字；“此为肾绝也”，无“也”字；“若阳气前绝”，作“阳气先绝”；“阴气后竭者”，无“者”字；“身色必青”，其后有“肉必冷”；“阴气前绝”，作“阴气先绝”；“阳气后竭者”无“者”字。成本：“形体

不仁”，作“体形不仁”；“直视摇头者，此为心绝也”，无“者”及“为”字。

〔词解〕

①阳反独留：阳热独盛。

②唇吻：口唇。

③四肢𦞦习：𦞦习，小鸟学飞而振翅扑打貌。此谓四肢振颤动摇。

④环口黧黑：黧黑，黄黑色。此指环绕口唇周围呈现黄黑之色，为土败之征。

⑤柔汗发黄：汗出柔腻色黄。

⑥溲便遗失：大、小便自遗。

⑦前绝：先绝。

⑧心下：此指心窝部。

〔语译〕脉浮而洪，身体汗出如油，喘息不止，汤水不进，形体不知痛痒，神情忽静忽乱，这是即将死亡的表现。但还不能判知是哪一脏气先绝。如果汗出头发湿润，喘息不止，这是肺气先绝；阳热独盛，形体肤色如烟熏一样，直视摇头，这是心气先绝；口唇反而青紫，四肢振颤动摇，这是肝气先绝；环绕口唇周围呈现黄黑之色，汗出柔腻色黄，这是脾气先绝；大、小便自遗，狂言，眼神反而直视，这是肾气先绝。这还不能判知是哪一脏的阴阳之气先绝。如果阳气先绝，阴气后竭，病人死后，尸体肤色必然发青；阴气先绝，阳气后竭，病人死后，尸体肤色必然红赤，腋下温，心窝部热。

〔提要〕辨命绝脉证。

〔释义〕本条论述了命绝脉证、五脏死候及根据尸体特征辨别阴阳气先绝等内容。脉浮而洪与身汗如油、喘息不休并见是元气亡脱之兆，水浆不下乃胃气败绝之征，形体不仁、乍静乍乱为荣卫离散、神气浮越，一派阴阳离决之象，故谓之命绝。五脏死候，皆为藏真竭绝的表现。肺主气，汗出发润主津脱，喘不休主气脱，表现亡气之象，故谓之肺气绝；心主血，阳反独留乃阳亢火炽，形体如烟熏是荣血不荣，直视摇头为心经气绝，表现亡血之象，故谓之心气先绝；肝藏血，主筋，唇吻反青是肝色外现，四肢挛急是筋急风动，表现精血俱亡之象，故谓之肝气绝；脾主运化，开窍于口，其华在唇，环口黧黑是土色外现，柔汗色黄是脾之真液外泄，表现土败之象，故谓之脾气绝；肾藏精与志，主水，司二便，溲便遗失是肾气不固，狂言是肾不藏志，目反直视是肾精竭绝不能上荣，先天之本亏竭，故谓之肾气绝。关于验死后身色以辨阴阳气之何气先绝，大抵寒证命绝阳气先绝，阴气后竭，所以死后肤色青紫，肤冷；热证命绝阴气先绝，阳气后竭，所以死后肤色红赤，腋下及心窝见温热。综上述，足证仲景丰富的临床经验，可资临床参考。

〔讨论〕脉洪大一般并非死候之脉。此之所以说是命绝脉象，主要是指与身汗如油、喘而不休、水浆不下、形体不仁、乍静乍乱等并见而言。由此推之，其洪大必现浮洪涌盛而散漫无根之象。如王肯堂说：“火之将灭也必明，脉来浮洪涌盛，此将去人体之兆也。”这有力地说明，脉证合参在临床上具有十分重要的意义。

〔附录〕

《伤寒论》脉象及主病表

脉	象	主病
脉	平	即脉转平和，主大邪已去，阴阳调和，津液已复，病已向愈之征（390条）
浮	脉浮	主太阳表证（1，45，71，115，118，120条）；风寒表实麻黄汤证（37，51，175，234，237条）；余热在表证（393条）；邪有外解之势，可与小柴胡汤（234条）；阴证转阳之征（276条）；感邪后阳不足之征（29条）；热越在外（206条）；阳明津伤水热互结（226条）
脉	脉浮紧	主伤寒表实（17，38，46，47，50，55，155，194条）；主阳明里实（206，226条）
类	脉浮缓	主中风表虚（12条）；伤寒表实（39条）；太阳病（192条）；太阴病脾阳复（278条）
	脉浮虚	主表虚，桂枝汤证（242条）

续 1

脉	象	主病
浮脉类	脉浮数	主风寒表实麻黄汤证 (52条)；主热在表 (40, 72条)；余邪在表未尽 (57条)；主邪热盛 (259条)
	脉浮滑	主小结胸 (142条)；热邪充斥表里 (181条)
	脉浮大	主结胸证忌下 (136条)
	脉浮细	主表邪已去，正气尚未全复 (37条)
	脉浮弱	主中风表虚，与“浮缓”同 (42条)
	脉浮而迟	主真寒假热，阴盛格阳 (228条)
	脉浮而芤	主阴不和阳，阳独亢 (248条)
	脉浮而动数	主风邪在表，里无实邪 (138条)
	脉浮虚而涩	主风湿相搏 (179条)
沉脉类	脉沉	主里实 (223条)；主里虚 (94条)；主里 (153条)；主少阴 (301, 305, 323条)
	脉沉紧	主大结胸 (139条)；主太阳转入少阳 (267条)；主里寒 (67条)；主阳微结 (153条)
	脉沉迟	主汗多伤营血，身痛 (62条)；主寒盛于里，戴阳 (365条)
	脉沉实	主余热在里，可下 (393条)
	脉沉结	主瘀热在里，蓄血 (129条)
	脉沉弦	主邪气下迫，里急后重 (364条)

续 2

脉 象		主 病
沉脉类	脉 沉 滑	主协热利 (144条)
	脉 沉 微	主阳虚 (61条)
迟脉类	脉 迟	主邪入里, 热入血室(148条); 主邪在里成实, 腑气不通 (213, 216条); 主胃阳虚, 阳明中寒 (200条); 主脏寒, 中脏阳虚 (333条)
	动数变迟	主阳邪实于里, 腑内拒痛(318条)
	脉迟浮弱	主气血虚弱, 感受风寒, 邪入里而表未解 (100条)
脉 数		主热 (259条); 客热(126条); 阳复或阳气得通, 自愈兆 (360, 366条); 阳复太过(332条)
脉 促		主正气抗邪达表 (22, 34, 144条); 主阳为阴阻 (349条)
弦脉类	脉 弦	主少阳病, 邪热入于肝经 (147条); 主阳明腑实热极津枯, 正气尚存, 犹有生机 (217条)
	脉弦浮大	主三阳合病 (234条)
	脉 弦 迟	主痰实阻于胸, 胸阳被郁, 不能四达 (324条)
	脉 弦 细	主少阳 (200条)
紧脉	脉 紧	主里寒盛 (287条); 邪陷入里(156条); 亦主正气达邪, 向愈之征 (197条)

续 3

脉 象		主 病
紧脉	复紧	主寒邪内阻，病不解（360条）
	脉乍紧	主痰涎阻塞胸中，胸中阳气不能布达四肢（354条）
脉	缓	主中风表虚（2条）
脉	洪大	主大汗出时阳盛于外，桂枝汤证（25条）； 主里热炽盛，阳明经证（26条）
脉	大	主阳明病（191条）；主邪盛，其病为进（364条）
脉	小	主少阳邪气已退，向愈征（271条）
脉	长	主太阴中风正气充实欲愈证（274条）
脉	短	主亡阳谵语气血津液虚竭死候（216条）
滑脉	脉滑	主阳盛，热厥（350条）
	脉滑而疾	主热实而燥结未甚（219条）
	脉滑而数	主有宿食（258条）
脉	实	主里实已成，可下之征（242条）；正虚邪实，胃阳绝真脏脉现（368条）
脉	虚	主亡血伤津（347条）
脉	涩	主气血里虚，正虚邪实（217，219条）； 气血阻滞（48条）
脉	结代	主心阴心阳两虚（182条）

脉 象		主 病
细脉类	脉 弱	主胃气弱 (280条)；里虚寒 (376条)；阴虚津液不足 (116条)；阳明燥热在里 (253条)；邪气已衰，邪去阳回之征 (359条)；表中见浮，主正气能达邪出表 (116条)
	脉 细	主阳微结，血行不畅 (153条)
	脉 细 数	主太阳病下之头痛未止 (144条)
	脉 细 沉 数	主少阴里虚，血不足 (285条)
	脉 细 欲 绝	主血虚受寒，气血运行不利 (351条)
微脉类	脉 微	主阳衰 (23, 286, 315, 338, 343, 384条)
	脉 甚 微	主阳气衰微 (165条)
	脉 暴 微	主正复邪退，为向愈之机 (287条)
	脉 微 欲 绝	主阴液将尽，元阳将亡，真寒假热，或阴盛格阳 (317, 388, 389条)
	脉 微 浮	主病势从阴出阳，为欲愈之征 (327条)
	脉 微 而 沉	主气血壅滞，邪陷于里 (128条)
	脉 微 缓	主邪衰正复，欲愈征 (23条)
	脉 微 数	主阴虚火旺 (119条)
	脉 微 细	主气血虚少，内外俱虚 (60, 281条)
	脉 微 细 沉	主少阴病 (300条)
	脉 微 弱	主正气素虚，卫阳不足 (27条)；主里虚 (38条)；正为邪阻 (143条)

脉 象		主 病
微脉类	脉微弱数	主邪气已衰,正气渐复,欲愈之兆 (364条)
	脉微涩	主气血少 (325条); 吐下后津液大伤,血行不畅 (383条)
	脉微厥	主里虚寒下利 (108条)
三部九候脉	寸口脉浮而紧	主肝乘脾 (111条)
	寸口脉浮而大	主阴阳不足,复感外邪 (30条)
	寸脉微浮	主病在上焦 (171条)
	寸脉沉而迟	主下后津伤,阳气内陷 (356条)
	脉关上浮	主无形热邪聚于心下 (169条)
	关上脉细数	主误吐伤中,气血受伤 (124条)
	脉浮大,上关上	主三阳合病 (268条)
	尺中迟	主荣气不足,血少,忌汗 (50条)
	尺中脉微	主里阳不足,禁汗 (49条)
候脉	尺脉弱涩	主阳虚阴血不足,忌下 (286条)
	寸脉浮关脉沉	主结胸 (132条)
	寸脉浮关脉小细沉紧	主脏结 (132条)
	寸脉反浮数尺中自涩	主里热炽盛,热伤阴亡 (362条)
	寸缓关浮尺弱	主太阳中风误下致心下痞 (246条)
脉	脉阴阳俱紧	主太阳伤寒表实 (3条); 寒邪直中少阴 (283条)

脉 象		主 病
三部九候脉	脉阴阳俱浮	主风温，热邪充斥内外（6条）
	脉阴阳俱停	主正邪交争，正气一时之虚，气血被阻，经脉不利，为战汗之征（96条）
	阳浮而阴弱	主太阳中风表虚（12条）
	脉阳弱阴浮	主邪不盛，正不虚，有抗邪外达之势，为少阴中风欲愈之征（290条）
	脉阳微阴涩而长	主邪气不盛，正气充实，为太阴中风欲愈之征（274条）
	阳脉涩阴脉弦	主少阳里虚，腹中急痛（102条）
	趺阳脉浮而涩	主脾约（249条）
	少阴负趺阳	主厥利胃气未绝，尚可救治，故云“顺”（361条）
脉 不 至		主吐利交作，正气暴虚，脉气一时不能接续（292条）；真阳败绝，有阴无阳（298条）
下部脉不至（尺脉）		主气虚于下（356条）
无 脉		主阴寒一时充斥，阳气将绝（361条）；阴阳之气上下不能交接（315条）
脉 绝		主津液骤然大泄，阳气乍脱，脉一时隐伏不现（367条）
脉 还		主阳气能自然恢复（367条）
脉 不 还		主正气不复，阳气已脱，危殆（361，367条）
脉 暴 出		主无根之阳暴露（315条）
脉 微 续		主微阳渐复（315条）

注，96条“但阳脉微”、“但阴脉微”，及144条所论脉证临床少见，以存疑而未列入。脉“微厥”，亦有解释为“脉微”而“肢厥”。